

Bunga Rampai **PENGALAMAN PRAKTIK DAN PEMBELAJARAN TENAGA KESEHATAN** DALAM PELAYANAN KESEHATAN



Halimatussakdiah • Lani Nurlita • Annisa Ridlayanti
Anita Setyowati • Yeni Fitrianingsih

Editor : Yosephina Maria Hawa Keytimu

BUNGA RAMPAI: PENGALAMAN PRAKTIK DAN PEMBELAJARAN TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Penulis:

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp.M.Kep., Sp.Mat.

Lani Nurlita, S.Tr.,M.Tr.Keb.

Annisa Ridlayanti, S.Keb.,Bd.,M.Keb.

Anita Setyowati, S.Tr.Kep., M.Tr.Ke.

Dr. Yeni Fitriyaningsih, SST, MKes.

Editor:

Yosephina Maria Hawa Keytimu, S. Kep., Ns., M.P.H



Bunga Rampai: Pengalaman Praktik dan Pembelajaran Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan

Penulis:

Dr. Halimatussakdiah, S.Kp.M.Kep., Sp.Mat.

Lani Nurlita, S.Tr.,M.Tr.Keb.

Annisa Ridlayanti, S.Keb.,Bd.,M.Keb.

Anita Setyowati, S.Tr.Kep., M.Tr.Ke.

Dr. Yeni Fitrianiingsih, SST, MKes.

Editor:

Yosephina Maria Hawa Keytimu, S. Kep., Ns., M.P.H

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7556-77-6

Cetakan Pertama: Maret, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga bunga rampai "Pengalaman Praktik dan Pembelajaran Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan" ini dapat tersusun dengan baik. Buku ini merupakan kumpulan pengalaman, refleksi, dan pembelajaran dari praktik nyata tenaga kesehatan dalam berbagai setting pelayanan.

Lima Chapter dalam buku ini membahas pengalaman praktik tenaga kesehatan, pembelajaran dari praktik kebidanan, pengalaman praktik gizi, refleksi etika dan profesionalisme, serta implikasi pengalaman praktik terhadap pengembangan pendidikan kesehatan. Setiap bagian menghadirkan gambaran nyata dinamika pelayanan sekaligus pembelajaran yang bermakna bagi peningkatan mutu layanan dan pendidikan kesehatan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi tenaga kesehatan, pendidik, dan mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang

Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 PENGALAMAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN..... 1

(Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat).....	1
A. Pendahuluan	1
B. Tujuan Penulisan Buku	2
C. Peran dan Realitas Praktik Tenaga Kesehatan di Sistem Kesehatan Indonesia.....	3
D. Tantangan Nyata Tenaga Kesehatan di Lapangan (Isu Aktual).....	4
E. Pengalaman Tenaga Kesehatan dalam Situasi Krisis dan Bencana.....	7
F. Transformasi Praktik Pelayanan: Digitalisasi dan Inovasi Teknologi	9
G. Pengalaman Praktik Interprofessional Collaboration (IPC).....	11
H. Praktik Mandiri dan Kewirausahaan Tenaga Kesehatan	13
I. Hambatan Memperoleh Tenaga Kesehatan Yang Berpengalaman	15
J. Simpulan	16
K. Referensi.....	17

BAB 2 PEMBELAJARAN DARI PRAKTIK KEBIDANAN DI LAYANAN KESEHATAN 21

(Lani Nurlita, M.Tr.Keb)	21
A. Pendahuluan	21
B. Konsep Dasar Pembelajaran Praktik Kebidanan	22
C. Landasan Pembelajaran Praktik Kebidanan di Layanan Kesehatan	24
D. Tujuan dan Capaian Pembelajaran Praktik Kebidanan.....	26
E. Layanan Kesehatan sebagai Wahana Pembelajaran Praktik	28
F. Model dan Metode Pembelajaran Praktik Kebidanan.....	29
G. Peran dan Tanggung Jawab dalam Pembelajaran Praktik Kebidanan...	31
H. Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Praktik Kebidanan	33
I. Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran Praktik Kebidanan.....	35
J. Tantangan dan Strategi Penguatan Pembelajaran Praktik Kebidanan..	37
K. Implikasi Pembelajaran Praktik Kebidanan terhadap Kompetensi Lulusan	39
L. Simpulan	41
M. Referensi.....	41
N. Glosarium.....	42

BAB 3 PENGALAMAN PRAKTIK GIZI DALAM PELAYANAN KESEHATAN..... 44

(Annisa Ridlayanti, S.Keb.,Bd.,M.Keb) 44

A. Pendahuluan	44
B. Peran Tenaga Gizi dalam Pelayanan Kesehatan	45
C. Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) di Fasilitas Kesehatan	45
D. Pengalaman Praktik Gizi di Pelayanan Rawat Jalan.....	45
E. Pengalaman Praktik Gizi di Pelayanan Rawat Inap	46
F. Praktik Gizi Masyarakat di Puskesmas dan Komunitas	46
G. Edukasi dan Konseling Gizi dalam Pelayanan Kesehatan.....	46
H. Tantangan dan Hambatan dalam Praktik Gizi Pelayanan Kesehatan.....	47
I. Penerapan Evidence-Based Nutrition Practice.....	47
J. Pengalaman Praktik Gizi dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	48
K. Refleksi Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi Profesional ...	49
L. Simpulan	50
M. Referensi.....	50
N. Glosarium.....	52

BAB 4 REFELKSI ETIKA DAN REFLEKSI ETIKA DAN PROFESIONALISME DALAM PRAKTIK KESEHATAN..... 53

(Anita Setyowati, M.Tr.Kep)..... 53

A. Pendahuluan	53
B. Konsep Dasar Etika dalam Praktik Kesehatan.....	54
C. Profesionalisme dalam Pelayanan Kesehatan.....	58
D. Dilema Etika dan Pengambilan Keputusan Klinis	59
E. Refleksi Praktik dan Pengembangan Karakter Profesional	61
F. Membangun Budaya Etis dalam Organisasi Pelayanan Kesehatan	65
G. Simpulan	68
H. Referensi.....	68

BAB 5 IMPLIKASI PENGALAMAN PRAKTIK TERHADAP PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESEHATAN 71

(Dr.Yeni Fitrianingsih,SST,MKes)..... 71

A. Pendahuluan.....	71
B. Transformasi Kurikulum Berbasis Real-World Evidence dan Fenomena Klinis.....	73
C. Refleksi Praktis Berbasis Teknologi Digital dalam Pendidikan Kesehatan	75
D. Sinergi Interprofessional Collaboration (IPC) dalam Praktik dan Pendidikan	76
E. Simpulan	78
F. Referensi.....	79

PROFIL PENULIS	81
-----------------------------	-----------

CHAPTER 1

PENGALAMAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

(Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat)

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan sistem yang kompleks dan dinamis, yang menuntut tenaga kesehatan tidak hanya memiliki kompetensi klinis, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan. Dalam konteks negara Indonesia, tenaga kesehatan berada di garis depan pelayanan, baik di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, rujukan, maupun pelayanan berbasis komunitas. Pengalaman praktik tenaga kesehatan menjadi bagian penting dalam menggambarkan realitas pelayanan kesehatan, karena di dalamnya tercermin tantangan, inovasi, serta strategi yang dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Lestari et al., 2025).

Seiring dengan perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi digital kesehatan, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, praktik tenaga kesehatan mengalami transformasi yang signifikan. Tenaga kesehatan dihadapkan pada berbagai situasi kompleks, mulai dari keterbatasan sumber daya, beban kerja tinggi, hingga kebutuhan kolaborasi interprofesional yang semakin kuat. Selain itu, pengalaman menghadapi situasi krisis bencana seperti pandemi, bencana alam, dan masalah kesehatan masyarakat lainnya memberikan pembelajaran penting dalam meningkatkan ketahanan sistem kesehatan dan profesionalisme tenaga Kesehatan (Solon et al., 2021).

Bab ini disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta didik keperawatan mengenai gambaran nyata praktik tenaga kesehatan di lapangan. Melalui pembahasan pengalaman praktik, diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan teori dengan praktik nyata, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta menumbuhkan sikap profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, bab ini tidak hanya menjadi sumber pengetahuan, tetapi juga menjadi refleksi pembelajaran bagi calon tenaga kesehatan dalam menghadapi tantangan pelayanan kesehatan di masa kini dan masa depan.

B. Tujuan Penulisan Buku

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, serta tuntutan mutu pelayanan kesehatan yang semakin tinggi menuntut tenaga kesehatan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan sistem pelayanan. Oleh karena itu, dokumentasi pengalaman praktik tenaga kesehatan menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga bagi dunia pendidikan kesehatan. Melalui pembelajaran berbasis pengalaman praktik, diharapkan terjadi integrasi antara teori akademik dengan realitas pelayanan kesehatan, sehingga mampu meningkatkan kualitas lulusan tenaga kesehatan yang siap kerja dan profesional.

Buku ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pengalaman praktik tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan, termasuk tantangan, strategi adaptasi, serta pembelajaran yang dapat diambil untuk pengembangan pendidikan tenaga kesehatan. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, maupun institusi pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa

Tujuan penulisan buku ini bagi mahasiswa adalah untuk memberikan gambaran nyata mengenai praktik pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di lapangan. Mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana teori yang dipelajari di bangku kuliah diterapkan dalam situasi klinis yang kompleks, termasuk aspek komunikasi, kolaborasi tim, pengambilan keputusan klinis, serta etika profesi. Selain itu, bab ini bertujuan menumbuhkan kesiapan mental, keterampilan profesional, dan sikap reflektif mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja pelayanan kesehatan.

2. Bagi Dosen

Bagi dosen, buku ini bertujuan menjadi sumber referensi pembelajaran berbasis pengalaman praktik nyata (*evidence and experience based-learning*). Materi ini dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, serta sebagai bahan diskusi kasus klinis. Selain itu, bab ini khususnya atau bab lain umumnya diharapkan dapat membantu dosen dalam mengintegrasikan teori, praktik, serta perkembangan isu pelayanan kesehatan terkini dalam proses pendidikan tenaga kesehatan.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Bagi institusi pendidikan, tujuan penulisannya adalah sebagai bahan penguatan mutu pendidikan tenaga kesehatan melalui penyediaan referensi yang relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan saat ini. Selain itu, dapat menjadi dasar dalam evaluasi kurikulum, pengembangan model pembelajaran praktik

klินิก, serta peningkatan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Dengan demikian, institusi diharapkan mampu menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi tantangan pelayanan kesehatan modern.

C. Peran dan Realitas Praktik Tenaga Kesehatan di Sistem Kesehatan Indonesia

Peran tenaga kesehatan di Indonesia mengalami evolusi yang signifikan seiring perubahan paradigma sistem kesehatan global dan nasional. Awalnya pelayanan kesehatan berfokus pada tindakan kuratif di fasilitas kesehatan, namun saat ini berkembang menjadi pelayanan promotif, preventif, serta berbasis komunitas (Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, 2025). Pergeseran ini menuntut tenaga kesehatan memiliki kompetensi multidimensi yang meliputi keterampilan klinis, komunikasi, edukasi kesehatan, serta kemampuan kolaborasi interprofesional. Standar profesi disusun untuk memastikan tenaga kesehatan memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang terukur sehingga mutu pelayanan kesehatan tetap terjaga (Qelina & Reswara, 2025).

Realitasnya, sistem kesehatan Indonesia, tenaga kesehatan merupakan komponen utama yang menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan adalah individu yang mengabdikan diri pada bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan serta keterampilan melalui pendidikan kesehatan formal. Sedangkan pendidikan tinggi kesehatan memiliki tanggung jawab mempersiapkan tenaga kesehatan profesional yang mampu bekerja sesuai kebutuhan sistem kesehatan nasional. Hal ini menegaskan bahwa kualitas pendidikan tenaga kesehatan sangat berpengaruh terhadap mutu layanan kesehatan di masyarakat (Ramdani et al., 2026).

Perawat memiliki posisi integral dalam pelayanan kesehatan profesional karena berperan langsung dalam pemberian asuhan keperawatan, pemantauan kondisi pasien, serta edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga. Standar kompetensi perawat dikembangkan untuk menjamin bahwa praktik keperawatan berjalan aman, efektif, dan sesuai standar profesi. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan klinis, keterampilan interpersonal, serta kemampuan pengambilan keputusan dalam situasi klinis. Penerapan standar ini juga bertujuan melindungi keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan (Lu, 2022).

Dalam praktik profesional, tenaga kesehatan wajib menjalankan pelayanan sesuai standar kompetensi nasional dan standar profesi yang ditetapkan pemerintah dan organisasi profesi. Standar profesi mencakup standar kompetensi, kode etik, serta standar praktik profesional yang menjadi pedoman dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Standar tersebut tidak hanya menjadi acuan bagi tenaga

kesehatan, tetapi juga bagi institusi pendidikan, pemerintah, dan organisasi profesi dalam menjaga mutu pelayanan kesehatan nasional (Fachrurrozi, 2023).

Selain kompetensi teknis, praktik tenaga kesehatan harus dilandasi etika profesi dan kompetensi moral. Penelitian internasional menunjukkan bahwa kompetensi moral perawat berperan penting dalam pengambilan keputusan klinis, kualitas pelayanan, serta hubungan profesional dengan pasien. Penguatan kompetensi moral perlu dilakukan melalui pendidikan, pelatihan profesional, serta dukungan organisasi agar tenaga kesehatan mampu menghadapi dilema etika dalam praktik klinis modern (Jiwa et al., 2024).

Dari aspek regulasi, praktik tenaga kesehatan di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang dan kebijakan kesehatan nasional. Regulasi tersebut mengatur kualifikasi pendidikan, kewenangan praktik, serta sistem sertifikasi tenaga kesehatan. Undang-undang kesehatan terbaru juga menekankan penguatan tata kelola profesi kesehatan, standar kompetensi, serta penjaminan mutu praktik tenaga kesehatan sebagai bagian dari reformasi sistem kesehatan nasional (Ismiyah et al., 2024).

D. Tantangan Nyata Tenaga Kesehatan di Lapangan (Isu Aktual)

Dalam pelaksanaan praktik di lapangan, terdapat kemungkinan munculnya berbagai tantangan atau ketidaksesuaian antara kondisi faktual dan tujuan yang diharapkan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan, sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Ketimpangan Distribusi Tenaga Kesehatan Kota vs Daerah Terpencil

Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan masih menjadi masalah utama dalam sistem kesehatan Indonesia. Sebagian besar dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya terkonsentrasi di wilayah perkotaan, khususnya Pulau Jawa dan kota-kota besar. Hal ini menyebabkan daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan mengalami kekurangan tenaga kesehatan sehingga berdampak pada keterlambatan pelayanan, keterbatasan layanan spesialisik, serta meningkatnya angka kesakitan dan kematian yang seharusnya dapat dicegah. Ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sarana prasarana, serta kesempatan pengembangan karier yang lebih banyak tersedia di perkotaan (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Selain faktor geografis, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan juga dipengaruhi oleh sistem rekrutmen dan retensi tenaga kesehatan di daerah. Banyak tenaga kesehatan yang ditempatkan di daerah terpencil hanya dalam jangka waktu terbatas, kemudian kembali ke daerah asal atau pindah ke wilayah dengan fasilitas lebih baik. Kurangnya insentif finansial, keterbatasan fasilitas

pendidikan bagi keluarga tenaga kesehatan, serta minimnya akses transportasi menjadi faktor yang mempercepat perpindahan tenaga kesehatan dari daerah terpencil ke kota (Ramandini, 2024).

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan, seperti program Nusantara Sehat, Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), dan pemberian insentif khusus bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil. Namun, keberhasilan program ini masih membutuhkan penguatan sistem monitoring, peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, serta dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan lingkungan kerja yang kondusif dan aman (Octaviani et al., 2024).

2. Keterbatasan Fasilitas, Pelatihan, dan Akses *Guideline*

Keterbatasan fasilitas kesehatan di lapangan masih menjadi tantangan signifikan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan optimal. Banyak fasilitas kesehatan primer di daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan alat medis, obat-obatan esensial, serta sarana penunjang diagnostik. Kondisi ini menyebabkan tenaga kesehatan harus mengambil keputusan klinis dengan keterbatasan sumber daya, yang berpotensi meningkatkan risiko kesalahan diagnosis dan keterlambatan penanganan pasien (Fahriyyan et al., 2025).

Selain keterbatasan fasilitas fisik, akses terhadap pelatihan berkelanjutan dan *guideline* klinis terbaru juga masih belum merata. Tenaga kesehatan di daerah terpencil sering mengalami kesulitan mengikuti pelatihan karena keterbatasan akses internet, biaya perjalanan, serta keterbatasan waktu akibat beban kerja tinggi. Hal ini dapat berdampak pada kesenjangan kompetensi antara tenaga kesehatan di kota dan daerah, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi kesehatan dan terapi terbaru.

Untuk mengatasi hal ini, pengembangan sistem pembelajaran berbasis digital, *telemedicine*, serta distribusi *guideline* nasional secara elektronik menjadi solusi strategis. Implementasi sistem ini perlu didukung oleh peningkatan infrastruktur digital, pelatihan penggunaan teknologi, serta kebijakan nasional yang memastikan seluruh tenaga kesehatan memiliki akses yang sama terhadap informasi ilmiah terkini (Budiyanti et al., 2019).

3. Beban Kerja Tinggi dan Burnout Tenaga Kesehatan

Beban kerja tenaga kesehatan yang tinggi merupakan masalah global yang semakin meningkat sejak pandemi COVID-19. Tenaga kesehatan sering menghadapi jam kerja panjang, jumlah pasien yang banyak, serta tuntutan administratif yang kompleks (Hakim, 2020). Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang berujung pada burnout, yang ditandai dengan

kelelahan emosional, penurunan motivasi kerja, dan berkurangnya kualitas pelayanan kepada pasien (Sugiat et al., 2023).

Burnout pada tenaga kesehatan juga berdampak pada keselamatan pasien dan stabilitas sistem kesehatan. Tenaga kesehatan yang mengalami burnout cenderung memiliki risiko lebih tinggi melakukan kesalahan medis, mengalami depresi, serta memiliki keinginan untuk meninggalkan profesinya. Studi global menunjukkan bahwa prevalensi burnout pada tenaga kesehatan, khususnya perawat dan dokter, cukup tinggi terutama di fasilitas kesehatan dengan beban pelayanan yang besar (Bodenheimer et al., 2025).

Upaya pencegahan burnout memerlukan pendekatan sistemik, termasuk pengaturan beban kerja yang proporsional, dukungan kesehatan mental tenaga kesehatan, serta peningkatan jumlah tenaga kesehatan. Selain itu, kepemimpinan organisasi yang suportif dan budaya kerja yang sehat juga menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan tenaga kesehatan secara berkelanjutan juga memberikan andil terhadap penyelesaian masalah tersebut

4. Tantangan Komunikasi dan Kepercayaan Masyarakat

Komunikasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelayanan kesehatan. Di beberapa wilayah, perbedaan bahasa, budaya, dan tingkat pendidikan masyarakat dapat menjadi hambatan dalam penyampaian informasi kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap diagnosis, pengobatan, maupun upaya pencegahan penyakit (Pamungkas et al., 2025).

Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan dan sistem kesehatan juga dipengaruhi oleh pengalaman pelayanan sebelumnya, informasi yang beredar di media sosial, serta kepercayaan budaya lokal. Misinformasi kesehatan yang berkembang di masyarakat dapat menyebabkan penolakan terhadap intervensi kesehatan, seperti imunisasi, pengobatan medis, maupun program kesehatan masyarakat lainnya (Fitriani & Yuliani, 2025).

Peningkatan komunikasi efektif berbasis budaya lokal, pemberdayaan kader kesehatan, serta pendekatan komunitas menjadi strategi penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kolaborasi antara tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan pemimpin agama juga terbukti efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Irfan Sazali Nasution et al., 2024).

E. Pengalaman Tenaga Kesehatan dalam Situasi Krisis dan Bencana

Pengalaman tenaga kesehatan dalam situasi krisis dan bencana merupakan bagian penting dalam memahami kesiapsiagaan sistem pelayanan kesehatan terhadap kondisi darurat. Dalam situasi seperti bencana alam, wabah penyakit, maupun konflik kemanusiaan, tenaga kesehatan dituntut mampu bekerja secara cepat, tepat, dan adaptif di tengah keterbatasan sumber daya. Saat bencana dibutuhkan pentingnya kompetensi klinis, manajemen krisis, serta ketahanan mental bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan yang optimal dan berkelanjutan kepada masyarakat terdampak. Berikut ini beberapa gambaran pengalaman yang terjadi saat situasi krisis dan bencana.

1. Pengalaman Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 menjadi pengalaman krisis kesehatan terbesar dalam beberapa dekade terakhir yang sangat memengaruhi praktik tenaga kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tenaga kesehatan berada di garis depan pelayanan dengan risiko paparan infeksi tinggi, keterbatasan alat pelindung diri pada fase awal pandemi, serta tekanan kerja yang meningkat drastis akibat lonjakan pasien. Kondisi ini menyebabkan perubahan besar dalam sistem pelayanan kesehatan, termasuk penyesuaian alur triase, manajemen pasien infeksius, serta penggunaan teknologi digital dalam pelayanan. Studi global menunjukkan pandemi memaksa sistem kesehatan beradaptasi cepat untuk menjaga keselamatan pasien dan tenaga kesehatan (Simamora, 2021).

Secara psikologis, pandemi memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan. Penelitian menunjukkan pandemi meningkatkan risiko kelelahan emosional, serta depersonalisasi akibat beban kerja dan tekanan emosional yang tinggi. Meta-analisis internasional menunjukkan adanya peningkatan kejadian burnout pada tenaga kesehatan selama pandemi, sehingga diperlukan intervensi organisasi dan sistem kesehatan untuk mendukung kesejahteraan tenaga kesehatan (Yuliani & Ak, 2019).

Selain itu, pandemi juga meninggalkan dampak jangka panjang terhadap persepsi profesi tenaga kesehatan. Beberapa laporan menunjukkan tenaga kesehatan mengalami disilusi akibat ketidakseimbangan antara pengorbanan saat pandemi dan perbaikan sistem kesehatan setelah pandemi. Hal ini berkontribusi terhadap penurunan kepuasan kerja, peningkatan niat keluar dari profesi, serta masalah kesehatan mental pasca krisis (Reinhart et al., 2024).

2. Adaptasi Praktik Klinis Saat Krisis

Situasi krisis menuntut tenaga kesehatan melakukan adaptasi praktik klinis secara cepat dan inovatif. Selama pandemi COVID-19, banyak fasilitas kesehatan menerapkan *telemedicine*, triase berbasis risiko infeksi, serta penggunaan

teknologi untuk meminimalkan kontak langsung antara pasien dan tenaga kesehatan. Inovasi teknologi seperti tele-operatif ultrasonografi paru bahkan dikembangkan untuk mendukung diagnosis tanpa meningkatkan risiko penularan (Sundoro et al., 2025).

Selain adaptasi teknologi, tenaga kesehatan juga harus menyesuaikan standar pelayanan dengan keterbatasan sumber daya. Krisis global COVID-19 menunjukkan bahwa manajemen logistik, khususnya alat pelindung diri, menjadi faktor krusial dalam menjaga keselamatan tenaga kesehatan. Penelitian menunjukkan manajemen stok menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan sistem kesehatan menghadapi krisis (Ramandini, 2024).

Adaptasi praktik juga mencakup perubahan dalam pengambilan keputusan klinis berbasis bukti yang terus berkembang. Dalam situasi pandemi, banyak penelitian klinis menggunakan desain adaptif untuk mempercepat penemuan terapi efektif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik klinis dalam krisis membutuhkan fleksibilitas tinggi tanpa mengurangi validitas ilmiah dan keselamatan pasien (Ashidiqi & Shariff, 2025).

3. Dilema Etik dan Tekanan Kerja

Krisis kesehatan sering menimbulkan dilema etik kompleks bagi tenaga kesehatan, terutama ketika sumber daya terbatas. Pada pandemi COVID-19, tenaga kesehatan sering dihadapkan pada keputusan prioritas pasien, keterbatasan ventilator, serta konflik antara keselamatan diri dan kewajiban profesional (Susilowati & Hakiem, 2020). Studi menunjukkan sebagian besar tenaga kesehatan mengalami moral distress akibat konflik antara nilai etika profesional dan kondisi nyata di lapangan (Gustina et al., 2020).

Tekanan kerja yang tinggi selama krisis juga meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental tenaga kesehatan. Banyak tenaga kesehatan mengalami kelelahan emosional, depresi, bahkan keinginan meninggalkan profesi akibat tekanan kerja ekstrem dan pengalaman traumatis selama pandemi. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa paparan kematian massal, beban kerja berlebih, dan kurangnya dukungan sistem dapat memperburuk kondisi psikologis tenaga Kesehatan (Ridlo, 2023).

Selain itu, dilema etik juga muncul dalam konteks tanggung jawab profesional dan keselamatan pribadi. Situasi "*all hands on deck*" selama pandemi menimbulkan perdebatan etik tentang kewajiban tenaga kesehatan untuk tetap bekerja dalam kondisi berisiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa krisis kesehatan memerlukan penguatan sistem etika klinis, dukungan psikososial, serta kebijakan perlindungan tenaga Kesehatan.

F. Transformasi Praktik Pelayanan: Digitalisasi dan Inovasi Teknologi

Transformasi praktik pelayanan kesehatan melalui digitalisasi dan inovasi teknologi menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan mutu, efisiensi, dan akses layanan kesehatan di era modern. Pemanfaatan rekam medis elektronik, *telemedicine*, serta sistem informasi kesehatan terintegrasi membantu tenaga kesehatan dalam pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat dan akurat. Penerapan teknologi digital untuk mendukung sistem pelayanan kesehatan yang lebih responsif, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat sangat mendukung Tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Berikut beberapa alat digital dan inovasi teknologi.

1. Rekam Medis Elektronik dan Digital Nursing Documentation

Transformasi pelayanan kesehatan melalui rekam medis elektronik (*electronic medical record/EMR*) telah menjadi fondasi penting dalam peningkatan mutu layanan kesehatan modern. Sistem EMR memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan akses data pasien secara terintegrasi sehingga mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat dan akurat. Implementasi EMR juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi manajemen rumah sakit serta kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan melalui integrasi sistem informasi Kesehatan (Rosyid, 2023).

Digital nursing documentation merupakan bagian dari transformasi EMR yang secara khusus mendukung praktik keperawatan berbasis bukti. Dokumentasi digital memudahkan koordinasi antar tenaga kesehatan, meningkatkan keselamatan pasien, serta menurunkan risiko kesalahan dokumentasi manual. Selain itu, teknologi digital kesehatan terbukti mampu meningkatkan kepuasan tenaga kesehatan serta efisiensi waktu kerja melalui optimalisasi alur kerja klinis (Halimatussakdiah et al., 2022).

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi rekam medis elektronik juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, resistensi tenaga kesehatan, serta kebutuhan pelatihan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan sistem digital kesehatan harus mempertimbangkan kebutuhan tenaga kesehatan agar adopsinya optimal dan berkelanjutan dalam sistem pelayanan Kesehatan

Perkembangan EMR juga membuka peluang integrasi teknologi lain seperti big data dan sistem pendukung keputusan klinis. Integrasi ini berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan melalui analisis data kesehatan populasi, pemantauan penyakit, dan perencanaan pelayanan kesehatan berbasis data. Namun, keberhasilan implementasi tetap memerlukan kesiapan sumber daya

manusia dan kebijakan kesehatan yang mendukung pelaksanaan dan monitoring penggunaan EMR tersebut.

2. *Artificial Intelligence* (AI) dalam Pelayanan Kesehatan

Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu inovasi teknologi yang paling cepat berkembang dalam pelayanan kesehatan modern. AI mampu membantu analisis data klinis kompleks, meningkatkan akurasi diagnosis, serta mendukung pengambilan keputusan klinis melalui teknologi seperti machine learning dan natural language processing. Penggunaan AI berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan dan outcome pasien secara signifikan (Yusuf et al., 2024).

Dalam praktik keperawatan, AI juga berperan dalam meningkatkan efisiensi manajemen pelayanan, komunikasi tim kesehatan, serta optimalisasi penggunaan sumber daya. Teknologi AI dapat membantu perawat dalam pemantauan pasien, prediksi risiko klinis, serta manajemen beban kerja berbasis data. Hal ini menunjukkan bahwa AI bukan menggantikan tenaga kesehatan, tetapi mendukung kinerja profesional mereka (Purísima et al., 2024).

Namun, penerapan AI juga menghadirkan tantangan seperti potensi bias algoritma, kesenjangan data, serta isu etika penggunaan teknologi. Bias dalam sistem AI dapat memperburuk kesenjangan pelayanan kesehatan jika tidak dikembangkan dengan data yang representatif dan regulasi yang kuat. Oleh karena itu, pengembangan AI harus memperhatikan aspek keadilan dan transparansi (Gray et al., 2022).

Selain itu, penggunaan AI dalam praktik klinis juga menimbulkan tantangan hukum dan keselamatan pasien. Beberapa laporan menunjukkan adanya risiko kesalahan pada perangkat medis berbasis AI, sehingga diperlukan pengawasan regulasi dan evaluasi teknologi secara ketat sebelum digunakan secara luas dalam pelayanan Kesehatan.

3. Tantangan Literasi Digital Tenaga Kesehatan

Literasi digital menjadi kompetensi penting bagi tenaga kesehatan di era transformasi digital. Tenaga kesehatan dituntut mampu menggunakan teknologi digital, mengelola data kesehatan, serta memahami sistem informasi kesehatan secara efektif. Peningkatan literasi digital terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan, akses layanan kesehatan, dan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan (Alethea & Verlag, 2008). Namun, masih terdapat kesenjangan literasi digital di kalangan tenaga kesehatan, terutama terkait pemahaman teknologi baru, pelatihan, serta kesiapan sistem pendukung. Hambatan lain meliputi keterbatasan infrastruktur, kekhawatiran peningkatan beban kerja, dan resistensi terhadap perubahan teknologi dalam praktik klinis sehari-hari (Rosyid, 2023).

Literasi digital juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi AI dan teknologi digital kesehatan lainnya. Tenaga kesehatan perlu memiliki kompetensi dalam memahami cara kerja teknologi, interpretasi data digital, serta penggunaan teknologi secara etis dan aman dalam pelayanan pasien. Harapannya, penguatan literasi digital harus menjadi bagian dari pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan berkelanjutan. Integrasi kompetensi digital dalam pendidikan kesehatan akan membantu tenaga kesehatan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di era digital (Rigo et al., 2025).

G. Pengalaman Praktik Interprofessional Collaboration (IPC)

Interprofessional Collaboration (IPC) merupakan pendekatan penting dalam praktik pelayanan kesehatan yang menekankan kerja sama efektif antar tenaga kesehatan dari berbagai profesi untuk mencapai keselamatan dan kualitas pelayanan pasien yang optimal. Dalam praktiknya, IPC menuntut komunikasi yang terbuka, saling menghargai peran profesi, serta pengambilan keputusan bersama berbasis kebutuhan pasien. Kolaborasi lintas profesi merupakan aspek penting dalam pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien dan keberlanjutan sistem kesehatan. Dibawah ini beberapa bentuk gambaran IPC yang dianjurkan saat melakukan tindakan kepada pasien di pelayanan Kesehatan.

1. Kolaborasi dokter–perawat–tenaga kesehatan lain

Interprofessional Collaboration (IPC) merupakan bentuk kerja sama antara tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk mencapai pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berorientasi pada pasien. Dalam praktik klinis modern, IPC menjadi kunci untuk meningkatkan mutu pelayanan, efektivitas terapi, serta keselamatan pasien. Kolaborasi ini menekankan pembagian peran profesional, komunikasi terbuka, dan pengambilan keputusan bersama dalam tim Kesehatan (Manurung et al., 2023).

Dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, kolaborasi antara dokter, perawat, bidan, farmasi, dan profesi kesehatan lain semakin dibutuhkan seiring meningkatnya kompleksitas kasus penyakit. Studi menunjukkan bahwa praktik kolaboratif dapat meningkatkan kepuasan pasien, mempercepat proses penyembuhan, dan menurunkan risiko kesalahan medis melalui koordinasi pelayanan yang lebih baik.

Perawat memiliki peran strategis dalam IPC karena berada paling dekat dengan pasien selama 24 jam pelayanan. Pada situasi pandemi COVID-19 misalnya, perawat menjadi koordinator penting dalam komunikasi antar profesi dan memastikan kesinambungan asuhan pasien melalui koordinasi klinis yang

intensif. Selain itu, penerapan IPC juga dipengaruhi oleh kepemimpinan organisasi dan budaya kerja rumah sakit. Kepemimpinan yang mendukung kolaborasi terbukti dapat menciptakan lingkungan kerja yang sinergis, memperkuat *patient-centered care*, serta meningkatkan kualitas luaran pelayanan Kesehatan (Lu, 2022).

2. Hambatan komunikasi tim

Meskipun penting, implementasi IPC masih menghadapi berbagai hambatan, terutama pada aspek komunikasi antar tenaga kesehatan. Perbedaan latar belakang pendidikan, budaya profesi, dan persepsi peran sering menyebabkan miskomunikasi dalam tim pelayanan kesehatan. Hal tersebut dapat diatasi dengan kebijakan pimpinan untuk mendukung IPC (Noviyanti et al., 2023).

Komunikasi yang tidak efektif dapat memengaruhi kualitas pelayanan dan keselamatan pasien. Oleh karena itu, kompetensi komunikasi interprofesional menjadi aspek penting yang harus dimiliki tenaga kesehatan untuk meningkatkan koordinasi pelayanan dan kualitas layanan rumah sakit. Selain faktor individu, hambatan komunikasi juga dipengaruhi oleh sistem organisasi seperti struktur hierarki yang kaku, beban kerja tinggi, dan kurangnya pelatihan komunikasi tim. Faktor-faktor tersebut dapat menurunkan efektivitas kerja sama tim Kesehatan (Ummah et al., 2025).

Di beberapa fasilitas kesehatan Indonesia, implementasi IPC belum optimal karena keterbatasan dukungan manajemen, sistem kerja, dan kebijakan organisasi. Kondisi ini menunjukkan pentingnya intervensi sistemik dalam memperkuat komunikasi tim kesehatan.

3. Dampak IPC terhadap keselamatan pasien

IPC memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan keselamatan pasien karena memungkinkan identifikasi risiko secara kolektif dan pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat. Keselamatan pasien merupakan sistem yang mencakup identifikasi risiko, pelaporan insiden, dan pembelajaran dari kesalahan medis untuk mencegah kejadian berulang. Kolaborasi antar profesi juga memungkinkan pelayanan yang lebih holistik, sehingga kebutuhan pasien dapat dipenuhi secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi perawatan, dan kepuasan pasien terhadap layanan Kesehatan (Elungan et al., 2025).

Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi efektif dapat menurunkan risiko kesalahan medis melalui koordinasi pengobatan, validasi tindakan klinis, dan komunikasi lintas profesi. Pendekatan kolaboratif juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis dalam praktik pelayanan kesehatan. IPC

berkontribusi terhadap terciptanya budaya keselamatan pasien dalam organisasi pelayanan kesehatan. Tim kesehatan yang memiliki kolaborasi baik cenderung lebih terbuka dalam melaporkan kesalahan, belajar dari insiden, dan melakukan perbaikan sistem pelayanan secara berkelanjutan (Alifiya & Susanti, 2023).

H. Praktik Mandiri dan Kewirausahaan Tenaga Kesehatan

Praktik mandiri dan kewirausahaan tenaga kesehatan menjadi salah satu bentuk pengembangan profesional yang berperan dalam memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi tenaga kesehatan. Melalui praktik mandiri, tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih fleksibel, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sementara aspek kewirausahaan mendorong kemampuan manajerial, inovasi layanan, serta pemanfaatan teknologi kesehatan. Untuk melihat beberapa informasi praktik mandiri dan kewirausahaan tenaga Kesehatan, perhatikan uraian berikut ini.

1. Praktik Mandiri Perawat

Praktik mandiri perawat merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan secara individu atau kelompok di luar fasilitas pelayanan kesehatan formal, dengan tetap berlandaskan standar profesi, kode etik, dan regulasi yang berlaku. Secara konsep, praktik mandiri bertujuan membantu individu, keluarga, dan masyarakat memenuhi kebutuhan kesehatan melalui pelayanan asuhan keperawatan, edukasi kesehatan, konsultasi, dan promosi kesehatan. Praktik ini menjadi salah satu wujud profesionalisme perawat dalam menjalankan kewenangannya sesuai kompetensi yang dimiliki (Qelina & Reswara, 2025).

Di Indonesia, praktik mandiri perawat memiliki dasar hukum yang jelas, terutama melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan regulasi turunannya seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019. Regulasi tersebut mengatur persyaratan praktik mandiri, termasuk kewajiban memiliki STR, SIPP, serta memenuhi standar sarana dan prasarana pelayanan. Selain itu, regulasi terbaru juga menguatkan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik sesuai standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku (Herdiani et al., 2020).

Dari sisi pengembangan profesi, praktik mandiri juga dipandang sebagai peluang karier dan kewirausahaan bagi perawat. Pemerintah bahkan mendorong optimalisasi praktik mandiri sebagai alternatif peningkatan akses layanan kesehatan masyarakat. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti jumlah izin praktik yang relatif sedikit dibandingkan jumlah perawat, serta

distribusi tenaga kesehatan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia(Clustering et al., 2024).

2. Peluang dan Hambatan Regulasi

Regulasi praktik mandiri memberikan peluang besar bagi tenaga kesehatan untuk mengembangkan kewirausahaan berbasis pelayanan kesehatan. Dengan adanya regulasi yang jelas, tenaga kesehatan dapat membuka layanan secara legal dan profesional. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendorong kemudahan perizinan diharapkan dapat meningkatkan jumlah praktik mandiri, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas Kesehatan (Susanti & Supartono, 2023).

Namun, dalam implementasinya, regulasi juga dapat menjadi hambatan. Beberapa kendala yang sering ditemukan meliputi proses perizinan yang kompleks, persyaratan administrasi yang ketat, serta kebutuhan investasi sarana dan prasarana yang cukup besar. Selain itu, perubahan kebijakan atau standar pendidikan minimal praktik mandiri juga dapat memengaruhi kesiapan tenaga kesehatan untuk membuka praktik secara mandiri (Sjarlis, 2022).

Selain faktor administratif, tantangan regulasi juga dapat berasal dari dinamika kebijakan kesehatan nasional. Regulasi baru yang bertujuan meningkatkan mutu pelayanan kadang menimbulkan konsekuensi berupa peningkatan standar operasional dan kebutuhan sumber daya yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pengawasan mutu layanan dan kemudahan akses bagi tenaga kesehatan untuk membuka praktik mandiri.

3. Dampak pada Akses Layanan Masyarakat

Praktik mandiri tenaga kesehatan berpotensi meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya di daerah yang kekurangan fasilitas kesehatan formal. Keberadaan praktik mandiri dapat memperluas jangkauan pelayanan kesehatan primer dan meningkatkan keterjangkauan layanan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional yang menekankan pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas (Sundoro et al., 2025).

Selain itu, praktik mandiri dapat membantu mengatasi ketimpangan distribusi tenaga kesehatan. Data menunjukkan bahwa praktik mandiri lebih banyak berkembang di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan karena kebutuhan layanan kesehatan yang lebih tinggi dan keterbatasan fasilitas kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik mandiri dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis komunitas.

Secara global, peningkatan akses layanan kesehatan juga dapat didukung oleh inovasi layanan berbasis teknologi seperti telehealth dan remote monitoring.

Teknologi tersebut terbukti dapat meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan di wilayah underserved, meskipun tetap memerlukan dukungan regulasi, infrastruktur, dan kesiapan tenaga kesehatan dalam implementasinya (Bagaskara et al., 2025).

I. Hambatan Memperoleh Tenaga Kesehatan Yang Berpengalaman

Hambatan atau kendala pelaksanaan SDM yang memiliki pengalaman praktik dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dapat dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu sumber daya manusia itu sendiri, sistem organisasi, sarana prasarana, serta kebijakan dan regulasi.

Pertama, hambatan dari aspek kompetensi dan pengembangan SDM. Meskipun tenaga kesehatan telah memiliki pengalaman praktik, tidak semua mendapatkan kesempatan pelatihan berkelanjutan yang merata. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang sangat cepat menuntut tenaga kesehatan untuk terus memperbarui kompetensinya. Namun, keterbatasan waktu, beban kerja tinggi, serta keterbatasan akses pelatihan sering menjadi kendala. Selain itu, perbedaan kualitas pendidikan dan pengalaman praktik antar tenaga kesehatan juga dapat memengaruhi standar pelayanan yang diberikan (Attriani, 2022).

Kedua, hambatan beban kerja dan distribusi tenaga kesehatan. Ada beberapa tempat atau fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas dan fasilitas di daerah terpencil, jumlah tenaga kesehatan masih belum sebanding dengan jumlah pasien. Hal ini menyebabkan tenaga kesehatan harus menangani banyak tugas secara bersamaan, mulai dari pelayanan klinis, administrasi, hingga edukasi masyarakat. Kondisi ini dapat menimbulkan kelelahan kerja (burnout), menurunkan kualitas pelayanan, serta menghambat optimalisasi pengalaman praktik yang dimiliki tenaga Kesehatan (Samuriwo, 2022).

Ketiga, hambatan komunikasi dan kolaborasi tim interprofesional. Dalam pelayanan kesehatan modern, kerja tim antar profesi sangat penting. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti perbedaan persepsi peran, komunikasi yang kurang efektif, serta hierarki profesi yang terlalu kuat. Hal ini dapat menghambat proses pengambilan keputusan klinis dan memengaruhi keselamatan pasien. Kurangnya budaya kolaborasi juga dapat membuat pengalaman praktik tenaga kesehatan tidak berkembang secara optimal.

Keempat, hambatan sarana, prasarana, dan teknologi. Tidak semua fasilitas kesehatan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung praktik tenaga kesehatan secara optimal. Keterbatasan alat kesehatan, sistem informasi kesehatan yang belum terintegrasi, serta keterbatasan akses teknologi digital dapat

menghambat penerapan praktik berbasis bukti dan inovasi pelayanan. Hal ini sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan daerah dengan keterbatasan sumber daya (Thaliah et al., 2024).

Kelima, hambatan kebijakan dan sistem manajemen. Kebijakan yang berubah-ubah, sistem birokrasi yang kompleks, serta keterbatasan dukungan manajerial dapat memengaruhi kinerja tenaga kesehatan. Selain itu, sistem penghargaan dan pengembangan karier yang belum optimal juga dapat menurunkan motivasi tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas praktiknya. Kurangnya supervisi dan pembinaan profesional juga menjadi kendala dalam menjaga mutu pelayanan.

Keenam, hambatan faktor psikososial dan lingkungan kerja. Lingkungan kerja dengan tekanan tinggi, risiko paparan penyakit, tuntutan pelayanan cepat, serta konflik internal tim dapat memengaruhi kesehatan mental tenaga kesehatan. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat berdampak pada penurunan kinerja, meningkatnya kesalahan pelayanan, dan menurunnya kepuasan kerja tenaga kesehatan.

Secara keseluruhan, hambatan pelaksanaan SDM dalam praktik pelayanan kesehatan bersifat multidimensional dan saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, pemerataan distribusi tenaga kesehatan, penguatan sistem manajemen, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta penguatan kebijakan yang mendukung pengembangan profesional tenaga kesehatan secara berkelanjutan. Jika hambatan-hambatan ini dapat diatasi, maka pengalaman praktik tenaga kesehatan akan lebih optimal dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Ca et al., 2021).

J. Simpulan

Pengalaman praktik tenaga kesehatan merupakan unsur penting dalam membentuk kompetensi, profesionalisme, dan kesiapan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Melalui praktik langsung, tenaga kesehatan tidak hanya meningkatkan keterampilan klinis, tetapi juga mengembangkan kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, kerja sama tim interprofesional, serta pemahaman kebutuhan pasien secara menyeluruh. Hal ini menjadi dasar dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien, mutu layanan, dan kepuasan masyarakat.

Pengalaman praktik dipengaruhi oleh sistem pelayanan kesehatan, regulasi, perkembangan teknologi, serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Meskipun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya, hambatan komunikasi, dan ketimpangan akses layanan, terdapat pula peluang pengembangan

melalui praktik mandiri, inovasi digital, dan kolaborasi lintas profesi. Oleh karena itu, dukungan dari institusi pendidikan, pemerintah, organisasi profesi, dan fasilitas kesehatan sangat diperlukan agar tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan yang aman, bermutu, dan sesuai kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan.

K. Referensi

- Alethea, L., & Verlag, V. D. M. (2008). *QUT Digital Repository: For Dad*. 17, 250–258.
- Alifiya, I. N., & Susanti, I. H. (2023). *Hubungan Spiritual Well-Being dengan Burnout pada Perawat*. 5, 121–134. <https://doi.org/10.33088/jkr.v5i2.1002>
- Ashidiqi, A. I., & Shariff, S. (2025). *Harmonizing Faith and Care: Analyzing Inpatient Satisfaction in Islamic Healthcare at Unimus Hospital, Indonesia*. 14(April), 79–97.
- Attriani, A. N. (2022). *Tantangan dan isu strategis sumber daya kesehatan manusia kesehatan pada puskesmas di Indonesia*. 3(September), 363–368.
- Bagaskara, D., Evalentin, F., Sinurat, D., Purba, G. R., Sinaga, J., & Rahmadani, T. W. (2025). *Kesehatan Digital Lewat Smartwatch Tren Atau Solusi? 04(01)*, 683–692.
- Bodenheimer, T., Diaz, I., Ph, D., Chen, M. A., Willard-grace, R., Zhang, M., Johnson, P., Qian, Y., Donnell, E. M. O., Unruh, M. A., & Ph, D. (n.d.). *Burnout and Patient Outcomes*. 9–11. <https://doi.org/10.1007/s11606-022-07894-7>
- Budiyantri, R. T., Herlambang, P. M., & Nandini, N. (2019). *Tantangan Etika dan Hukum Penggunaan Rekam Medis Elektronik dalam Era Personalized Medicine*. 4(1), 49–54.
- Ca, B. S., Sundari, S., & Alvionita, C. V. (2021). *Health Notions, Volume 5 Number 8 (August 2021) Factors Affecting the Implementation of Patient Safety Culture at RSI Unisma Malang 262 | Publisher: Humanistic Network for Science and Technology Health Notions, Volume 5 Number 8 (August 2021) ISSN 2580-4936 263 | Publisher: Humanistic Network for Science and Technology*. 5(8), 262–266.
- Clustering, K., Data, A., & Kesehatan, L. (2024). *Analisis Distribusi Tenaga Kesehatan Di Indonesia Menggunakan K-Means Clustering*. 11(3), 287–298.
- Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas. (2025). *Kepdirjen Kesehatan Primer Dan Komunitas Nomor Hk.02.02-B-576-2025 Tentang Juknis Pmt Lokal Bagi Ibu Hamil Dan Balita Bermasalah Gizi*.
- Elungan, A. N. F., Baharuddin, M., Tjenreng, Z., Pemerintahan, I., & Negeri, D. (2025). *Government Policy in Health Services: Kebijakan Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan*. 8(1), 170–177.
- Fachrurrozi, A. (2023). *Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit: Systematic Literature Review*. 2(1).

- Fahriyyan, A., Wiji, D., Sari, P., & Issroviatiningrum, R. (2025). *Hubungan Peran Perawat sebagai Edukator dengan Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman Nyaman Pasien*. 3.
- Fitriani, A., & Yuliani, F. (2025). *MEMBANGUN KOMUNIKASI EFEKTIF DENGAN LANSIA : STUDI DI PUSKESMAS MUARA*. 6(1), 34–45.
- Gray, K., Slavotinek, J., Dimaguila, G. L., Choo, D., & Gray, K. (2022). *Artificial Intelligence Education for the Health Workforce: Expert Survey of Approaches and Needs Corresponding Author: 8*, 1–11. <https://doi.org/10.2196/35223>
- Gustina, N. Z., Ode, L., Rahman, A., Ilmu, F., & Universitas, K. (2020). *Dilema Etik Dalam Assisted Reproductive Technology*. 5(1), 43–53.
- Hakim, L. N. (2020). *Lukman Nul Hakim*. April.
- Halimatussakdiah, H., Faisal, T. I., Nuraskin, C. A., Ahmad, A., & Alhuda, A. (2022). The Effect of Electronic Nursing Documentation (END) Implementation on Nursing Services Toward Patients' Satisfaction. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 7(1), 237–246. <https://doi.org/10.30604/jika.v7i1.842>
- Herdiani, T. N., Apriani, W., Kerja, M., Enterpreneur, I., & Mandiri, P. (2020). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Inovasi Enterpreneur Dalam Pelayanan Praktik Mandiri Bidan Di Kota Bengkulu*. 3(2), 233–246. <https://doi.org/10.30994/jqwh.v3i2.80>
- Irfan Sazali Nasution, Nurhazizah Br Said, Mutiara Salsabila, Ayu Maulidia, Zahwa Sinta Aulia, & Suci ramadhani. (2024). Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Tinjauan, Tantangan, dan Rekomendasi. *Vitamin : Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, 2(3), 195–206. <https://doi.org/10.61132/vitamin.v2i3.509>
- Ismiyah, N., Asy-syifa, A. M., & Mangkurat, L. (2024). *Telemedicine dan Kesehatan : Memahami Dampak Teknologi Kedokteran di Era Digital dalam Konteks Ajaran Islam*. 4.
- Jiwa, H., Dan, K., Utami, S. S., Suwarni, A., Putra, F. A., Keperawatan, S. I., Sains, F., Kesehatan, T., & Sahid, U. (2024). *Perawat Terhadap Kualitas Pelayanan Praktik Mandiri (Homecare) Dalam Pelaksanaan Praktik Keperawatan Mandiri Di Sukoharjo 2023*. 01(01), 1–13.
- Lestari, H. D., Ottu, E. R., Hamu, A. H., & Vanchapo, A. R. (2025). *Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit : Systematic Literature Review Strategies for Improving Healthcare Service Quality in Hospitals: A Systematic Literature Review*. 155–166.
- Lu, F. C. (2022). *Kolaborasi Interprofessional Collaboration (IPC) dalam Menanggapi Krisis Kesehatan Global : Pandemi COVID-19*.
- Manurung, J. S., Handini, M. C., & Sitorus, M. E. J. (2023). *IMPLEMENTASI INTER PROFESSIONAL COLLABORATION (IPC)*. 4, 1857–1870.

- Noviyanti, A., Sari, N. L., Lestari, T., Mitra, S., Karanganyar, H., Brigjen, J. L., Barat, K., Indah, G. P., Tasikmadu, K., Karanganyar, K., & Tengah, J. (2023). *Indonesian Journal of Health Information Management (IJHIM) Vol. 3 No. 1 (2023), 3(1), 1–12.*
- Octaviani, P., Fitri, T. A., Kurnia, I. P., Wasir, R., Arbitera, C., Pembangunan, U., Veteran, N., Pembangunan, U., Veteran, N., Pembangunan, U., Veteran, N., Pembangunan, U., Veteran, N., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2024). *PERENCANAAN SDM KESEHATAN: MEWUJUDKAN KEBUTUHAN. 4(6), 953–960.*
- Pamungkas, L. J., Az-zahra, R. I. P., & Permana, D. T. (2025). *Peran Perawat dalam Shared Decision Making untuk Pasien Penyakit Kronis: Suatu Tinjauan Sistematis 2015 – 2025. 5(2), 1667–1678.*
- Purisima, E. M., Oliber, B., Jr, A., Locsin, R. C., Montayre, J., & Nero, F. D. (2024). *Reframing the environment domain of the nursing metaparadigm: Exploring space, place, and technology. 10(6), 614–623.*
- Qelina, L., & Reswara, U. A. (2025). *Narative Review: Strategi Pengembangan Sumberdaya Manusia di Rumah Sakit untuk meningkatkan Profesionalisme dan Layanan. 4.*
- Ramandini, N. (2024). *Krisis Ekonomi dan Pemulihan Pasca Pandemi: Pembelajaran dari Resesi Global 2020 dan Strategi untuk Membangun Kembali. 3(5), 4554–4565.*
- Ramdani, M. I., Ruhaeni, N., & Suminar, R. S. (2026). *Kekuatan Mengikat Who Patient Safety Rights Charter sebagai Instrumen Soft Law dalam Sistem Hukum Indonesia ini menyatakan bahwa keselamatan pasien adalah hak, bukan sekedar kewajiban medis, dan pendekatan teknokratis yang berpotensi besar akan merugikan pasien karena tidak terpenuhi. 3(November 2025).*
- Reinhart, W., Pomeo, R., & Winarti, E. (2024). *DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN DI DAERAH TERPENCIL: TANTANGAN DAN. 5, 2309–2329.*
- Ridlo, I. A. (n.d.). *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental Pandemi COVID-19 dan Tantangan Kebijakan Kesehatan Mental di Indonesia. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v5i12020.155-164>*
- Rigo, D., Fehring, L., Mortsiefer, A., Med, P., & Meister, S. (2025). *Service Quality Assessment of Digital Health Solutions in Outpatient Care: Qualitative Item Repository Development Study Corresponding Author: 9, 1–21. <https://doi.org/10.2196/68276>*
- Rosyid, A. F. (2023). *No Title. 5(2), 277–285.*
- Samuriwo, R. (2022). *Interprofessional Collaboration — Time for a New Theory of Action? 9(March), 1–4. <https://doi.org/10.3389/fmed.2022.876715>*

- Simamora, T. M. (2021). *Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas Terpencil dan Sangat Terpencil di Masa Pandemi*. 1.
- Sjarlis, S. (2022). *Journal of Applied Management and Business Research (JAMBiR) Pengaruh Profesionalisme Tenaga Kesehatan terhadap Kinerja Tenaga Kesehatan melalui Kualitas Pelayanan dan Kerja Tim di Puskesmas*. 2(2), 184–195.
- Solon, M., Madu, Y. G., & Tolidunde, M. (2021). *Dampak Beban Kerja Terhadap Tingkat Stres Pada Tenaga Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid 19*. 4(2), 94–101. <https://doi.org/10.52774/jkfn.v4i2.74>
- Sugiat, J., Rusdian, S., & Information, A. (2023). *MOTIVASI SEMANGAT BERWIRAUSAHA GENERASI MUDA KHUSUSNYA DI KALANGAN SISWA SMKS AL-QUDSY CIBATU*. 1, 1396–1400.
- Sundoro, F. M., Wulan, A., Saputri, A., & Pradista, L. (2025). *Telemedicine dan Transformasi Digital Kesehatan Global 1999 – 2025*. 23(4), 634–650. <https://doi.org/10.26623/slsi.v23i4.13058>
- Susanti, S., & Supartono, B. (2023). *REGULASI PELAYANAN KESEHATAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA: REVIEW LITERATUR KOMPREHENSIF Pendahuluan*. 2(2), 74–84.
- Susilowati, I., & Hakiem, F. N. (2020). Optimalisasi Peran Perempuan Sebagai Strategi Alternatif Kebijakan Publik Dalam Menekan Penyebaran Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(8), 723–736. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16551>
- Thaliah, A., Priyono, P., Alba, A. M., Wasir, R., & Arbitera, C. (2024). *MANAJEMEN KINERJA SDM KESEHATAN: MENJAGA KUALITAS*. 4(6), 871–882.
- Ummah, F., Prayoga, O. W., Fitri, K., Nugraha, A., Prabawa, D. C., Wildan, M. A., Madura, U. T., Bangkalan, K., & Timur, J. (2025). *KOMUNIKASI INTERNAL DAN KUALITAS KEHIDUPAN KERJA*. 3(12).
- Yuliani, I., & Ak, D. (2019). *Pengembangan Sistem Kewaspadaan Dini Penyakit New-Emerging Dan Re-Emerging , Studi Kasus Pada Penyakit MERS-CoV Dan Ebola Di Kantor Kesehatan Pelabuhan*. 4(1).
- Yusuf, S. A., Herlina, C., & Sibarani, L. (2024). *Aspek Legal dan Etika Penggunaan Data Pasien dalam Teknologi Big Data dan Kecerdasan Buatan di Sektor Kesehatan*. 381–393.

CHAPTER 2

PEMBELAJARAN DARI PRAKTIK KEBIDANAN DI LAYANAN KESEHATAN

(Lani Nurlita, M.Tr.Keb)

A. Pendahuluan

Praktik kebidanan merupakan implementasi dari ilmu kebidanan oleh bidan yang bersifat otonom, kepada perempuan, keluarga, dan komunitas nya yang didasari etika dan kode etik bidan (Yuhana et al., 2024). Pembelajaran praktik kebidanan merupakan inti dari pendidikan kebidanan di mana mahasiswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara sistematis dalam konteks klinis nyata. Pembelajaran ini memungkinkan mahasiswa mengalami langsung dinamika pelayanan kesehatan, termasuk memberikan asuhan kebidanan yang aman, efektif, dan berpusat pada klien perempuan dan keluarganya. Pelayanan Kebidanan adalah semua tugas yang menjadi tanggungjawab praktik profesi bidan dalam sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat. Pengalaman klinis dapat membangun kompetensi profesional bidan, bukan hanya keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi, pengambilan keputusan, refleksi praktik, serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya (Yang et al., 2025).

Pembelajaran dari praktik kebidanan juga berperan penting dalam membangun kemampuan berpikir kritis dan klinis mahasiswa. Critical thinking atau kemampuan berpikir kritis adalah serangkaian sikap atau perilaku seseorang yang menerapkan kemampuan mencari kebenaran, berpikir rasional, dan terbuka (Yuhana et al., 2024). Melalui paparan terhadap berbagai kasus kebidanan, mahasiswa dilatih untuk menganalisis masalah, menentukan prioritas asuhan, serta menerapkan standar dan pedoman praktik kebidanan yang berbasis bukti. Studi menunjukkan bahwa pengalaman klinik yang terstruktur dan dibimbing dengan baik dapat meningkatkan kepercayaan diri, kompetensi klinik, serta kesiapan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja sebagai bidan profesional (McKellar et al., 2019).

Layanan kesehatan berperan sebagai lingkungan belajar nyata yang memungkinkan mahasiswa kebidanan berinteraksi langsung dengan klien, keluarga, serta tenaga kesehatan lainnya. Berbagai tatanan pelayanan, seperti puskesmas,

rumah sakit, klinik, dan praktik mandiri bidan, menyediakan ragam kasus kebidanan yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa (Kemenkeks RI, 2018). Melalui keterlibatan aktif dalam pelayanan kebidanan, mahasiswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran dan tanggung jawab bidan dalam memberikan asuhan yang aman, etis, dan berpusat pada klien (IBI, 2021).

Namun demikian, pelaksanaan pembelajaran praktik tidak terlepas dari tantangan. Variasi sumber daya, kesiapan pembimbing klinik, keterbatasan pasien atau kasus, serta koordinasi antara institusi pendidikan dan fasilitas layanan kesehatan merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pengalaman praktik mahasiswa (Rahimah, Mufdlilah, & Hakimi, 2024).

Oleh karena itu, pembelajaran dari praktik kebidanan di layanan kesehatan merupakan bagian esensial dari pendidikan kebidanan yang harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis. Praktik kebidanan yang berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan bidan yang kompeten, profesional, serta mampu berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak sesuai dengan standar nasional dan internasional (Kemenkes RI, 2020).

Oleh karena itu, pembahasan mengenai pembelajaran dari praktik kebidanan di layanan kesehatan menjadi penting untuk memberikan gambaran konseptual dan praktis bagi dosen, pembimbing klinik, dan mahasiswa dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran praktik dan pelayanan kebidanan secara berkelanjutan. chapter ini disusun untuk mengkaji pembelajaran yang diperoleh dari praktik kebidanan di layanan kesehatan sebagai bagian penting dari pendidikan kebidanan. Pendekatan pembelajaran yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan kebidanan sekaligus berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan kebidanan di layanan kesehatan.

B. Konsep Dasar Pembelajaran Praktik Kebidanan

Pembelajaran praktik kebidanan merupakan bagian inti dari pendidikan kebidanan yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi profesional mahasiswa melalui pengalaman langsung di layanan kesehatan. Pembelajaran ini menekankan integrasi antara pengetahuan teoretis, keterampilan klinik, dan sikap profesional dalam konteks pelayanan kebidanan kepada perempuan, bayi, dan keluarga secara berkesinambungan (ICM, 2019). Melalui pembelajaran praktik, mahasiswa tidak hanya mempelajari *apa* yang harus dilakukan, tetapi juga *bagaimana* dan *mengapa* asuhan kebidanan diberikan sesuai standar profesi dan kebutuhan klien.

Secara konseptual, pembelajaran praktik kebidanan berlandaskan pada pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, di mana pengalaman klinik

menjadi sumber utama pembelajaran dan refleksi mahasiswa. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap praktik kebidanan melalui keterlibatan aktif dalam situasi klinik nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan kontekstual (Kolb, 1984; O'Connor et al., 2018). Pengalaman langsung tersebut juga berperan penting dalam melatih kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinik yang esensial dalam praktik kebidanan.

Pembelajaran praktik kebidanan di layanan kesehatan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pembelajaran teori dan laboratorium. Pembelajaran ini berlangsung dalam lingkungan klinik nyata yang dinamis dan kompleks, seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, dan komunitas, di mana mahasiswa dihadapkan pada variasi kondisi klien dan situasi pelayanan yang tidak selalu dapat diprediksi (WHO, 2016). Kondisi ini menuntut mahasiswa untuk mampu beradaptasi, berkomunikasi secara efektif, serta menerapkan prinsip keselamatan pasien dan etika profesi dalam setiap tindakan kebidanan.

Karakteristik lainnya adalah adanya interaksi langsung dengan klien dan kolaborasi dengan tim kesehatan. Interaksi tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan komunikasi terapeutik, kerja sama interprofesional, dan pemahaman terhadap peran bidan dalam sistem pelayanan kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan belajar klinik yang suportif dan didukung pembimbing klinik yang kompeten berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepercayaan diri dan kesiapan praktik mahasiswa kebidanan (Sweet & Glover, 2020; Martensson et al., 2019).

Dalam pendidikan kebidanan, pembelajaran praktik perlu dipahami sebagai bagian dari satu kesatuan dengan pembelajaran teori dan laboratorium. Pembelajaran teori berfokus pada penguasaan konsep, prinsip ilmiah, dan dasar pengetahuan kebidanan sebagai landasan kognitif mahasiswa. Pembelajaran laboratorium berfungsi sebagai tahap transisi yang memungkinkan mahasiswa berlatih keterampilan dasar kebidanan dalam lingkungan yang terkontrol dan aman melalui simulasi, sebelum menghadapi klien secara langsung (Cant & Cooper, 2017). Sementara itu, pembelajaran praktik klinik menempatkan mahasiswa dalam konteks pelayanan nyata dengan tingkat kompleksitas dan tanggung jawab yang lebih tinggi, sehingga menuntut integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional secara utuh (ICM, 2019).

Perbedaan mendasar antara ketiga bentuk pembelajaran tersebut terletak pada konteks, tingkat risiko, dan kedalaman pengalaman belajar. Pembelajaran praktik klinik memberikan pengalaman autentik yang tidak sepenuhnya dapat diperoleh melalui pembelajaran teori maupun laboratorium, terutama dalam aspek

pengambilan keputusan klinik, interaksi dengan klien, serta penerapan nilai etik dan profesionalisme bidan (WHO, 2016; Sweet & Glover, 2020).

Pembelajaran praktik kebidanan memiliki peran yang sangat strategis dalam pencapaian kompetensi bidan. Kompetensi bidan mencakup pengetahuan, keterampilan klinik, sikap profesional, dan kemampuan komunikasi yang hanya dapat berkembang secara optimal melalui pengalaman praktik yang bermakna dan berulang. Studi menunjukkan bahwa kualitas dan durasi pengalaman praktik klinik berpengaruh langsung terhadap kesiapan kerja dan kemampuan mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan yang aman dan bermutu (McKellar et al., 2018).

Melalui pembelajaran praktik, mahasiswa belajar menginternalisasi peran bidan sebagai pemberi asuhan, pendidik kesehatan, dan advokat perempuan. Proses ini juga berkontribusi dalam pembentukan identitas profesional bidan yang berorientasi pada keselamatan klien, penghormatan terhadap hak perempuan, serta praktik kebidanan berbasis bukti (ICM, 2019; O'Connor et al., 2018). Oleh karena itu, pembelajaran praktik kebidanan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam menghasilkan bidan yang kompeten, beretika, dan siap menghadapi tuntutan pelayanan kesehatan.

C. Landasan Pembelajaran Praktik Kebidanan di Layanan Kesehatan

Pembelajaran praktik kebidanan di layanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari berbagai landasan yang menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Landasan tersebut mencakup aspek filosofis, pedagogis, yuridis, serta etik dan profesionalisme yang saling melengkapi dalam membentuk pembelajaran praktik yang bermutu dan berorientasi pada pencapaian kompetensi bidan. Kejelasan landasan pembelajaran praktik kebidanan sangat penting agar proses pembelajaran di lahan praktik berjalan sistematis, terarah, dan selaras dengan tujuan pendidikan kebidanan (ICM, 2019).

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembelajaran praktik kebidanan berakar pada filosofi kebidanan yang memandang kehamilan, persalinan, dan nifas sebagai proses fisiologis kehidupan yang perlu didukung secara holistik dan berpusat pada perempuan (*woman-centered care*). Filosofi ini menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam asuhan, dengan menghargai martabat, nilai, budaya, dan hak klien dalam setiap pengambilan keputusan kebidanan (ICM, 2019).

Dalam konteks pembelajaran praktik, landasan filosofis ini mendorong mahasiswa untuk memahami bahwa praktik kebidanan tidak semata-mata tindakan klinik, tetapi juga bentuk pelayanan yang humanistik, empatik, dan

berorientasi pada hubungan terapeutik. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman filosofi kebidanan yang kuat pada mahasiswa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas asuhan dan sikap profesional dalam praktik klinik (Leap et al., 2016). Dengan demikian, pembelajaran praktik kebidanan harus diarahkan untuk membentuk bidan yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan kemanusiaan.

2. Landasan Pedagogis

Landasan pedagogis pembelajaran praktik kebidanan didasarkan pada teori pembelajaran orang dewasa (*andragogi*) dan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*). Mahasiswa kebidanan sebagai pembelajar dewasa memiliki kebutuhan untuk terlibat aktif, memahami tujuan pembelajaran, serta mengaitkan pengalaman praktik dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya (Knowles et al., 2015).

Pembelajaran praktik kebidanan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk belajar melalui pengalaman langsung di layanan kesehatan, diikuti dengan proses refleksi untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi. Pendekatan ini sejalan dengan teori *experiential learning* yang menekankan bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi ketika pengalaman diolah melalui refleksi dan konseptualisasi (Kolb, 1984). Studi menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran reflektif dalam praktik klinik kebidanan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan mahasiswa (O'Connor et al., 2018).

Selain itu, pembelajaran praktik kebidanan juga mengadopsi pendekatan *student-centered learning*, di mana mahasiswa didorong untuk bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri dengan dukungan pembimbing klinik. Lingkungan belajar klinik yang kondusif dan pembimbingan yang efektif terbukti meningkatkan keterlibatan dan pencapaian belajar mahasiswa kebidanan (Sweet & Glover, 2020).

3. Landasan Yuridis dan Kebijakan

Landasan yuridis pembelajaran praktik kebidanan di layanan kesehatan mengacu pada regulasi dan kebijakan yang mengatur pendidikan dan praktik kebidanan. Di tingkat global, World Health Organization menegaskan bahwa pendidikan kebidanan harus mencakup praktik klinik yang memadai dan berkualitas untuk menjamin kesiapan lulusan dalam memberikan pelayanan yang aman dan bermutu (WHO, 2016).

Di tingkat profesi, ICM menetapkan standar global pendidikan kebidanan yang menempatkan pembelajaran praktik sebagai komponen inti kurikulum untuk mencapai kompetensi bidan secara utuh (ICM, 2019). Standar tersebut

menekankan pentingnya kesesuaian antara capaian pembelajaran, pengalaman praktik klinik, serta sistem supervisi dan penilaian yang jelas.

Secara nasional, pembelajaran praktik kebidanan juga harus selaras dengan standar pendidikan tenaga kesehatan dan kebijakan terkait penyelenggaraan pendidikan profesi bidan. Kesesuaian antara institusi pendidikan dan lahan praktik menjadi aspek penting dalam menjamin legalitas, keselamatan klien, serta perlindungan bagi mahasiswa selama menjalani praktik klinik (Kemenkes, 2020).

4. Landasan Etik dan Profesionalisme

Landasan etik dan profesionalisme merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pembelajaran praktik kebidanan di layanan kesehatan. Mahasiswa sebagai calon bidan perlu dibekali pemahaman dan penerapan prinsip etik kebidanan, seperti menghormati otonomi klien, menjaga kerahasiaan, berbuat baik, serta menghindari tindakan yang merugikan klien. Penerapan prinsip etik dalam pembelajaran praktik sangat penting karena mahasiswa terlibat langsung dalam pelayanan kepada klien nyata (ICM, 2019).

Pembelajaran praktik kebidanan juga menjadi sarana pembentukan profesionalisme bidan, termasuk tanggung jawab, disiplin, akuntabilitas, dan komitmen terhadap mutu pelayanan. Penelitian menunjukkan bahwa paparan langsung terhadap praktik klinik dengan teladan profesional dari pembimbing klinik berperan besar dalam pembentukan identitas profesional mahasiswa kebidanan (Martensson et al., 2019). Oleh karena itu, pembelajaran praktik harus dirancang tidak hanya untuk melatih keterampilan klinik, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai etik dan profesional yang menjadi ciri khas praktik kebidanan.

D. Tujuan dan Capaian Pembelajaran Praktik Kebidanan

Pembelajaran praktik kebidanan dirancang secara terencana untuk mendukung pencapaian kompetensi bidan melalui pengalaman klinik yang nyata dan bermakna. Tujuan dan capaian pembelajaran praktik kebidanan harus selaras dengan filosofi pendidikan kebidanan, standar profesi, serta kebutuhan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Kejelasan tujuan dan capaian pembelajaran menjadi landasan penting dalam merancang pengalaman praktik yang sistematis, terukur, dan berorientasi pada mutu lulusan (ICM, 2019).

1. Tujuan Pembelajaran Praktik Kebidanan

Tujuan utama pembelajaran praktik kebidanan adalah memfasilitasi mahasiswa agar mampu menerapkan pengetahuan teoretis dan keterampilan dasar kebidanan secara aman, efektif, dan etis dalam situasi pelayanan kesehatan nyata. Melalui pembelajaran praktik, mahasiswa diharapkan memiliki kesiapan

untuk memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif kepada perempuan, bayi, dan keluarga sesuai standar praktik profesional (WHO, 2016).

Secara khusus, pembelajaran praktik kebidanan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan asuhan kebidanan berbasis bukti (*evidence-based midwifery*), mengambil keputusan klinik secara tepat, serta berkomunikasi secara efektif dengan klien dan tim kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman praktik klinik yang terstruktur berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis dan kepercayaan diri mahasiswa kebidanan dalam praktik profesional (O'Connor et al., 2018).

Selain itu, pembelajaran praktik kebidanan juga bertujuan membentuk sikap profesional dan etika bidan, termasuk tanggung jawab, empati, penghormatan terhadap hak klien, serta komitmen terhadap keselamatan dan mutu pelayanan. Pembentukan sikap ini hanya dapat dicapai secara optimal melalui keterlibatan langsung mahasiswa dalam praktik klinik dengan bimbingan tenaga profesional yang kompeten (Martensson et al., 2019).

2. Capaian Pembelajaran Praktik Kebidanan

Capaian pembelajaran praktik kebidanan merupakan pernyataan tentang kompetensi yang diharapkan dapat dicapai mahasiswa setelah mengikuti rangkaian praktik klinik di layanan kesehatan. Capaian pembelajaran ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang terintegrasi dalam pelaksanaan asuhan kebidanan. Dalam pendidikan kebidanan berbasis kompetensi, capaian pembelajaran praktik harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dan standar kompetensi bidan yang berlaku (ICM, 2019).

Pada aspek keterampilan, mahasiswa diharapkan mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada berbagai siklus kehidupan perempuan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, perawatan bayi baru lahir, hingga pelayanan kesehatan reproduksi, sesuai kewenangan dan tingkat pendidikan. Studi menunjukkan bahwa mahasiswa yang memperoleh paparan praktik klinik yang cukup dan beragam memiliki kemampuan klinik yang lebih baik serta kesiapan kerja yang lebih tinggi setelah lulus (McKellar et al., 2018).

Pada aspek pengetahuan, pembelajaran praktik kebidanan memungkinkan mahasiswa mengaitkan teori dengan situasi klinik nyata, sehingga pemahaman menjadi lebih mendalam dan kontekstual. Integrasi antara teori dan praktik ini penting untuk mengurangi kesenjangan antara pembelajaran akademik dan tuntutan pelayanan kebidanan di lapangan (Sweet & Glover, 2020).

Sementara itu, pada aspek sikap dan profesionalisme, capaian pembelajaran praktik kebidanan mencakup kemampuan mahasiswa dalam menunjukkan

perilaku etis, tanggung jawab profesional, kerja sama tim, serta refleksi terhadap praktik yang telah dilakukan. Penelitian menunjukkan bahwa refleksi praktik selama pembelajaran klinik berperan penting dalam pembentukan identitas profesional bidan dan peningkatan kualitas asuhan kebidanan (O'Connor et al., 2018; Martensson et al., 2019).

Dengan demikian, tujuan dan capaian pembelajaran praktik kebidanan tidak hanya berorientasi pada pencapaian keterampilan teknis, tetapi juga pada pembentukan bidan yang kompeten secara holistik. Keberhasilan pencapaian tujuan dan capaian pembelajaran praktik sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan belajar klinik, sistem pembimbingan, serta keselarasan antara institusi pendidikan dan layanan kesehatan dalam menyelenggarakan praktik kebidanan yang bermutu (WHO, 2016; ICM, 2019).

E. Layanan Kesehatan sebagai Wahana Pembelajaran Praktik

Layanan kesehatan merupakan wahana utama dalam pelaksanaan pembelajaran praktik kebidanan karena menyediakan lingkungan belajar yang autentik dan kontekstual bagi mahasiswa. Melalui keterlibatan langsung di layanan kesehatan, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengintegrasikan pengetahuan teoretis, keterampilan klinik, dan sikap profesional dalam situasi pelayanan nyata kepada perempuan, bayi, dan keluarga. Lingkungan praktik yang nyata ini menjadi sarana penting dalam membentuk kompetensi bidan secara holistik dan berkelanjutan (ICM, 2019).

Sebagai wahana pembelajaran, layanan kesehatan mencakup berbagai tatanan pelayanan, seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, praktik mandiri bidan, serta layanan kebidanan berbasis komunitas. Setiap tatanan pelayanan memiliki karakteristik dan kompleksitas kasus yang berbeda, sehingga memberikan pengalaman belajar yang beragam bagi mahasiswa. Paparan terhadap berbagai setting pelayanan memungkinkan mahasiswa memahami peran bidan secara komprehensif dalam sistem kesehatan, baik sebagai pemberi asuhan primer, anggota tim kesehatan, maupun pendidik kesehatan masyarakat (WHO, 2016).

Layanan kesehatan sebagai wahana pembelajaran praktik memberikan pengalaman belajar yang bersifat kontekstual dan dinamis. Mahasiswa dihadapkan pada kondisi klinik yang bervariasi, mulai dari asuhan kebidanan fisiologis hingga kasus dengan komplikasi, sehingga menuntut kemampuan adaptasi, berpikir kritis, dan pengambilan keputusan klinik secara tepat. Penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran klinik di lingkungan pelayanan nyata berperan signifikan dalam meningkatkan kesiapan kerja dan kepercayaan diri mahasiswa kebidanan (McKellar et al., 2018).

Selain itu, layanan kesehatan memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara mahasiswa dengan klien dan tim kesehatan. Interaksi ini menjadi sarana pembelajaran penting dalam mengembangkan keterampilan komunikasi terapeutik, kerja sama interprofesional, serta pemahaman terhadap etika dan budaya pelayanan kesehatan. Lingkungan belajar klinik yang mendukung, ditandai dengan supervisi yang efektif dan hubungan yang positif antara mahasiswa dan pembimbing klinik, terbukti meningkatkan kualitas pengalaman belajar praktik kebidanan (Sweet & Glover, 2020).

Dalam konteks pembelajaran praktik kebidanan, layanan kesehatan juga berfungsi sebagai wahana pembentukan profesionalisme bidan. Mahasiswa belajar menerapkan nilai-nilai etika, tanggung jawab profesional, disiplin, serta komitmen terhadap keselamatan dan mutu pelayanan. Paparan langsung terhadap praktik profesional bidan di layanan kesehatan memberikan teladan nyata yang berpengaruh besar terhadap pembentukan identitas profesional mahasiswa (Martensson et al., 2019).

Pemanfaatan layanan kesehatan sebagai wahana pembelajaran praktik memerlukan kerja sama yang erat antara institusi pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Kerja sama ini penting untuk memastikan kesesuaian antara tujuan pembelajaran, pengalaman praktik yang diperoleh mahasiswa, serta standar pelayanan yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antar institusi pendidikan dan lahan praktik berkontribusi pada peningkatan mutu pembelajaran klinik dan pencapaian kompetensi mahasiswa kebidanan (O'Connor et al., 2018).

Dengan demikian, layanan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat praktik, tetapi juga sebagai lingkungan belajar strategis yang berperan besar dalam keberhasilan pembelajaran praktik kebidanan. Optimalisasi layanan kesehatan sebagai wahana pembelajaran praktik menjadi kunci dalam menghasilkan lulusan bidan yang kompeten, profesional, dan siap memberikan asuhan kebidanan yang aman serta bermutu sesuai kebutuhan masyarakat (ICM, 2019; WHO, 2016).

F. Model dan Metode Pembelajaran Praktik Kebidanan

Pembelajaran praktik kebidanan menuntut penerapan model dan metode pembelajaran yang mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik klinik. Model dan metode yang digunakan harus berorientasi pada pencapaian kompetensi, pengalaman belajar yang bermakna, serta pengembangan profesionalisme mahasiswa kebidanan. Oleh karena itu, pemilihan model dan metode pembelajaran praktik kebidanan perlu disesuaikan dengan karakteristik

layanan kesehatan, tingkat pendidikan, dan capaian pembelajaran yang ditetapkan (ICM, 2019).

1. Model Pembelajaran Praktik Kebidanan

Model praktik merujuk pada cara atau metode konkret di mana suatu konsep atau teori diterapkan dalam situasi praktis. (Yuhanah et al., 2024). Salah satu model pembelajaran yang banyak digunakan dalam praktik kebidanan adalah pembelajaran berbasis kompetensi (competency-based education). Model ini menekankan pada pencapaian kompetensi klinik yang terukur melalui pengalaman praktik langsung, supervisi, dan evaluasi berkelanjutan. Pendidikan kebidanan berbasis kompetensi terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi tuntutan praktik profesional di layanan kesehatan (Frank et al., 2017).

Selain itu, model pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) menjadi landasan penting dalam pembelajaran praktik kebidanan. Model ini menekankan proses belajar melalui pengalaman langsung, refleksi, konseptualisasi, dan penerapan kembali dalam praktik klinik. Dalam konteks kebidanan, experiential learning memungkinkan mahasiswa belajar dari kasus nyata dan mengembangkan pemahaman klinik yang mendalam (O'Connor et al., 2018).

Model lain yang relevan adalah preceptorship model, yaitu model pembelajaran yang menempatkan mahasiswa di bawah bimbingan langsung bidan klinik yang berpengalaman. Preceptorship memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar melalui teladan praktik profesional, diskusi kasus, serta umpan balik langsung di lahan praktik. Penelitian menunjukkan bahwa model preceptorship berkontribusi positif terhadap peningkatan keterampilan klinik dan pembentukan identitas profesional mahasiswa kebidanan (Martensson et al., 2019).

2. Metode Pembelajaran Praktik Kebidanan

Metode pembelajaran praktik kebidanan dirancang untuk mendukung penerapan model pembelajaran yang digunakan. Metode praktik langsung (direct clinical practice) merupakan metode utama, di mana mahasiswa terlibat secara aktif dalam pemberian asuhan kebidanan sesuai tingkat kompetensi dan kewenangan. Keterlibatan aktif ini penting untuk membangun keterampilan psikomotorik, pengambilan keputusan klinik, dan tanggung jawab profesional (WHO, 2016).

Metode supervisi klinik juga menjadi komponen penting dalam pembelajaran praktik kebidanan. Supervisi yang efektif memungkinkan mahasiswa memperoleh bimbingan, umpan balik konstruktif, serta koreksi

terhadap praktik yang dilakukan. Studi menunjukkan bahwa kualitas supervisi klinik berpengaruh signifikan terhadap pengalaman belajar dan pencapaian kompetensi mahasiswa kebidanan (Sweet & Glover, 2020).

Selain itu, metode refleksi praktik digunakan untuk mendorong mahasiswa melakukan evaluasi diri terhadap pengalaman praktik yang telah dijalani. Refleksi membantu mahasiswa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan dalam praktik kebidanan. Penelitian menunjukkan bahwa refleksi terstruktur selama praktik klinik meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pembelajaran sepanjang hayat pada mahasiswa kebidanan (McKellar et al., 2018).

Dalam beberapa konteks, metode diskusi kasus dan konferensi klinik juga digunakan untuk memperkaya pembelajaran praktik kebidanan. Melalui diskusi kasus, mahasiswa belajar menganalisis masalah klinik, mengintegrasikan bukti ilmiah, serta mempertimbangkan aspek etika dan sosial budaya dalam pengambilan keputusan asuhan kebidanan (Sweet & Glover, 2020).

Dengan mengombinasikan model dan metode pembelajaran praktik kebidanan secara tepat, institusi pendidikan dapat menciptakan pengalaman belajar klinik yang efektif dan berorientasi pada pencapaian kompetensi. Pemilihan model dan metode yang sesuai akan mendukung terbentuknya bidan yang kompeten, reflektif, dan siap memberikan asuhan kebidanan yang aman serta bermutu di berbagai tatanan layanan kesehatan (ICM, 2019; WHO, 2016).

G. Peran dan Tanggung Jawab dalam Pembelajaran Praktik Kebidanan

Pembelajaran praktik kebidanan merupakan proses pendidikan yang kompleks dan kolaboratif, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh kejelasan peran dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat. Pihak-pihak utama dalam pembelajaran praktik kebidanan meliputi institusi pendidikan, dosen pembimbing akademik, pembimbing klinik (preceptor), mahasiswa, serta institusi layanan kesehatan sebagai lahan praktik. Kejelasan peran dan sinergi antarpihak menjadi prasyarat penting untuk menjamin mutu pembelajaran dan keselamatan klien (ICM, 2019).

1. Peran dan Tanggung Jawab Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan kebidanan memiliki peran strategis dalam merancang, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran praktik kebidanan. Institusi bertanggung jawab memastikan bahwa kurikulum praktik selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, standar kompetensi bidan, serta kebutuhan layanan kesehatan. Kurikulum praktik yang terstruktur dan berbasis kompetensi terbukti berkontribusi pada peningkatan kesiapan mahasiswa menghadapi praktik profesional (Frank et al., 2017).

Selain itu, institusi pendidikan bertanggung jawab menjalin kerja sama formal dengan lahan praktik untuk menjamin ketersediaan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Kerja sama yang efektif antara institusi pendidikan dan layanan kesehatan berperan penting dalam menciptakan pengalaman belajar klinik yang berkualitas dan berkesinambungan (WHO, 2016).

2. Peran dan Tanggung Jawab Dosen Pembimbing Akademik

Dosen pembimbing akademik berperan sebagai penghubung antara pembelajaran teoretis di institusi pendidikan dan praktik klinik di layanan kesehatan. Dosen bertanggung jawab dalam mempersiapkan mahasiswa sebelum praktik, memantau pencapaian pembelajaran, serta melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pengalaman praktik mahasiswa. Pendampingan akademik yang konsisten membantu mahasiswa mengintegrasikan teori dengan praktik secara lebih efektif (Sweet & Glover, 2020).

Dosen juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa proses pembelajaran praktik berjalan sesuai tujuan pembelajaran dan prinsip keselamatan klien. Keterlibatan aktif dosen dalam pemantauan praktik klinik terbukti meningkatkan kualitas pembelajaran dan kepuasan mahasiswa terhadap pengalaman praktik kebidanan (McKellar et al., 2018).

3. Peran dan Tanggung Jawab Pembimbing Klinik (Preseptor)

Pembimbing klinik atau preceptor memiliki peran kunci dalam pembelajaran praktik kebidanan karena berinteraksi langsung dengan mahasiswa di lahan praktik. Preceptor bertanggung jawab memberikan bimbingan, supervisi, teladan praktik profesional, serta umpan balik konstruktif selama mahasiswa menjalani praktik klinik. Hubungan pembimbing–mahasiswa yang suportif terbukti berpengaruh positif terhadap perkembangan keterampilan klinik dan kepercayaan diri mahasiswa kebidanan (Martensson et al., 2019).

Selain membimbing keterampilan teknis, preceptor juga berperan dalam menanamkan nilai-nilai profesionalisme, etika, dan budaya keselamatan pasien. Paparan langsung terhadap praktik profesional bidan di layanan kesehatan menjadi sumber pembelajaran penting bagi mahasiswa dalam membentuk identitas profesionalnya (O'Connor et al., 2018).

4. Peran dan Tanggung Jawab Mahasiswa

Mahasiswa merupakan subjek utama dalam pembelajaran praktik kebidanan dan memiliki tanggung jawab besar terhadap proses belajarnya sendiri. Mahasiswa dituntut untuk aktif, bertanggung jawab, dan reflektif dalam setiap pengalaman praktik klinik yang dijalani. Sikap proaktif mahasiswa dalam belajar terbukti berhubungan dengan pencapaian kompetensi klinik yang lebih baik (McKellar et al., 2018).

Mahasiswa juga bertanggung jawab mematuhi standar operasional prosedur, etika profesi, serta prinsip keselamatan klien selama praktik klinik. Kesadaran terhadap batas kewenangan dan kemampuan diri merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi selama pembelajaran praktik kebidanan (ICM, 2019).

5. Peran Layanan Kesehatan sebagai Mitra Pembelajaran

Layanan kesehatan berperan sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pembelajaran praktik kebidanan. Institusi layanan kesehatan bertanggung jawab menyediakan lingkungan praktik yang kondusif, aman, serta mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Lingkungan belajar klinik yang positif, ditandai dengan budaya pembelajaran dan dukungan organisasi, berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengalaman praktik mahasiswa kebidanan (Sweet & Glover, 2020).

Dengan pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas serta kolaborasi yang efektif antarpihak, pembelajaran praktik kebidanan dapat berlangsung secara optimal. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam menghasilkan bidan yang kompeten, profesional, dan mampu memberikan asuhan kebidanan yang aman serta bermutu sesuai kebutuhan masyarakat dan sistem kesehatan (WHO, 2016; ICM, 2019).

H. Tahapan Pelaksanaan Pembelajaran Praktik Kebidanan

Pelaksanaan pembelajaran praktik kebidanan merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan, yang dirancang untuk memastikan tercapainya kompetensi mahasiswa secara optimal. Tahapan pembelajaran praktik kebidanan umumnya meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan praktik klinik, serta tahap evaluasi dan refleksi. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam menjamin mutu pembelajaran, keselamatan klien, dan pencapaian capaian pembelajaran yang telah ditetapkan (ICM, 2019).

1. Tahap Persiapan Pembelajaran Praktik Kebidanan

Tahap persiapan merupakan fondasi awal dalam pelaksanaan pembelajaran praktik kebidanan. Pada tahap ini, institusi pendidikan bertanggung jawab memastikan kesiapan mahasiswa, dosen pembimbing, pembimbing klinik, serta lahan praktik. Persiapan yang baik mencakup penyampaian tujuan dan capaian pembelajaran praktik, penjelasan kompetensi yang harus dicapai, serta pembekalan terkait etika, keselamatan klien, dan standar operasional prosedur di layanan kesehatan (WHO, 2016).

Mahasiswa pada tahap ini perlu dibekali dengan pengetahuan teoretis dan keterampilan dasar yang relevan melalui pembelajaran kelas dan laboratorium.

Kesiapan mahasiswa sebelum memasuki lahan praktik terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengalaman belajar dan kemampuan adaptasi di lingkungan klinik (Sweet & Glover, 2020). Selain itu, orientasi lahan praktik menjadi bagian penting dari tahap persiapan untuk membantu mahasiswa memahami sistem pelayanan, alur kerja, serta peran bidan dalam tatanan layanan kesehatan (McKellar et al., 2018).

2. Tahap Pelaksanaan Praktik Klinik

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari pembelajaran praktik kebidanan, di mana mahasiswa terlibat langsung dalam pelayanan kebidanan di bawah supervisi pembimbing klinik dan dosen pembimbing. Pada tahap ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan kebidanan dalam memberikan asuhan kepada klien secara bertahap sesuai tingkat kompetensi dan kewenangan. Keterlibatan aktif mahasiswa dalam praktik klinik merupakan kunci dalam pengembangan keterampilan klinik dan pengambilan keputusan profesional (O'Connor et al., 2018).

Selama pelaksanaan praktik, pembimbing klinik berperan memberikan supervisi, bimbingan, serta umpan balik konstruktif terhadap tindakan yang dilakukan mahasiswa. Supervisi klinik yang efektif membantu mahasiswa mengidentifikasi kesalahan, meningkatkan keterampilan, serta menumbuhkan kepercayaan diri dalam praktik kebidanan (Martensson et al., 2019). Selain itu, mahasiswa didorong untuk melakukan pencatatan dan dokumentasi asuhan kebidanan sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pertanggungjawaban profesional.

Tahap pelaksanaan praktik juga menjadi wahana pembelajaran nilai-nilai profesionalisme, komunikasi terapeutik, kerja sama tim, serta penerapan prinsip keselamatan pasien. Lingkungan praktik yang suportif dan kondusif terbukti berkontribusi pada pencapaian kompetensi mahasiswa secara lebih optimal (Sweet & Glover, 2020).

3. Tahap Evaluasi dan Refleksi Pembelajaran Praktik

Tahap evaluasi dan refleksi merupakan bagian penting dalam siklus pembelajaran praktik kebidanan. Evaluasi dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa berdasarkan kriteria dan instrumen penilaian yang telah ditetapkan. Penilaian dapat mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, serta kemampuan komunikasi dan kerja sama tim (ICM, 2019).

Selain evaluasi, refleksi pengalaman praktik menjadi sarana penting bagi mahasiswa untuk meninjau kembali proses pembelajaran yang telah dilalui. Refleksi membantu mahasiswa memahami kekuatan dan kelemahan diri, mengaitkan pengalaman praktik dengan teori, serta merencanakan perbaikan

untuk praktik selanjutnya. Penelitian menunjukkan bahwa refleksi terstruktur dalam pembelajaran klinik berperan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pembelajaran sepanjang hayat pada mahasiswa kebidanan (O'Connor et al., 2018).

Hasil evaluasi dan refleksi pembelajaran praktik kebidanan juga menjadi bahan masukan bagi institusi pendidikan dan lahan praktik untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pembelajaran klinik. Dengan pelaksanaan tahapan pembelajaran praktik kebidanan yang sistematis dan berkesinambungan, diharapkan mahasiswa mampu mencapai kompetensi secara utuh dan siap menjalankan peran profesional sebagai bidan di layanan kesehatan (WHO, 2016; ICM, 2019).

I. Penilaian dan Evaluasi Pembelajaran Praktik Kebidanan

Penilaian dan evaluasi merupakan komponen esensial dalam pembelajaran praktik kebidanan karena berfungsi untuk memastikan ketercapaian kompetensi mahasiswa secara komprehensif. Dalam konteks pendidikan kebidanan berbasis kompetensi, penilaian tidak hanya menitikberatkan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran praktik yang dijalani mahasiswa di layanan kesehatan. Penilaian dan evaluasi yang terencana dan sistematis berperan penting dalam menjamin mutu lulusan serta keselamatan klien dalam pelayanan kebidanan (ICM, 2019).

1. Konsep Penilaian dalam Pembelajaran Praktik Kebidanan

Penilaian pembelajaran praktik kebidanan merupakan proses pengumpulan dan interpretasi informasi untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa selama praktik klinik. Penilaian ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan klinik, sikap profesional, serta kemampuan komunikasi dan kerja sama tim. Pendekatan penilaian yang komprehensif diperlukan untuk menggambarkan kemampuan mahasiswa secara utuh sebagai calon bidan profesional (WHO, 2016).

Dalam pembelajaran praktik kebidanan, penilaian berbasis kompetensi menekankan pada kemampuan mahasiswa dalam melakukan asuhan kebidanan secara aman dan efektif sesuai standar praktik. Penelitian menunjukkan bahwa penilaian berbasis kompetensi memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja dibandingkan penilaian berbasis pengetahuan semata (Frank et al., 2017).

2. Metode Penilaian Pembelajaran Praktik Kebidanan

Berbagai metode penilaian digunakan dalam pembelajaran praktik kebidanan untuk menilai pencapaian kompetensi mahasiswa secara objektif.

Penilaian observasional langsung merupakan metode utama, di mana pembimbing klinik atau dosen mengamati kinerja mahasiswa saat memberikan asuhan kebidanan kepada klien. Observasi langsung memungkinkan penilai menilai keterampilan klinik, pengambilan keputusan, serta penerapan prinsip keselamatan pasien secara nyata (Martensson et al., 2019).

Logbook atau portofolio praktik juga banyak digunakan sebagai alat penilaian dalam pembelajaran praktik kebidanan. Melalui logbook, mahasiswa mendokumentasikan jenis dan jumlah tindakan kebidanan yang telah dilakukan, refleksi pengalaman praktik, serta umpan balik dari pembimbing. Portofolio praktik terbukti efektif dalam mendukung pembelajaran reflektif dan pemantauan perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan (McKellar et al., 2018).

Selain itu, penilaian formatif dilakukan secara berkelanjutan selama praktik klinik untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada mahasiswa. Umpan balik yang tepat waktu dan spesifik membantu mahasiswa memperbaiki kinerja dan meningkatkan kompetensi secara bertahap. Studi menunjukkan bahwa penilaian formatif dengan umpan balik berkualitas berpengaruh positif terhadap motivasi dan pencapaian belajar mahasiswa kebidanan (Sweet & Glover, 2020).

3. Evaluasi Pembelajaran Praktik Kebidanan

Evaluasi pembelajaran praktik kebidanan dilakukan untuk menilai efektivitas keseluruhan proses pembelajaran, baik dari sisi mahasiswa, pembimbing, maupun lingkungan praktik. Evaluasi ini mencakup kesesuaian antara tujuan pembelajaran, pengalaman praktik yang diperoleh mahasiswa, serta hasil penilaian kompetensi. Evaluasi yang komprehensif menjadi dasar penting dalam perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan pembelajaran praktik kebidanan (WHO, 2016).

Salah satu aspek penting dalam evaluasi pembelajaran praktik adalah refleksi mahasiswa terhadap pengalaman klinik yang telah dijalani. Refleksi memungkinkan mahasiswa mengidentifikasi pembelajaran bermakna, tantangan yang dihadapi, serta strategi pengembangan diri ke depan. Penelitian menunjukkan bahwa refleksi terstruktur berperan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan pembelajaran sepanjang hayat pada mahasiswa kebidanan (O'Connor et al., 2018).

Hasil evaluasi pembelajaran praktik kebidanan juga menjadi umpan balik bagi institusi pendidikan dan lahan praktik untuk meningkatkan mutu pembelajaran klinik. Evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, dan pembimbing klinik, dapat memberikan gambaran yang

lebih komprehensif mengenai kualitas lingkungan belajar praktik kebidanan (Sweet & Glover, 2020).

Dengan demikian, penilaian dan evaluasi pembelajaran praktik kebidanan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran pencapaian kompetensi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan kebidanan. Penerapan sistem penilaian dan evaluasi yang objektif, transparan, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menghasilkan bidan yang kompeten, reflektif, dan profesional dalam memberikan asuhan kebidanan yang aman dan bermutu (ICM, 2019; WHO, 2016).

J. Tantangan dan Strategi Penguatan Pembelajaran Praktik Kebidanan

Pembelajaran praktik kebidanan adalah komponen penting dalam pendidikan kesehatan yang menghubungkan tahu (*knowing*) dan mampu (*doing*) secara praktik nyata di lapangan. Namun, penerapannya tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang dapat menghambat pencapaian kompetensi mahasiswa secara optimal. Tantangan tersebut bersifat struktural, kurikuler, humanis, hingga terkait hubungan kolaboratif antar pemangku kepentingan pembelajaran praktik kebidanan (Sweet & Glover, 2020).

1. Tantangan Pembelajaran Praktik Kebidanan

a. Kesenjangan antara Teori dan Praktik

Salah satu tantangan utama pembelajaran praktik kebidanan adalah adanya kesenjangan antara materi yang diajarkan di ruang kelas dan realitas kasus di layanan kesehatan. Banyak mahasiswa mengalami kesulitan menerjemahkan teori ke situasi klinik nyata, terutama ketika menghadapi variasi kasus yang kompleks (McKellar et al., 2018). Kondisi ini memerlukan strategi kurikuler yang mampu mengintegrasikan pembelajaran klinik dengan teori secara lebih sinergis.

b. Keterbatasan Supervisi dan Pembimbing Klinik

Kualitas pembimbing klinik (*preceptor*) yang beragam menjadi tantangan signifikan dalam pembelajaran praktik. Tidak semua pembimbing klinik memiliki keterampilan pedagogis yang memadai untuk membimbing mahasiswa, sehingga umpan balik yang diberikan kurang optimal (Martensson, Löfmark, Mamhidir, & Skytt, 2019). Hambatan ini sering berdampak pada pengalaman klinik mahasiswa yang tidak konsisten.

c. Variabilitas Lingkungan Lahan Praktik

Lahan praktik menawarkan pengalaman kasus yang beragam, mulai dari kasus fisiologis kehamilan hingga kondisi berisiko tinggi. Namun, tidak semua mahasiswa memiliki akses yang setara terhadap variasi kasus tersebut selama

periode praktik mereka, sehingga potensi pembelajaran menjadi terbatas (O'Connor, Peters, & Jackson, 2018).

d. Beban Administratif dan Dokumentasi

Mahasiswa sering menghadapi beban administratif dan dokumentasi praktik yang tinggi, seperti pengisian logbook, portofolio, dan laporan evaluasi. Beban ini kadang mengalihkan fokus mahasiswa dari proses pembelajaran inti menjadi kegiatan administratif semata (Sweet & Glover, 2020).

e. Keterbatasan Sumber Daya dan Infrastruktur Klinik
Tidak semua fasilitas layanan kesehatan yang menjadi lahan praktik memiliki sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran klinik. Keterbatasan sarana, ruang belajar, dan perangkat medis ideal dapat mempengaruhi kualitas pengalaman praktik mahasiswa (WHO, 2016).

2. Strategi Penguatan Pembelajaran Praktik Kebidanan

Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas dan meningkatkan mutu pembelajaran praktik kebidanan, sejumlah strategi dapat diimplementasikan oleh institusi pendidikan, pembimbing klinik, serta pemangku kepentingan lainnya.

a. Meningkatkan Integrasi Kurikulum Teori dengan Praktik Klinik

Penyesuaian kurikulum yang memungkinkan integrasi pembelajaran teori dengan praktik secara kontinu dapat membantu mahasiswa memahami keterkaitan konsep dengan kasus klinik nyata. Pendekatan hybrid, simulasi klinik sebelum praktik nyata, dan pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*) merupakan contoh strategi yang efektif untuk menyatukan teori dan praktik (O'Connor et al., 2018).

b. Pengembangan Kapabilitas Pembimbing Klinik

Pelatihan pedagogis bagi pembimbing klinik dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memberikan bimbingan efektif, umpan balik bermakna, serta dukungan perkembangan kompetensi mahasiswa. Program *faculty development* dan *trainer of preceptors* terbukti meningkatkan kualitas supervisi klinik bagi mahasiswa kesehatan (Martensson et al., 2019).

c. Optimalisasi Lingkungan Belajar Klinik

Lingkungan belajar klinik yang suportif dan kondusif sangat mempengaruhi pengalaman pembelajaran praktik mahasiswa. Institusi pendidikan dapat berkonsultasi dengan fasilitas layanan kesehatan untuk merancang jadwal praktik yang memastikan eksposur kasus variatif serta dukungan sumber daya pelatihan klinik (Sweet & Glover, 2020).

d. Penerapan Pendekatan Reflektif dan Umpan Balik Berkualitas

Metode evaluasi itu sendiri menjadi alat pembelajaran penting jika dilakukan dengan umpan balik yang konstruktif dan reflektif. Penggunaan strategi

seperti jurnal reflektif, *structured reflection*, atau *feedback coaching* dapat memfasilitasi mahasiswa menginternalisasi pengalaman praktik menjadi pembelajaran berkelanjutan (McKellar et al., 2018).

e. Pemanfaatan Teknologi dan Simulasi Pembelajaran

Integrasi teknologi pendidikan, termasuk simulasi berbasis virtual atau manikin canggih, membantu mahasiswa mempersiapkan diri sebelum terjun ke praktik nyata. Simulasi ini tidak hanya memperkuat keterampilan klinik namun juga meminimalkan risiko terhadap keselamatan pasien selama pembelajaran (Cant & Cooper, 2017).

f. Membangun Kolaborasi yang Kuat antara Institusi Pendidikan dan Lahan Praktik

Kolaborasi formal antara institusi pendidikan dan fasilitas layanan kesehatan perlu ditingkatkan melalui kerangka kerja bersama, perjanjian kerja sama, serta kesepakatan standar supervisi dan evaluasi praktik. Pendekatan ini membantu menyamakan ekspektasi pembelajaran dan memperkuat harmonisasi proses belajar-mengajar di lapangan (WHO, 2016).

K. Implikasi Pembelajaran Praktik Kebidanan terhadap Kompetensi Lulusan

Pembelajaran praktik kebidanan memiliki implikasi yang signifikan terhadap pencapaian kompetensi lulusan pendidikan kebidanan. Melalui pembelajaran praktik yang terencana, terstruktur, dan terintegrasi dengan kurikulum, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi secara utuh yang mencakup pengetahuan, keterampilan klinik, serta sikap profesional. Kompetensi lulusan yang terbentuk melalui pengalaman praktik klinik menjadi indikator penting kesiapan bidan dalam memberikan asuhan kebidanan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan perempuan dan keluarga (ICM, 2019).

1. Implikasi terhadap Kompetensi Pengetahuan

Pembelajaran praktik kebidanan memungkinkan mahasiswa mengintegrasikan konsep teoretis yang diperoleh di kelas dengan situasi klinik nyata di layanan kesehatan. Proses integrasi ini membantu mahasiswa membangun pemahaman yang lebih kontekstual dan aplikatif terhadap ilmu kebidanan. Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman praktik klinik yang memadai berkontribusi pada peningkatan kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menerapkan prinsip asuhan kebidanan berbasis bukti (*evidence-based practice*) (O'Connor et al., 2018).

Selain itu, pembelajaran praktik mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pengambilan keputusan klinik. Mahasiswa dihadapkan pada berbagai variasi kasus kebidanan yang menuntut

analisis situasi, identifikasi masalah, serta penentuan intervensi yang tepat. Kemampuan kognitif ini menjadi bagian penting dari kompetensi lulusan bidan yang siap menghadapi kompleksitas praktik di lapangan (Frank et al., 2017).

2. Implikasi terhadap Kompetensi Keterampilan Klinik

Implikasi paling nyata dari pembelajaran praktik kebidanan terlihat pada penguasaan keterampilan klinik lulusan. Melalui keterlibatan langsung dalam pelayanan kebidanan, mahasiswa memperoleh pengalaman berulang dalam melakukan prosedur klinik sesuai standar praktik. Paparan praktik yang cukup dan bervariasi terbukti meningkatkan ketepatan tindakan, kepercayaan diri, serta ketangkasan lulusan dalam memberikan asuhan kebidanan (McKellar et al., 2018).

Pembelajaran praktik juga memungkinkan mahasiswa mengembangkan keterampilan komunikasi terapeutik dan kerja sama tim interprofesional. Keterampilan ini penting dalam mendukung kesinambungan asuhan kebidanan serta kolaborasi efektif dengan tenaga kesehatan lain di layanan kesehatan. Lingkungan praktik klinik yang autentik memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mempraktikkan keterampilan tersebut secara nyata dan berkelanjutan (Sweet & Glover, 2020).

3. Implikasi terhadap Kompetensi Sikap dan Profesionalisme

Selain pengetahuan dan keterampilan, pembelajaran praktik kebidanan berimplikasi besar terhadap pembentukan sikap dan profesionalisme lulusan. Melalui interaksi langsung dengan klien, keluarga, dan tenaga kesehatan, mahasiswa belajar menerapkan nilai-nilai etika, empati, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak perempuan. Pembentukan sikap profesional ini menjadi fondasi penting dalam praktik kebidanan yang berpusat pada perempuan (*woman-centered care*) (ICM, 2019).

Penelitian menunjukkan bahwa pengalaman praktik klinik yang didampingi oleh pembimbing yang kompeten berperan dalam pembentukan identitas profesional bidan. Lulusan yang mendapatkan pengalaman praktik berkualitas cenderung memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap standar profesi dan keselamatan klien (Martensson et al., 2019).

4. Implikasi terhadap Kesiapan Kerja dan Mutu Layanan

Implikasi pembelajaran praktik kebidanan terhadap kompetensi lulusan juga tercermin pada kesiapan kerja (*work readiness*) setelah lulus. Lulusan yang memperoleh pengalaman praktik klinik yang memadai dinilai lebih siap menghadapi tuntutan kerja, mampu beradaptasi dengan lingkungan pelayanan, serta menunjukkan kinerja awal yang lebih baik sebagai bidan pemula. Hal ini berdampak positif terhadap mutu pelayanan kebidanan dan keselamatan ibu dan bayi (McKellar et al., 2018 WHO, 2016).

Dengan demikian, pembelajaran praktik kebidanan memiliki implikasi strategis terhadap kualitas lulusan pendidikan kebidanan. Optimalisasi pembelajaran praktik menjadi kunci dalam menghasilkan bidan yang kompeten secara kognitif, terampil secara klinik, serta profesional dalam sikap dan perilaku. Penguatan pembelajaran praktik kebidanan secara berkelanjutan diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan mutu layanan kebidanan dan pencapaian tujuan kesehatan ibu dan anak secara global (WHO, 2016;ICM, 2019).

L. Simpulan

Pembelajaran dari praktik kebidanan melibatkan mahasiswa dalam situasi pelayanan nyata, pembelajaran praktik menjadi sarana utama untuk mengintegrasikan pengetahuan teoretis, keterampilan klinik, dan sikap profesional secara utuh dan kontekstual. Layanan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat praktik, tetapi juga sebagai lingkungan belajar autentik yang memungkinkan mahasiswa memahami kompleksitas asuhan kebidanan, karakteristik klien, serta dinamika kerja tim kesehatan. Pengalaman belajar di lahan praktik mendorong mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinik, komunikasi efektif, serta tanggung jawab profesional yang esensial dalam praktik kebidanan. Pembelajaran dari praktik kebidanan di layanan kesehatan memiliki kontribusi signifikan terhadap kesiapan lulusan dalam memberikan asuhan kebidanan yang aman, bermutu, dan berpusat pada kebutuhan perempuan. Optimalisasi pembelajaran praktik kebidanan dengan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi pada kompetensi menjadi landasan penting dalam pengembangan kualitas bidan dan peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

M. Referensi

- Cant R. P., & Cooper, S. J. (2017). Use of simulation-based learning in undergraduate nurse education: An umbrella systematic review. *Nurse Education Today*, 49, 63–71. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2016.11.015>
- International Confederation of Midwives. (2019). *Essential Competencies for Midwifery Practice*. The Hague: ICM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar Profesi Bidan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Knowles, M. S., Holton, E. F., & Swanson, R. A. (2015). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development* (8th ed.). Routledge..
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. New Jersey: Prentice Hall.

- Leap, N., Pairman, S., Homer, C., & Tracy, S. (2016). *Working with women: Midwifery philosophy and practice* (2nd ed.). Elsevier.
- Martensson, G., Löfmark, A., Mamhidir, A. G., & Skytt, B. (2019). Preceptors' reflections on clinical supervision in midwifery education. *Nurse Education in Practice*, 34, 125–131. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2018.11.009>
- McKellar L, Graham K, Anderson J. (2019). Clinical learning environments and preparation for practice in midwifery education. *Nurse Educ Pract*;34:117–22.
- McKellar, L., Pincombe, J., & Henderson, A. (2018). Insights from Australian midwifery graduates: What helped and hindered preparedness for practice. *Women and Birth*, 31(4), 281–287. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2017.10.003>
- O'Connor, M., Peters, K., & Jackson, D. (2018). The role of experiential learning in midwifery education. *Nurse Education in Practice*, 33, 92–98. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2018.09.002>
- Rahimah, H., Mufdlilah, M., & Hakimi, H. (2024). Strategy of clinical practice learning of midwifer of students: A scoping review. *Jurnal Kesehatan* (12(1), 434).
- Sweet L, Broadbent J. (2017). Midwifery students' perceptions of confidence and competence during clinical placement. *Women Birth*;30(3):e144–52.
- Sweet, L., & Glover, P. (2020). Optimising the clinical learning environment for undergraduate midwifery students. *Nurse Education Today*, 85, 104268. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.104268>
- World Health Organization. (2016). *Global standards for the education of midwives*. WHO.
- World Health Organization. (2016). *Midwifery Education Modules: Foundations of Midwifery*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2016). *Midwifery Educator Core Competencies*. WHO.
- Yang, Z., Zhang, F., Li, X., Mao, D., Lu, R., Zhang, L., Zhang, X., Feng, R., & Zhang, L. (2025). *Midwifery students' perceptions and learning experiences during clinical practice: A qualitative systematic review*. *JB I Evidence Synthesis*, 23(6), 1077–1149.
- Yuhanah, et al. (2024). *Pengantar Praktik Kebidanan*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

N. Glosarium

KEMENKES RI	= Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
IBI	= Ikatan Bidan Indonesia
ICM	= International Confederation of Midwives

WHO = World Health Organization

CHAPTER 3

PENGALAMAN PRAKTIK GIZI DALAM PELAYANAN KESEHATAN

(Annisa Ridlayanti, S.Keb.,Bd.,M.Keb)

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan yang bermutu tidak dapat dipisahkan dari peran gizi sebagai salah satu pilar utama dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Gizi berperan penting dalam mempertahankan status kesehatan individu, mempercepat proses penyembuhan, serta mencegah terjadinya komplikasi penyakit. Dalam praktik pelayanan kesehatan, intervensi gizi tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi, tetapi juga mencakup edukasi, konseling, serta pemantauan status gizi pasien secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya tenaga gizi, dituntut memiliki kompetensi yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Ponorogo, 2008).

Pengalaman praktik gizi dalam pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran calon tenaga kesehatan maupun tenaga gizi profesional. Melalui praktik langsung di fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, maupun komunitas, mahasiswa dan praktisi gizi dapat memahami secara komprehensif peran gizi dalam penanganan berbagai masalah kesehatan. Praktik ini memberikan gambaran nyata mengenai proses asuhan gizi, mulai dari pengkajian status gizi, penetapan diagnosis gizi, perencanaan intervensi, hingga evaluasi dan monitoring. Pengalaman tersebut juga memperlihatkan dinamika kerja tim kesehatan yang melibatkan berbagai profesi dalam memberikan pelayanan yang terintegrasi (Pratamawati, 2025).

Selain aspek teknis, praktik gizi dalam pelayanan kesehatan juga memberikan pengalaman berharga dalam menghadapi tantangan di lapangan. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya, perbedaan latar belakang sosial budaya pasien, tingkat pengetahuan gizi masyarakat yang beragam, serta kepatuhan pasien terhadap anjuran diet. Melalui pengalaman praktik, tenaga gizi belajar mengembangkan keterampilan komunikasi, empati, serta kemampuan *problem solving* agar intervensi gizi yang diberikan dapat diterima dan diterapkan secara optimal oleh pasien maupun keluarga (Pranoto, 2022).

Dengan demikian, pengalaman praktik gizi dalam pelayanan kesehatan memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk tenaga gizi yang kompeten, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan berbasis pengalaman memungkinkan terjadinya integrasi antara teori dan praktik, sehingga pelayanan gizi yang diberikan menjadi lebih efektif dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan pasien. Oleh karena itu, pengkajian dan dokumentasi pengalaman praktik gizi menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kualitas pelayanan kesehatan di masa mendatang (*Ismatulizah, 2025*).

B. Peran Tenaga Gizi dalam Pelayanan Kesehatan

Tenaga gizi memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan karena bertanggung jawab memastikan kebutuhan nutrisi pasien terpenuhi sesuai kondisi klinis dan fisiologisnya. Dalam praktik pelayanan, tenaga gizi tidak hanya berperan sebagai pelaksana diet, tetapi juga sebagai pendidik, konselor, serta bagian dari tim kesehatan multidisiplin yang terlibat dalam pengambilan keputusan klinis (Ayu et al., 2024).

Melalui pengalaman praktik, peran tenaga gizi terlihat nyata dalam upaya pencegahan penyakit, perbaikan status gizi, dan peningkatan kualitas hidup pasien. Keterlibatan aktif tenaga gizi dalam diskusi tim medis menunjukkan bahwa intervensi gizi merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang holistik dan berorientasi pada pasien (Andreasih, 2023).

C. Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) di Fasilitas Kesehatan

Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) menjadi pedoman utama dalam praktik pelayanan gizi di fasilitas kesehatan. Proses ini meliputi pengkajian status gizi, diagnosis gizi, intervensi gizi, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sesuai standar profesi (Sina et al., 2025).

Pengalaman praktik menunjukkan bahwa penerapan PAGT membantu tenaga gizi dalam memberikan pelayanan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan individu pasien. Dengan mengikuti alur PAGT, intervensi gizi menjadi lebih terarah, terdokumentasi dengan baik, serta dapat dievaluasi efektivitasnya secara objektif (Putri et al., 2024).

D. Pengalaman Praktik Gizi di Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan rawat jalan menjadi salah satu area praktik gizi yang menekankan pada konseling dan edukasi gizi. Pasien rawat jalan umumnya datang dengan kondisi penyakit kronis atau membutuhkan pengaturan pola makan jangka panjang,

sehingga peran tenaga gizi sangat penting dalam membantu pasien memahami dan menerapkan anjuran diet (Andreasih, 2023).

Dalam praktik, tantangan yang sering dihadapi adalah keterbatasan waktu konseling dan rendahnya kepatuhan pasien terhadap rekomendasi gizi. Pengalaman ini melatih tenaga gizi untuk menyampaikan informasi secara efektif, sederhana, dan disesuaikan dengan kondisi sosial serta tingkat pemahaman pasien (Ponorogo, 2008).

E. Pengalaman Praktik Gizi di Pelayanan Rawat Inap

Pada pelayanan rawat inap, praktik gizi berfokus pada pemantauan asupan makanan, penentuan diet terapi, serta evaluasi respons pasien terhadap intervensi gizi. Tenaga gizi bekerja sama dengan dokter dan perawat untuk memastikan diet yang diberikan sesuai dengan diagnosis medis dan kondisi klinis pasien (Putri et al., 2024).

Pengalaman praktik di rawat inap memperlihatkan pentingnya ketelitian dan koordinasi antarprofesi. Kesalahan kecil dalam pengaturan diet dapat berdampak pada proses penyembuhan pasien, sehingga praktik ini melatih tenaga gizi untuk bekerja secara profesional, teliti, dan bertanggung jawab (Ayu et al., 2024).

F. Praktik Gizi Masyarakat di Puskesmas dan Komunitas

Praktik gizi masyarakat menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif melalui kegiatan di puskesmas maupun komunitas. Kegiatan ini meliputi pemantauan status gizi, edukasi gizi seimbang, serta intervensi pada kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan lansia (Nisak et al., 2025).

Melalui pengalaman praktik, tenaga gizi memahami bahwa masalah gizi di masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini menuntut pendekatan yang adaptif dan partisipatif agar program gizi yang dilaksanakan dapat diterima dan berkelanjutan (Pratawati, 2025).

G. Edukasi dan Konseling Gizi dalam Pelayanan Kesehatan

Edukasi dan konseling gizi merupakan komponen penting dalam praktik pelayanan kesehatan karena bertujuan meningkatkan pengetahuan dan perubahan perilaku pasien. Tenaga gizi berperan dalam menyampaikan informasi gizi yang akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh pasien serta keluarga (Dewi et al., 2023).

Pengalaman praktik menunjukkan bahwa keberhasilan edukasi gizi tidak hanya ditentukan oleh materi, tetapi juga oleh kemampuan komunikasi tenaga gizi. Pendekatan yang empatik dan persuasif terbukti lebih efektif dalam mendorong pasien untuk menerapkan pola makan sehat sesuai anjuran (Widartika et al., 2024).

H. Tantangan dan Hambatan dalam Praktik Gizi Pelayanan Kesehatan

Dalam praktik pelayanan kesehatan, tenaga gizi sering menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sarana, jumlah tenaga yang tidak sebanding dengan beban kerja, serta rendahnya kesadaran pasien terhadap pentingnya gizi. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan (Putri et al., 2024).

Pengalaman menghadapi hambatan tersebut menjadi proses pembelajaran yang penting bagi tenaga gizi. Praktik ini melatih kemampuan adaptasi, kreativitas, dan pengambilan keputusan agar pelayanan gizi tetap berjalan optimal meskipun dalam kondisi terbatas (Ismatulizah, 2025).

I. Penerapan Evidence-Based Nutrition Practice

Evidence-based nutrition practice menekankan penggunaan bukti ilmiah terbaru dalam pengambilan keputusan asuhan gizi. Dalam praktik pelayanan kesehatan, tenaga gizi dituntut untuk mengintegrasikan hasil penelitian, pedoman klinis, dan kondisi individual pasien. Pengalaman praktik menunjukkan bahwa penerapan pendekatan berbasis bukti meningkatkan kualitas intervensi gizi dan kepercayaan tim medis terhadap rekomendasi yang diberikan. Hal ini juga mendorong tenaga gizi untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan profesionalnya (Marshall et al., 2017).

Evidence-Based Nutrition Practice (EBNP) merupakan pendekatan praktik gizi yang didasarkan pada integrasi antara bukti ilmiah terbaik (*best available evidence*), keahlian klinis tenaga gizi, dan nilai serta kondisi pasien dalam pengambilan keputusan pelayanan gizi (Laville et al., 2017).

1. Identifikasi Masalah Gizi. Dalam praktik pelayanan kesehatan ibu dan anak, penerapan EBNP dimulai dengan :
 - a. Melakukan asesmen gizi komprehensif (antropometri, biokimia, klinis, dan riwayat diet).
 - b. Mengidentifikasi masalah seperti anemia pada ibu hamil, KEK, stunting, atau gizi kurang pada balita.
 - c. Merumuskan diagnosis gizi menggunakan pendekatan *Nutrition Care Process* (NCP).
2. Pencarian dan Evaluasi Bukti Ilmiah
 - a. Mengacu pada Pedoman Gizi Seimbang, PMK terkait gizi ibu dan anak, serta rekomendasi WHO dan Kemenkes RI.
 - b. Menggunakan literatur ilmiah seperti jurnal penelitian dan guideline praktik klinis.
 - c. Memilih intervensi yang telah terbukti efektif berdasarkan penelitian terbaru.

Contoh:

Pada ibu hamil dengan anemia, intervensi didasarkan pada bukti bahwa suplementasi zat besi dan edukasi konsumsi makanan tinggi zat besi efektif meningkatkan kadar hemoglobin. Studi ini dapat dilaksanakan melalui studi literature atau literature review.

3. Implementasi Intervensi Berbasis Bukti. Intervensi yang dilakukan meliputi :
 - a. Konseling gizi sesuai kebutuhan individu.
 - b. Edukasi mengenai pola makan seimbang dan MP-ASI sesuai rekomendasi usia.
 - c. Monitoring kepatuhan konsumsi tablet tambah darah.
 - d. Penyusunan rencana makan yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi pasien.

Pendekatan ini memastikan bahwa tindakan yang diberikan tidak hanya berdasarkan kebiasaan, tetapi berdasarkan penelitian yang telah teruji.

4. Monitoring dan Evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan :
 - a. Memantau perubahan berat badan, LILA, atau grafik pertumbuhan.
 - b. Mengevaluasi perubahan perilaku makan.
 - c. Menilai hasil laboratorium (jika tersedia).
 - d. Melakukan tindak lanjut untuk memastikan keberhasilan intervensi.
5. Refleksi Praktik. Penerapan EBNP membantu dalam hal :
 - a. Mengambil keputusan secara rasional dan ilmiah.
 - b. Memberikan pelayanan yang aman dan efektif.
 - c. Meningkatkan kualitas asuhan gizi.
 - d. Menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan dan preferensi pasien.

Dengan menerapkan *Evidence-Based Nutrition Practice*, pelayanan gizi pada ibu dan anak menjadi lebih terarah, sistematis, dan berkualitas, sehingga dapat mendukung perbaikan status gizi secara optimal (Beseler, 2017).

J. Pengalaman Praktik Gizi dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Pelayanan gizi pada ibu dan anak merupakan prioritas dalam sistem kesehatan karena berpengaruh langsung terhadap kualitas generasi mendatang. Praktik gizi pada kelompok ini mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, serta pencegahan masalah gizi pada bayi dan balita. Melalui pengalaman praktik, tenaga gizi memahami pentingnya intervensi dini dalam mencegah stunting dan masalah gizi lainnya. Pendekatan edukatif dan berkelanjutan kepada ibu dan keluarga menjadi kunci keberhasilan pelayanan gizi ibu dan anak. (Dewi et al., 2023).

Berikut contoh Pengalaman Praktik Gizi dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak : Selama praktik di fasilitas pelayanan kesehatan (puskesmas/rumah

sakit/klinik), sebagai bagian dari upaya peningkatan status gizi dan pencegahan masalah gizi diantaranya adalah :

1. Pelayanan Gizi pada Ibu Hamil

- a. Skrining status gizi melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, LILA (Lingkar Lengan Atas), dan perhitungan IMT.
- b. Identifikasi risiko KEK (Kekurangan Energi Kronis) dan anemia.
- c. Konseling gizi terkait kebutuhan energi dan zat gizi selama kehamilan (zat besi, asam folat, protein, kalsium).
- d. Edukasi mengenai pola makan seimbang, pencegahan anemia, serta pentingnya konsumsi tablet tambah darah.

Dari kegiatan ini, pentingnya komunikasi efektif agar ibu hamil memahami kebutuhan gizinya dan mampu menerapkan pola makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pelayanan Gizi pada Ibu Menyusui.

- a. Memberikan edukasi tentang kebutuhan energi tambahan selama menyusui.
- b. Menjelaskan pentingnya ASI eksklusif selama 6 bulan.
- c. Memberikan konseling mengenai makanan bergizi untuk mendukung produksi ASI.

Dukungan emosional dan informasi yang tepat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemberian ASI.

3. Pelayanan Gizi pada Bayi dan Balita

- a. Penimbangan dan pemantauan pertumbuhan menggunakan KMS.
- b. Identifikasi masalah gizi seperti stunting, wasting, dan underweight.
- c. Edukasi kepada orang tua tentang MP-ASI sesuai usia, frekuensi makan, tekstur, dan variasi makanan.
- d. Penyuluhan tentang pola makan gizi seimbang untuk balita.

Peran keluarga sangat penting dalam membentuk kebiasaan makan anak.

K. Refleksi Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi Profesional

Refleksi pengalaman praktik gizi memberikan kesempatan bagi tenaga gizi untuk mengevaluasi kemampuan, sikap, dan keterampilan yang telah diperoleh. Proses ini membantu mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan dalam praktik pelayanan kesehatan (Widartika et al., 2024).

Pengalaman praktik secara keseluruhan berkontribusi besar dalam pembentukan kompetensi profesional tenaga gizi. Integrasi antara teori dan praktik menjadikan tenaga gizi lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja serta mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berorientasi pada pasien (Evtiasari et al., 2024).

Pengalaman praktik gizi yang didapatkan dimulai dengan melakukan asesmen gizi secara komprehensif, memberikan konseling gizi yang sesuai dengan kondisi pasien, bekerja sama dalam tim tenaga Kesehatan dan mengedukasi masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami (Marshall et al., 2017).

Praktik gizi memberikan pemahaman bahwa pelayanan gizi pada ibu dan anak merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan masalah gizi sejak dini dan mendukung tumbuh kembang optimal anak (Nur'aisah, 2024).

L. Simpulan

Pengalaman praktik gizi dalam pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam pembentukan kompetensi tenaga gizi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Melalui praktik langsung di berbagai tatanan pelayanan kesehatan, tenaga gizi memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran strategis gizi dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Integrasi antara pengetahuan teoretis dan pengalaman lapangan memungkinkan penerapan asuhan gizi yang lebih efektif, terstandar, serta sesuai dengan kondisi klinis dan sosial budaya pasien.

Praktik gizi juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antarprofesi dalam sistem pelayanan kesehatan. Keterlibatan tenaga gizi dalam tim kesehatan berkontribusi terhadap pengambilan keputusan klinis yang lebih holistik dan berbasis bukti. Selain itu, pengalaman praktik melatih kemampuan komunikasi, edukasi, dan konseling gizi yang menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan pasien serta keberhasilan intervensi gizi.

Di sisi lain, berbagai tantangan yang dihadapi selama praktik, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya kesadaran gizi masyarakat, menjadi proses pembelajaran yang berharga. Tantangan tersebut mendorong tenaga gizi untuk mengembangkan sikap profesional, kemampuan adaptasi, serta penerapan evidence-based nutrition practice guna meningkatkan mutu pelayanan. Dengan demikian, pengalaman praktik gizi dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

M. Referensi

- Andreasih, C. (2023). *Implementasi Program Gizi Pada Layanan Posyandu Balita Puskesmas Mulyorejo Tahun 2023*.
- Artikel, I. (2024). *Pelayanan gizi, Mutu Pelayanan, kepuasan pasien*. 3(2), 97–104.
- Ayu, I., Genta, P., Ayu, I., Idyani, M., & Denpasar, P. K. (2024). *Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan melalui Puskesmas Keliling*.

Pengalaman di UPT Puskesmas Tembuku I dalam Mengatasi Stunting dan Penyakit Lingkungan. 03(02), 172–185.

- Beseler, L. (2017). A Year Later : Lessons Learned. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 117(5), 661–662. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2017.02.017>
- Dewi, K., Azis, A. A., Fitria, R., & Palupi, F. H. (2023). *Promosi Kesehatan dan Penyuluhan Gizi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan. 1(03), 171–183.* <https://doi.org/10.58812/ejincs.v1.i03>
- DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/sf16300h> Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pelayanan Gizi di Rumah Sakit Ismatulizah. (2025). 16(September), 651–660.
- Evtiasari, E., Nuzuliana, R., & Kesehatan, F. I. (2024). *Jurnal Kesehatan Mercusuar. 7(2), 9–18.*
- Gizi, P. (2025). *JGK-Vol.17, No.1 Januari 2025. 17(1), 9–17.*
- Laville, M., Segrestin, B., Alligier, M., Ruano-rodríguez, C., Serra-majem, L., Hiesmayr, M., Schols, A., Vecchia, C. La, Boirie, Y., Rath, A., & Neugebauer, E. A. M. (2017). *Evidence-based practice within nutrition : what are the barriers for improving the evidence and how can they be dealt with ? 1–9.* <https://doi.org/10.1186/s13063-017-2160-8>
- Marshall, T. A., Buren, J. M. Van, Warren, J. J., & Cavanaugh, J. E. (2017). *Practice applications 661 665. 117(5).* [https://doi.org/10.1016/S2212-2672\(17\)30306-4](https://doi.org/10.1016/S2212-2672(17)30306-4)
- Nisak, U. K., Yulianto, M. R., & Natasha, N. I. (2025). *Dari Pengetahuan ke Perilaku : Transformasi Gizi Sehat Remaja melalui Program Edukasi Berbasis Komunitas Pendahuluan. 5(4), 3232–3239.*
- Ponorogo, H. (2008). *EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL GIZI DI INSTALASI GIZI RSUD. 591–600.*
- Pranoto, Y. A. (2022). *Persepsi ahli gizi di Indonesia terhadap penerapan nutritional care process (NCP) di rumah sakit. 19(1), 21–28.* <https://doi.org/10.22146/ijcn.67934>
- Putri, S. S., Yunita, J., Ismainar, H., & Rienarti, A. (2024). *KEPUASAN PASIEN DI RS AWAL BROS PANAM PEKANBARU TAHUN 2024. 8, 6115–6126.*
- Sina, I., Hospital, R., & Regency, G. (2025). *Ghidza : Jurnal Gizi dan Kesehatan Capaian Standar Pelayanan Minimal Gizi pada Pasien Rawat Inap Ruang Ixia di RSUD Ibnu Sina Kabupaten Gresik. 9(1), 141–149.*
- Urgensi, A., Pendidikan, K., Berbasis, G., & Kuliner, P. (2024). *BAB IV Strategi Pendidikan Gizi Kuliner (Culinary Nutrition Education) Berbasis Praktik : Pendekatan Teori Dan Aplikasi. 52–75.*

N. Glosarium

WUS = Wanita Usia Subur

PAGT = Asuhan Gizi Terstandar PAGT

EBNP = Evidence-Based Nutrition Practice

NCP = Nutrition Care Process

KEK = Kurang Energi Kronis

CHAPTER 4

REFELKSI ETIKA DAN REFLEKSI ETIKA DAN PROFESIONALISME DALAM PRAKTIK KESEHATAN

(Anita Setyowati, M.Tr.Kep)

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan pada dasarnya tidak semata-mata menuntut keterampilan klinis dan penguasaan ilmu pengetahuan, melainkan juga integritas moral yang melekat dalam setiap tindakan tenaga kesehatan. Profesionalisme dalam praktik kesehatan merupakan perpaduan antara sikap, perilaku, komitmen, serta tanggung jawab etis yang diarahkan untuk menjamin keselamatan pasien, menjunjung keadilan dalam pemberian layanan, dan menghormati martabat manusia (Celerio et al., 2025). Profesionalisme tidak hanya diukur dari kecakapan teknis, tetapi juga dari kemampuan tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan prinsip etika.

Perkembangan teknologi di era transformasi digital turut mengubah lanskap praktik kesehatan menjadi semakin kompleks. Pemanfaatan rekam medis elektronik, layanan telemedicine, dan sistem informasi kesehatan telah meningkatkan efisiensi sekaligus memperluas akses pelayanan. Namun demikian, kemajuan tersebut juga menghadirkan persoalan etis baru, terutama terkait dengan perlindungan kerahasiaan data pasien, keamanan informasi, serta batas profesional dalam interaksi berbasis digital. Perawat dan tenaga kesehatan lainnya kerap menghadapi dilema antara optimalisasi penggunaan teknologi dan kewajiban menjaga privasi serta hak pasien (Yang & Jang, 2025). Kondisi ini menuntut kejelasan pedoman etika sekaligus kemampuan reflektif dalam merespons dinamika perubahan yang terjadi.

Di samping perkembangan teknologi, konsistensi dalam menjalankan etika profesi memegang peranan krusial dalam mencegah konflik maupun sengketa medik. Berbagai persoalan hukum dan ketegangan antara tenaga kesehatan dan pasien kerap bermula dari komunikasi yang kurang efektif, minimnya transparansi, atau perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak (Fitira & Subekti, 2025). Karena itu, praktik profesional yang beretika menuntut adanya komunikasi yang empatik, penyampaian informasi yang terbuka, serta penghormatan terhadap otonomi pasien sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan.

Nilai etika juga tidak hanya penting dalam ranah praktik klinis, tetapi menjadi landasan utama dalam proses pendidikan tenaga kesehatan. Pendidikan yang menanamkan kejujuran, tanggung jawab, empati, dan akuntabilitas akan membentuk kultur profesional yang kokoh sejak dini. Dengan pembekalan etika yang memadai, lulusan bidang kesehatan diharapkan tidak hanya memiliki kompetensi klinis, tetapi juga kesiapan moral untuk menghadapi berbagai dilema dengan pertimbangan yang arif dan matang.

Oleh karena itu, praktik kesehatan perlu dipahami sebagai profesi yang menuntut keseimbangan antara kecakapan teknis dan kematangan moral. Penghayatan terhadap nilai etika dan profesionalisme bukanlah sesuatu yang terbentuk secara instan, melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan refleksi diri secara terus-menerus. Melalui refleksi tersebut, karakter profesional tenaga kesehatan dapat tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, adaptif terhadap perubahan, serta senantiasa berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan pasien (Situmorang et al., 2025).

B. Konsep Dasar Etika dalam Praktik Kesehatan

Etika dalam praktik kesehatan merupakan cabang filsafat yang menelaah prinsip-prinsip moral sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam bersikap dan mengambil keputusan ketika memberikan pelayanan kepada pasien maupun masyarakat. Melalui etika, tenaga kesehatan diarahkan untuk mampu menilai tindakan yang tepat dan yang tidak tepat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai dasar seperti otonomi, beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak merugikan), serta keadilan dalam setiap tindakan klinis (Fitira & Subekti, 2025).

Dalam praktik kesehatan kontemporer, etika tidak lagi dipahami sebatas norma moral pribadi, melainkan mencakup tanggung jawab profesional, penghormatan terhadap hak-hak pasien, serta kepekaan terhadap konteks sosial dan budaya yang melingkupi pelayanan. Prinsip-prinsip moral tersebut menjadi pijakan dalam menentukan keputusan dan tindakan yang menjunjung martabat manusia serta menjamin keselamatan pasien. Dengan demikian, etika berperan sebagai kerangka konseptual yang membimbing tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi kompleks yang kerap tidak memiliki jawaban tunggal atau mutlak.

Dalam praktik klinis, terdapat sejumlah prinsip etika dasar yang universal dan menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan etis, yaitu:

1. Otonomi (Autonomy)

Menghormati hak individu untuk membuat keputusan tentang dirinya sendiri berdasarkan informasi yang lengkap dan tanpa paksaan.

2. *Beneficence* dan *Non-maleficence*

Tenaga kesehatan berkewajiban untuk melakukan kebaikan dan mencegah kerugian bagi pasien, serta mengambil tindakan yang memberikan manfaat maksimal. Prinsip ini menuntut tenaga kesehatan memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan pasien.

3. Keadilan (Justice)

Etika menuntut agar pelayanan kesehatan diberikan secara adil tanpa diskriminasi dan bias terhadap latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau budaya pasien.

4. Fidelity dan Akuntabilitas

Profesional kesehatan harus menjaga kepercayaan, integritas, serta bertanggung jawab secara moral atas tindakan dan hasil pelayanan yang diberikan. Prinsip-prinsip ini berakar pada filosofi moral yang diterapkan dalam bioetika kontemporer serta dikembangkan melalui pengalaman praktik dan refleksi kritis.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka normatif dalam menghadapi dilema moral yang sering muncul dalam konteks klinik dan organisasi pelayanan kesehatan.

Etika dalam praktik kesehatan merupakan fondasi utama yang menentukan arah perilaku profesional dan kualitas pengambilan keputusan dalam pelayanan medis maupun keperawatan. Setiap tindakan klinis pada dasarnya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ilmiah, tetapi juga pada pertimbangan moral yang mengatur hubungan antara tenaga kesehatan, pasien, dan masyarakat. Dalam konteks ini, etika menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak individu, tanggung jawab sosial profesi, serta kewajiban moral untuk mencegah cedera, memberikan manfaat, dan menjunjung keadilan. Kerangka nilai tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan tindakan klinis, komunikasi antarprofesi, maupun interaksi langsung dengan pasien dalam berbagai situasi pelayanan. Oleh karena itu, pemahaman etika tidak dapat dipisahkan dari kemampuan tenaga kesehatan untuk menimbang aspek moral, kebutuhan klinis, dan dinamika sosial secara proporsional, khususnya ketika menghadapi situasi yang kompleks atau dilematis.

Secara konseptual, etika pelayanan kesehatan bertumpu pada sejumlah prinsip dasar yang telah lama menjadi rujukan dalam praktik profesional, yakni otonomi, beneficence, non-maleficence, dan keadilan. Prinsip otonomi menegaskan bahwa pasien berhak menentukan pilihan atas dirinya setelah memperoleh informasi yang memadai dan dapat dipahami. Prinsip beneficence dan non-maleficence

mengarahkan tenaga kesehatan untuk mengupayakan tindakan yang memberi manfaat terbesar sekaligus meminimalkan risiko atau kerugian. Sementara itu, prinsip keadilan menuntut agar pelayanan diberikan secara setara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun keyakinan pasien. Berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa penguatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip tersebut dalam pendidikan kesehatan berperan penting dalam membentuk kepekaan moral dan konsistensi perilaku profesional, sehingga praktik pelayanan tetap selaras dengan nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat (Danacı & Erdoğan, 2025).

Etika dalam pelayanan kesehatan tidak berhenti pada tataran teori atau norma yang bersifat abstrak, melainkan berfungsi sebagai sarana refleksi yang membantu tenaga kesehatan menilai kembali praktik yang mereka jalankan. Dalam realitas pelayanan yang terus berubah, standar moral dan tuntutan profesional pun ikut berkembang. Kemajuan teknologi, seperti penggunaan rekam medis elektronik, telemedicine, dan sistem pengelolaan data pasien, menghadirkan persoalan etis baru yang tidak selalu dapat dijawab dengan pendekatan konvensional. Kondisi ini menuntut kemampuan reflektif yang lebih matang agar setiap keputusan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap martabat pasien dan mutu pelayanan. Melalui evaluasi kritis terhadap praktik sehari-hari, tenaga kesehatan dapat menilai kesesuaian tindakan mereka dengan nilai etik yang dianut, sekaligus membuka ruang dialog antarprofesi untuk mencapai kesepakatan dalam situasi yang kompleks dan beragam.

Di sisi lain, etika juga berperan dalam membentuk karakter dan budaya profesional di lingkungan organisasi pelayanan kesehatan. Institusi yang secara konsisten mengintegrasikan nilai etika ke dalam visi, misi, kebijakan, serta program pengembangan sumber daya manusia cenderung menghasilkan tenaga kesehatan yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki komitmen moral yang kuat. Budaya organisasi yang berlandaskan etika akan memperkuat integritas individu, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta menciptakan suasana kerja yang saling menghargai. Dalam perkembangan pemikiran etika klinis saat ini, integrasi nilai moral tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran formal, tetapi juga melalui diskusi kasus, refleksi praktik, dan dukungan struktural seperti keberadaan komite etik klinis. Pendekatan ini membantu tenaga kesehatan menghadapi dilema moral yang kompleks secara lebih sistematis dan bertanggung jawab.

Dalam praktik klinis sehari-hari, tenaga kesehatan kerap menghadapi situasi yang tidak dapat dinilai secara sederhana sebagai benar atau salah. Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu terapi, menyampaikan kabar mengenai prognosis yang kurang baik, maupun menyeimbangkan harapan keluarga dengan

hak otonomi pasien merupakan contoh kondisi yang sarat pertimbangan moral. Dalam konteks seperti ini, kemampuan menalar secara etis menjadi bagian tak terpisahkan dari kompetensi profesional, sejajar dengan keterampilan teknis dan pengetahuan klinis. Di samping itu, etika dalam praktik kesehatan berkaitan langsung dengan tanggung jawab profesional dan akuntabilitas. Setiap intervensi klinis tidak hanya berdampak secara medis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan moral yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, komunikasi yang jujur dan terbuka, pencatatan medis yang lengkap dan akurat, serta kesediaan untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan menjadi bagian penting dari praktik yang etis.

Arus globalisasi dan meningkatnya keberagaman budaya di masyarakat memperluas cakupan persoalan etika dalam pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan tidak lagi hanya berhadapan dengan variasi kondisi klinis, tetapi juga dengan perbedaan nilai, keyakinan, dan preferensi yang memengaruhi cara pasien memaknai sakit dan pengobatan. Tindakan yang secara medis dinilai tepat belum tentu sejalan dengan latar belakang budaya atau spiritual pasien. Karena itu, pendekatan etika mutakhir menekankan pentingnya *cultural humility*, yakni sikap rendah hati dan terbuka dalam memahami perbedaan tanpa mengesampingkan standar profesional. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kompetensi budaya yang baik berkontribusi pada peningkatan kepuasan pasien sekaligus mengurangi potensi konflik dalam proses pelayanan.

Di samping dimensi interpersonal, etika dalam praktik kesehatan juga berkaitan dengan kebijakan publik dan pengelolaan sumber daya. Dalam situasi keterbatasan, seperti krisis kesehatan atau wabah penyakit, tenaga kesehatan dan pengambil kebijakan dihadapkan pada keputusan sulit mengenai prioritas layanan dan distribusi fasilitas yang tersedia. Pada kondisi tersebut, prinsip keadilan distributif menjadi landasan penting agar keputusan diambil secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Pengalaman pandemi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya kerangka etika publik yang jelas untuk mendukung keputusan klinis maupun kebijakan kesehatan yang adil dan transparan (Emanuel et al., 2020). Hal ini menegaskan bahwa etika tidak hanya bekerja pada tingkat individu dalam interaksi klinis, tetapi juga pada tingkat sistem yang mengatur pelayanan kesehatan secara luas.

Pada akhirnya, pemahaman etika dalam praktik kesehatan tidak cukup berhenti pada penguasaan teori, tetapi menuntut perpaduan antara wawasan moral, kemampuan refleksi, dan komitmen profesional yang terus dipelihara. Nilai-nilai etika tidak terbentuk secara instan, melainkan berkembang melalui proses pendidikan formal, bimbingan di lahan praktik, pengalaman klinis, serta kebiasaan

melakukan evaluasi diri. Tenaga kesehatan yang terbiasa menelaah kembali keputusan dan tindakannya secara kritis akan lebih mampu menyadari konsekuensi moral dari setiap langkah yang diambil.

Dengan demikian, etika bukan sekadar pelengkap profesionalisme, melainkan landasan yang membentuk cara berpikir dan bertindak seorang tenaga kesehatan. Melalui etika, profesionalisme memperoleh makna yang lebih dalam sebagai komitmen untuk menghormati martabat manusia, menegakkan keadilan, dan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dalam praktik pelayanan kesehatan.

C. Profesionalisme dalam Pelayanan Kesehatan

Profesionalisme dalam pelayanan kesehatan merupakan landasan penting bagi terselenggaranya layanan yang bermutu, aman, dan berfokus pada kebutuhan pasien. Profesionalisme tidak sebatas ketaatan terhadap standar prosedur atau regulasi, melainkan mencerminkan sejauh mana nilai dan komitmen moral dihayati dalam praktik sehari-hari. Di dalamnya terkandung unsur integritas, tanggung jawab, empati, kemampuan berkomunikasi secara efektif, serta kesediaan untuk terus mengembangkan kompetensi. Dalam sistem pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, profesionalisme berperan besar dalam membentuk hubungan terapeutik yang saling percaya antara tenaga kesehatan dan pasien, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pelayanan kesehatan (Farooq et al., 2025).

Secara konseptual, profesionalisme mencakup rangkaian nilai, sikap, dan perilaku yang menunjukkan komitmen terhadap standar etika dan mutu layanan. Kompetensi teknis memang menjadi prasyarat penting, namun tidak cukup untuk mencerminkan profesionalisme secara utuh. Sikap empatik, kejujuran dalam menyampaikan informasi, akuntabilitas terhadap tindakan klinis, serta kemampuan bekerja sama dalam tim interprofesional merupakan bagian integral dari perilaku profesional dalam praktik kesehatan.

Dalam praktik klinis, profesionalisme tercermin melalui sikap hormat terhadap otonomi pasien, pemberian informasi yang jujur dan transparan, serta pengambilan keputusan berbasis bukti ilmiah. Sikap profesional juga tercermin dari kemampuan menjaga batas relasi terapeutik secara proporsional dan menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, sehingga integritas pelayanan tetap terjaga.

Seiring perkembangannya, profesionalisme tidak hanya dipahami sebagai seperangkat perilaku yang terlihat, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan identitas profesional. Profesionalisme dapat dikenali dari aspek yang tampak, seperti pola komunikasi, kepatuhan terhadap kode etik, dan tanggung jawab dalam

menjalankan praktik. Namun, identitas profesional menyentuh dimensi yang lebih mendalam, yakni cara individu memaknai perannya sebagai bagian dari profesi dengan nilai, norma, dan tanggung jawab sosial tertentu. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa profesionalisme dan identitas profesional berkembang secara bertahap melalui proses pendidikan dan pengalaman klinis yang berkelanjutan (Farooq et al., 2025). Proses ini dipengaruhi oleh pengalaman belajar, budaya organisasi, serta peran pembimbing sebagai teladan profesional.

Profesionalisme dalam pelayanan kesehatan menuntut penguasaan kompetensi klinis yang senantiasa diperbarui sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Tenaga kesehatan yang profesional tidak berhenti pada capaian pendidikan formal, tetapi secara aktif mengikuti pendidikan berkelanjutan, pelatihan, dan pembaruan praktik berbasis bukti. Penguasaan keterampilan teknis perlu berjalan seiring dengan kepekaan etis dan kecakapan komunikasi interpersonal. Dalam praktik sehari-hari, profesionalisme tampak melalui kemampuan menyampaikan informasi medis secara jelas dan jujur, menghormati pilihan pasien, serta menjaga kerahasiaan data kesehatan. Sikap tersebut tidak hanya mencerminkan integritas pribadi, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap keselamatan dan kepuasan pasien (Hapsari et al., 2023).

Dengan demikian, profesionalisme dalam pelayanan kesehatan bukanlah konsep yang statis, melainkan proses dinamis yang berkembang seiring pengalaman dan refleksi praktik. Profesionalisme menjadi jembatan antara kompetensi klinis dan tanggung jawab moral, serta menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan. Melalui pendidikan yang terstruktur, pembinaan berkelanjutan, serta refleksi kritis terhadap praktik sehari-hari, tenaga kesehatan diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme sebagai identitas dan komitmen utama dalam melayani masyarakat.

D. Dilema Etika dan Pengambilan Keputusan Klinis

Dilema etika dalam praktik kesehatan merupakan situasi ketika tenaga kesehatan dihadapkan pada dua atau lebih pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi moral, sehingga keputusan yang diambil berpotensi menimbulkan dampak etis tertentu. Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, dilema etika tidak hanya muncul pada kasus yang kompleks seperti penghentian terapi atau penentuan prioritas tindakan, tetapi juga dalam situasi sehari-hari seperti komunikasi prognosis, persetujuan tindakan medis, hingga kerahasiaan informasi pasien. Kompleksitas ini menuntut tenaga kesehatan untuk tidak hanya

mengandalkan pengetahuan klinis, tetapi juga kemampuan analisis moral yang matang dan reflektif.

Dalam praktik klinis, dilema etika sering kali berkaitan dengan benturan antara prinsip otonomi pasien dan kewajiban profesional untuk memberikan manfaat terbaik. Misalnya, ketika pasien menolak tindakan yang secara medis dianggap menyelamatkan nyawa, tenaga kesehatan menghadapi konflik antara menghormati keputusan pasien dan prinsip beneficence. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa konflik semacam ini kerap dipengaruhi oleh faktor komunikasi, tingkat pemahaman pasien, serta dinamika keluarga dalam pengambilan keputusan (Sucy et al., 2025). Situasi tersebut menegaskan bahwa dilema etika tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam konteks sosial, budaya, dan hukum yang turut memengaruhi proses keputusan klinis.

Pengambilan keputusan klinis yang etis memerlukan pendekatan sistematis yang mempertimbangkan aspek medis, nilai moral, regulasi hukum, serta standar profesi. Dalam konteks Indonesia, harmonisasi antara etika profesi dan aspek hukum kesehatan menjadi perhatian penting, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini menegaskan bahwa tenaga kesehatan yang bekerja sesuai standar profesi dan prosedur operasional memperoleh perlindungan hukum, namun tetap bertanggung jawab secara etik apabila terjadi pelanggaran (Abdullah & Binarsa, 2025).

Dilema etika juga dapat muncul akibat keterbatasan sumber daya pelayanan kesehatan. Dalam situasi tertentu, tenaga kesehatan harus menentukan prioritas tindakan ketika jumlah pasien tidak sebanding dengan fasilitas atau tenaga yang tersedia. Keputusan semacam ini menuntut penerapan prinsip keadilan distributif secara proporsional dan transparan. Kajian di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi profesionalisme tenaga kesehatan berkaitan erat dengan kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang adil dan bertanggung jawab dalam kondisi tekanan sistem (Hapsari et al., 2023). Hal ini memperlihatkan bahwa profesionalisme dan kompetensi etika merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam proses pengambilan keputusan klinis.

Selain faktor eksternal, aspek internal seperti moral distress juga berpengaruh terhadap kualitas keputusan klinis. Moral distress terjadi ketika tenaga kesehatan mengetahui tindakan yang secara etis dianggap benar, tetapi terhambat oleh kebijakan institusi, tekanan hierarki, atau keterbatasan sumber daya. Kondisi ini dapat menimbulkan stres psikologis dan berdampak pada kualitas pelayanan. Penelitian mengenai profesionalisme perawat di rumah sakit Indonesia menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan dukungan organisasi berpengaruh terhadap konsistensi penerapan nilai etik dalam praktik

Dalam konteks sosial budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kolektivisme, dilema etika sering kali melibatkan keluarga sebagai pengambil keputusan utama. Kondisi ini dapat menimbulkan ketegangan antara prinsip otonomi individu dan nilai kekeluargaan. Tenaga kesehatan perlu menunjukkan sensitivitas budaya agar proses pengambilan keputusan tetap menghormati hak pasien sekaligus mempertimbangkan dinamika sosial yang ada. Kompetensi budaya, dalam hal ini, menjadi bagian dari kompetensi etika yang tidak dapat dipisahkan dari praktik profesional.

Tekanan administratif dan target pelayanan juga berpotensi memengaruhi objektivitas pertimbangan klinis. Beban kerja tinggi, keterbatasan waktu, dan tuntutan efisiensi dapat mengurangi ruang refleksi moral dalam praktik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengambilan keputusan etis memerlukan dukungan sistem melalui pelatihan berkelanjutan, supervisi klinis, serta pembentukan komite etik di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengembangan area etika, moral, dan mediko-legal dalam kurikulum berbasis kompetensi juga menjadi strategi penting untuk membekali mahasiswa kesehatan menghadapi kompleksitas praktik nyata (Sarjana P et al., 2022).

Dalam pendidikan kesehatan, pembelajaran berbasis kasus (case-based learning) dan diskusi etik terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis dilema klinis. Penguatan area etika, moral, dan mediko-legal dalam kurikulum berbasis kompetensi menjadi strategi penting untuk mempersiapkan calon tenaga kesehatan menghadapi kompleksitas praktik nyata. Proses refleksi terhadap pengalaman klinis juga membantu mahasiswa mengembangkan identitas profesional yang peka terhadap implikasi moral setiap tindakan (Silaban et al., 2025).

E. Refleksi Praktik dan Pengembangan Karakter Profesional

Refleksi praktik merupakan proses intelektual dan moral yang memungkinkan tenaga kesehatan meninjau kembali pengalaman klinis yang telah dijalani untuk memahami makna, nilai, serta implikasi etis dari setiap tindakan yang dilakukan. Dalam pelayanan kesehatan, refleksi bukan sekadar evaluasi teknis terhadap keberhasilan prosedur, melainkan proses mendalam untuk menilai apakah keputusan dan perilaku profesional telah selaras dengan prinsip etika, standar profesi, serta martabat pasien. Melalui refleksi, tenaga kesehatan belajar dari pengalaman, memperbaiki kekurangan, dan menguatkan komitmen moral dalam praktik berikutnya.

Dalam konteks profesionalisme, refleksi praktik berfungsi sebagai mekanisme pembentukan identitas profesional. Identitas profesional terbentuk melalui integrasi

antara pengetahuan ilmiah, keterampilan klinis, nilai moral, dan pengalaman nyata di lapangan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang menekankan refleksi etik dalam pendidikan kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran moral mahasiswa serta kesiapan menghadapi dilema klinis. Hal ini menunjukkan bahwa refleksi bukan aktivitas tambahan, melainkan bagian integral dari pembentukan karakter tenaga kesehatan yang profesional.

Pengembangan karakter profesional juga berkaitan erat dengan nilai integritas, tanggung jawab, empati, dan akuntabilitas. Karakter profesional tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui pembiasaan sikap dan keputusan yang konsisten dalam berbagai situasi klinis. Studi mengenai profesionalisme tenaga kesehatan di Indonesia menunjukkan bahwa dukungan lingkungan kerja dan budaya organisasi yang etis memperkuat konsistensi perilaku profesional dalam praktik sehari-hari. Pengembangan karakter profesional tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga institusi pelayanan kesehatan.

Refleksi praktik juga membantu tenaga kesehatan menghadapi fenomena moral distress yang muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara nilai moral pribadi dengan kebijakan atau kondisi sistem pelayanan. Dalam situasi seperti ini, refleksi menjadi sarana untuk mengelola tekanan emosional sekaligus mempertahankan integritas profesional. Melalui diskusi etik, supervisi klinis, dan pembimbingan oleh senior, tenaga kesehatan dapat mengembangkan ketahanan moral yang mendukung keberlanjutan praktik profesional. Kajian literatur mengenai profesionalisme mahasiswa keperawatan di Indonesia menunjukkan bahwa pembimbing klinik memiliki peran signifikan dalam membentuk sikap reflektif dan perilaku profesional (Hapsari et al., 2023).

Di sisi lain, refleksi praktik juga berfungsi sebagai instrumen peningkatan mutu pelayanan. Tenaga kesehatan yang terbiasa melakukan refleksi akan lebih peka terhadap potensi risiko, kesalahan prosedur, maupun kekurangan komunikasi dalam tim. Sikap terbuka terhadap evaluasi diri mendorong budaya keselamatan dan transparansi dalam organisasi. Penelitian tentang penerapan etika profesi dokter dalam pelayanan kesehatan menekankan pentingnya kesadaran reflektif dalam menjaga kepercayaan pasien serta mencegah konflik medis (Sucy et al., 2025). Dengan demikian, refleksi praktik tidak hanya berdampak pada perkembangan individu, tetapi juga kualitas sistem pelayanan secara keseluruhan.

Dalam pendidikan kesehatan, strategi pembelajaran berbasis refleksi seperti jurnal reflektif, diskusi kasus, dan simulasi dilema etika terbukti efektif dalam meningkatkan moral reasoning mahasiswa. Integrasi aspek etika, moral, dan mediko-legal dalam kurikulum berbasis kompetensi memperkuat kemampuan mahasiswa untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata (Istadi, 2025).

Pendekatan ini membantu calon tenaga kesehatan memahami bahwa profesionalisme bukan hanya standar perilaku eksternal, tetapi cerminan nilai internal yang membentuk karakter.

Akhirnya, refleksi praktik dan pengembangan karakter profesional merupakan proses berkelanjutan sepanjang karier tenaga kesehatan. Tantangan sistem kesehatan yang dinamis, perkembangan teknologi, serta perubahan nilai sosial menuntut tenaga kesehatan untuk terus memperbarui pemahaman moralnya. Profesionalisme yang kokoh lahir dari komitmen untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan menjaga integritas dalam setiap tindakan klinis. Dengan menjadikan refleksi sebagai budaya, tenaga kesehatan tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga memperdalam kualitas kemanusiaan dalam pelayanan (Afdhaliyah et al., 2025).

Etika dalam praktik profesional bukan hanya pedoman perilaku, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam melindungi hak pasien, memperkuat kepercayaan publik, dan menjaga kredibilitas profesi kesehatan. Pelaksanaan prinsip etika profesional secara konsisten dapat menurunkan risiko konflik, sengketa medik, dan kesalahan praktik, serta menciptakan lingkungan pelayanan yang aman dan bermartabat bagi pasien.

Etika juga berperan penting dalam pendidikan tenaga kesehatan. Kurikulum pendidikan berbasis kompetensi menuntut pembelajaran etika dan profesionalisme yang kuat sebagai bagian penting dari pembentukan karakter lulusan kesehatan sehingga mereka mampu menghadapi dilema moral di lapangan secara kritis dan bertanggung jawab.

Refleksi praktik merupakan salah satu strategi penting dalam pengembangan karakter profesional tenaga kesehatan. Dalam konteks pelayanan kesehatan yang dinamis dan kompleks, refleksi tidak sekadar dimaknai sebagai kegiatan mengingat kembali pengalaman klinis, melainkan sebagai proses berpikir kritis dan sistematis untuk memahami makna tindakan, nilai yang mendasarinya, serta dampaknya terhadap pasien dan diri sendiri sebagai profesional. Refleksi memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengevaluasi keputusan klinis, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta memperbaiki praktik di masa mendatang. Dengan demikian, refleksi menjadi jembatan antara pengalaman dan pembelajaran berkelanjutan.

Dalam literatur pendidikan kesehatan, refleksi dipandang sebagai komponen inti dalam pembentukan identitas profesional (professional identity formation). Identitas profesional berkembang melalui interaksi antara pengetahuan, pengalaman klinis, nilai moral, dan budaya organisasi. Studi terbaru menunjukkan bahwa praktik reflektif yang dilakukan secara terstruktur selama pendidikan dan praktik klinis berkontribusi signifikan terhadap internalisasi nilai profesionalisme,

empati, serta tanggung jawab etis (Farooq et al., 2025). Melalui refleksi, mahasiswa dan tenaga kesehatan tidak hanya belajar “apa yang harus dilakukan”, tetapi juga memahami “mengapa tindakan tersebut penting” dalam kerangka nilai profesi.

Refleksi praktik juga berperan dalam memperkuat karakter profesional seperti integritas, empati, resiliensi, dan akuntabilitas. Dalam situasi klinis yang menantang, termasuk ketika menghadapi dilema etika atau tekanan sistem, refleksi membantu tenaga kesehatan menjaga konsistensi antara nilai pribadi dan standar profesi. Penelitian dalam pendidikan kesehatan menegaskan bahwa pendekatan reflektif yang terintegrasi dalam kurikulum dapat meningkatkan sensitivitas moral serta kemampuan pengambilan keputusan etis pada mahasiswa kesehatan (Wald et al., 2021). Proses ini mendorong terbentuknya profesional yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga matang secara moral.

Selain sebagai sarana pengembangan individu, refleksi praktik memiliki dimensi kolektif dalam konteks organisasi pelayanan kesehatan. Lingkungan kerja yang mendukung diskusi reflektif, supervisi klinis, dan mentoring terbukti memperkuat budaya profesionalisme serta mengurangi risiko kelelahan emosional dan moral distress. Studi terkini menunjukkan bahwa intervensi berbasis refleksi dan dukungan tim dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan. Refleksi sebaiknya tidak dipandang sebagai aktivitas personal semata, melainkan sebagai bagian dari sistem pembelajaran organisasi.

Pengembangan karakter profesional melalui refleksi juga menuntut komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Profesionalisme bukanlah status yang dicapai sekali, melainkan proses dinamis yang terus berkembang seiring pengalaman dan tantangan praktik. Dalam era pelayanan kesehatan yang terus berubah akibat kemajuan teknologi, kompleksitas kasus, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, tenaga kesehatan perlu secara konsisten melakukan evaluasi diri dan adaptasi nilai. Refleksi yang berkelanjutan memungkinkan terbentuknya profesional yang adaptif, etis, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Refleksi praktik merupakan elemen kunci dalam pengembangan karakter profesional tenaga kesehatan. Melalui proses reflektif yang sistematis dan didukung oleh lingkungan organisasi yang kondusif, nilai-nilai profesionalisme dapat terinternalisasi secara mendalam dan berkelanjutan. Refleksi membantu membentuk tenaga kesehatan yang tidak hanya cakap secara klinis, tetapi juga memiliki integritas moral, empati, dan komitmen terhadap pelayanan yang bermartabat.

F. Membangun Budaya Etis dalam Organisasi Pelayanan Kesehatan

Budaya etis dalam organisasi pelayanan kesehatan merupakan fondasi penting dalam menjamin mutu layanan, keselamatan pasien, serta integritas profesional tenaga kesehatan. Budaya etis tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, tetapi mencerminkan nilai, norma, dan praktik bersama yang menuntun perilaku individu maupun kelompok dalam organisasi. Dalam konteks pelayanan kesehatan yang kompleks dan berisiko tinggi, budaya etis berfungsi sebagai kompas moral yang membimbing pengambilan keputusan klinis, interaksi antarprofesional, serta hubungan dengan pasien dan keluarga. Organisasi yang memiliki budaya etis yang kuat cenderung menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi serta kualitas pelayanan yang lebih konsisten.

Pembentukan budaya etis tidak terjadi secara spontan, melainkan melalui proses yang terstruktur dan berkelanjutan. Kepemimpinan memiliki peran sentral dalam membangun dan memelihara nilai etika organisasi. Pemimpin yang menunjukkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas akan menjadi teladan yang memperkuat internalisasi nilai profesionalisme di lingkungan kerja. Penelitian terkini menunjukkan bahwa kepemimpinan etis berhubungan signifikan dengan peningkatan perilaku profesional, kepuasan kerja, serta komitmen organisasi tenaga kesehatan. Keteladanan pimpinan juga menciptakan lingkungan psikologis yang aman bagi tenaga kesehatan untuk menyampaikan kekhawatiran etis tanpa rasa takut terhadap sanksi atau stigma.

Selain kepemimpinan, sistem dan kebijakan organisasi turut menentukan keberhasilan pembentukan budaya etis. Keberadaan kode etik yang jelas, mekanisme pelaporan pelanggaran, serta komite etik klinis menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa prinsip etika tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam praktik. Organisasi yang menyediakan ruang diskusi etik dan refleksi bersama terbukti mampu mengurangi moral distress serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan klinis (Rushton et al., 2021). Dukungan struktural ini membantu tenaga kesehatan menghadapi dilema etika secara kolektif dan sistematis.

Budaya etis juga berkaitan erat dengan keselamatan pasien dan kualitas layanan. Lingkungan kerja yang menjunjung tinggi keterbukaan, komunikasi efektif, dan pembelajaran dari kesalahan mendorong terciptanya sistem yang lebih aman. Studi terbaru dalam konteks rumah sakit menunjukkan bahwa budaya organisasi yang berorientasi pada etika dan keselamatan berkontribusi terhadap penurunan insiden kesalahan medis serta peningkatan kolaborasi tim interprofesional (Alquwez, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa etika bukan hanya isu moral, tetapi memiliki implikasi langsung terhadap hasil klinis dan mutu pelayanan.

Di sisi lain, dinamika sistem kesehatan modern yang dipengaruhi tekanan ekonomi, beban kerja tinggi, dan perkembangan teknologi medis berpotensi menimbulkan konflik nilai dalam organisasi. Oleh karena itu, diperlukan ruang dialog etik yang konstruktif di lingkungan kerja, seperti konferensi kasus, diskusi interprofesional, dan supervisi klinis. Forum tersebut memungkinkan tenaga kesehatan berbagi perspektif serta memperkuat kesepahaman mengenai standar moral yang dijunjung bersama. Studi literatur tentang profesionalisme keperawatan Indonesia menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang suportif terhadap refleksi etik meningkatkan konsistensi perilaku profesional dalam praktik klinis (Supri & Pasande, 2024).

Di era transformasi digital dan tuntutan efisiensi pelayanan, tantangan dalam membangun budaya etis semakin kompleks. Tekanan administratif, target kinerja, dan keterbatasan sumber daya dapat memengaruhi konsistensi penerapan nilai etika. Oleh karena itu, organisasi pelayanan kesehatan perlu mengintegrasikan etika dalam visi, misi, serta strategi pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan dan pelatihan etika secara berkelanjutan, supervisi profesional, serta evaluasi budaya organisasi menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa nilai-nilai etis tetap menjadi prioritas utama.

Penguatan budaya etis juga harus mempertimbangkan aspek regulasi dan kebijakan nasional. Di Indonesia, praktik pelayanan kesehatan diatur melalui kode etik profesi dan regulasi kesehatan yang menekankan tanggung jawab moral tenaga kesehatan terhadap pasien dan masyarakat. Namun, keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa komitmen implementasi di tingkat organisasi. Oleh sebab itu, integrasi antara nilai profesional, sistem pengawasan, pendidikan berkelanjutan, serta kepemimpinan berbasis etika menjadi strategi utama dalam membangun budaya etis yang kokoh dan berkelanjutan.

Budaya etis dalam organisasi pelayanan kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh sistem pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia. Pendidikan berkelanjutan, pelatihan etika klinis, serta pembekalan mengenai regulasi profesi menjadi instrumen penting dalam menjaga konsistensi perilaku profesional tenaga kesehatan. Program penguatan etika yang dilakukan secara periodik terbukti meningkatkan sensitivitas moral dan kemampuan tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran etik di tempat kerja (Hapsari et al., 2025). Dengan demikian, pembinaan profesional tidak hanya berorientasi pada peningkatan kompetensi teknis, tetapi juga pada penguatan karakter dan tanggung jawab moral.

Selain aspek pendidikan, evaluasi kinerja berbasis nilai juga berperan dalam memperkuat budaya etis. Organisasi yang mengintegrasikan indikator

profesionalisme dan kepatuhan etik dalam sistem penilaian kinerja cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi terhadap standar pelayanan. Evaluasi semacam ini mendorong tenaga kesehatan untuk tidak hanya memenuhi target kuantitatif, tetapi juga menjaga kualitas interaksi dengan pasien dan keluarga. Penelitian mengenai implementasi etika profesi dalam pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa pengawasan yang sistematis dan evaluasi yang transparan membantu menekan potensi konflik serta meningkatkan akuntabilitas profesional (Sucy et al., 2025).

Budaya etis juga berkaitan erat dengan komunikasi organisasi yang terbuka dan saling menghargai. Lingkungan kerja yang mendukung dialog dua arah memungkinkan tenaga kesehatan menyampaikan pendapat, kekhawatiran, atau laporan pelanggaran tanpa rasa takut. Transparansi komunikasi ini penting dalam membangun kepercayaan internal maupun eksternal. Studi di lingkungan rumah sakit Indonesia menunjukkan bahwa komunikasi efektif antara pimpinan dan staf berkontribusi terhadap peningkatan perilaku profesional serta kepatuhan terhadap standar etika pelayanan. Dengan kata lain, budaya etis tumbuh dalam suasana yang aman secara psikologis (Emilia, 2025).

Lebih lanjut, penguatan budaya etis perlu memperhatikan dimensi interprofesional dalam pelayanan kesehatan. Kolaborasi antara dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya menuntut keselarasan nilai profesional agar tidak terjadi konflik kepentingan atau ketidaksepahaman peran. Integrasi etika dalam praktik kolaboratif membantu menjaga fokus utama pelayanan, yaitu keselamatan dan kesejahteraan pasien. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi di Indonesia yang memasukkan unsur etika dan keselamatan pasien menjadi langkah strategis dalam membentuk budaya kolaboratif yang bermoral sejak tahap pendidikan.

Dengan demikian, membangun budaya etis dalam organisasi pelayanan kesehatan merupakan proses multidimensional yang melibatkan kepemimpinan, sistem kebijakan, pendidikan, serta partisipasi aktif seluruh tenaga kesehatan. Budaya etis yang kuat tidak hanya memperkuat profesionalisme individu, tetapi juga menciptakan lingkungan pelayanan yang aman, transparan, dan berorientasi pada martabat pasien. Melalui komitmen bersama dan dukungan struktural yang konsisten, organisasi pelayanan kesehatan dapat mewujudkan praktik yang tidak hanya efektif secara klinis, tetapi juga bermakna secara moral.

G. Simpulan

Profesionalisme dan etika merupakan dua pilar utama dalam praktik pelayanan kesehatan yang tidak dapat dipisahkan dari kompetensi klinis. Praktik kesehatan bukan sekadar penerapan ilmu dan keterampilan teknis, melainkan juga perwujudan tanggung jawab moral terhadap keselamatan, martabat, dan hak pasien. Dalam konteks pelayanan modern yang semakin kompleks, tenaga kesehatan dituntut untuk mampu mengintegrasikan nilai integritas, empati, akuntabilitas, serta komitmen terhadap standar profesi dalam setiap pengambilan keputusan klinis.

Budaya etis dalam organisasi pelayanan kesehatan menjadi fondasi yang memperkuat konsistensi perilaku profesional. Kepemimpinan yang berlandaskan nilai moral, sistem tata kelola yang transparan, pendidikan berkelanjutan, serta komunikasi yang terbuka berperan penting dalam membentuk lingkungan kerja yang aman secara etis. Organisasi yang menanamkan nilai profesionalisme secara sistematis tidak hanya meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi kesehatan.

Dilema etika yang muncul dalam praktik klinis merupakan konsekuensi dari kompleksitas situasi kesehatan yang melibatkan berbagai kepentingan dan nilai. Oleh karena itu, kemampuan refleksi moral dan pengambilan keputusan yang berbasis prinsip etika menjadi kompetensi esensial bagi setiap tenaga kesehatan. Proses refleksi yang berkelanjutan memungkinkan profesional kesehatan untuk terus memperbaiki diri dan menjaga keseimbangan antara tuntutan klinis dan nilai kemanusiaan.

Pada akhirnya, penguatan etika dan profesionalisme harus dipandang sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan individu, organisasi, dan sistem pendidikan kesehatan. Melalui internalisasi nilai-nilai etis, pengembangan karakter profesional, serta pembentukan budaya organisasi yang bermartabat, pelayanan kesehatan dapat diwujudkan secara aman, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan pasien. Dengan demikian, etika dan profesionalisme bukan hanya aspek normatif, melainkan inti dari identitas dan keberlanjutan praktik kesehatan.

H. Referensi

- Abdullah, M., & Binarsa, D. B. (2025). Etika Profesi dan Aspek Pidana dalam Pelayanan Kesehatan: Harmonisasi menurut Undang - Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 32(3), 167–186.
- Afdhaliyah, N., Mokhtar, S., & Kartika, I. D. (2025). Persepsi Mahasiswa Kedokteran Terhadap Perilaku Profesionalisme (Honor and Integrity). *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2), 3532–3538.

<https://doi.org/10.31004/prepotif.v9i2.46126>

- Celerio, M. M., Loor, I. W., Macias, R. M., Molina, M. N., Moreina, B. E., Borroto, E. R., & Herrera, M. del R. (2025). Medical ethics and professional training : building competencies for responsible healthcare practice. *Revista Gregoriana De Ciencias De La Salud*, 2(2), 146–157. <https://doi.org/https://orcid.org/0009-0003-7493-2951>
- Danacı, E., & Erdoğan, T. K. (2025). Ethical principles, sensitivity, and caring behaviors among nursing students: a cross-sectional study. *BMC Nursing*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s12912-025-03644-2>
- Emilia, M. (2025). Profesionalisme Apoteker dalam Perspektif Nilai Obat sebagai Amanah pada Teori Konstitusi Kesehatan Nusantara. *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 3(5), 129–136. <https://journal.arikesi.or.id/index.php/OBAT/article/view/1617>
- Farooq, M., Hashim, M. J., Alhosani, S., Alalawi, A. M., Alalawi, O. M., Qandilo, K. A., Hafeez, U., & Cevik, A. A. (2025). Professionalism and professional identity in medical students: a cross-sectional mixed-methods analysis of correlation and progression. *Frontiers in Medicine*, 12. <https://doi.org/10.3389/FMED.2025.1650073/FULL>
- Fitira, A., & Subekti, R. (2025). Peran Etika dalam Hubungan Profesional Tenaga Medis-Tenaga Kesehatan dan Pasien Sebagai Strategi Pencegahan Sengketa Medik. *Cendekia Ilmiah*, 5(1), 2033–2045.
- Hapsari, E. H., Efrilianty, S., Sagara, W. M., Eka, N. G. A., & Diannita, C. G. (2023). Persepsi Mahasiswa Keperawatan terhadap Profesionalisme Keperawatan Indonesia: Kajian Literatur Sistematis. *Jurnal Kedokteran Meditek*, 29(3), 348–361. <https://doi.org/10.36452/jkdoktmeditek.v29i3.2887>
- Sarjana P, Zakaria C, & Susiarno T. (2022). Tinjauan Hukum Dan Etika Terhadap Penangguhan Pelayanan Essensial Di Rumah Sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 02(02), 116–120.
- Silaban, S., Simarmata, M. M., & Maryani, F. (2025). Hubungan Pemahaman Etika dengan Praktik Profesional : Studi Empiris pada Mahasiswa D3 Optometri. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia*, 10(2).
- Situmorang, R., Rifai, S. I., & Situmorang, E. (2025). Analisis Perilaku Etik Dengan Caring Pada Perawat Di Rumah Sakit Wilayah Kabupaten Bandung. *Jurnal Keperawatan Muhammadiyah*, 10(4), 254–259.
- Sucy, P., Mz, R., Sidi, R., & Simarmata, M. (2025). Penerapan Etika Profesi Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien. *Journal of Science and Social Research*, 4307(3), 3968–3973. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>
- Supri, A., & Pasande, D. T. (2024). *Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Perawat*

Instalasi Gawat Darurat. 3(1), 11–22.

Yang, H. M., & Jang, Y. E. (2025). Ethics of nursing in the digital age: perceptions and challenges among Korean nursing students. *BMC Medical Ethics, 26*(1). <https://doi.org/10.1186/s12910-025-01301-6>

CHAPTER 5

IMPLIKASI PENGALAMAN PRAKTIK TERHADAP PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KESEHATAN

(Dr.Yeni Fitriainingsih,SST,MKes)

A. Pendahuluan

Dinamika pelayanan kesehatan di abad ke-21 tidak lagi hanya menuntut kemahiran teknis statis, melainkan fleksibilitas adaptif terhadap perkembangan sains dan teknologi. Pendidikan kesehatan, khususnya dalam ekosistem Poltekkes Kemenkes, memegang peranan vital sebagai jembatan antara standar akademik dan realitas klinis yang kompleks. Judul bab ini, "Implikasi Pengalaman Praktik terhadap Pengembangan Pendidikan Kesehatan," berpijak pada premis bahwa lahan praktik adalah "laboratorium hidup" yang menyediakan data riil (real-world evidence) untuk merevitalisasi kurikulum yang ada.

Seiring dengan peluncuran Transformasi Kesehatan RI 2024-2029, pendidikan tenaga kesehatan dihadapkan pada tantangan besar untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga literat secara digital dan mahir dalam kolaborasi interprofesional. Pengalaman praktis tenaga kesehatan di lapangan sering kali mengungkap celah antara teori yang diajarkan dengan kebutuhan aktual pasien. Oleh karena itu, pengalaman tersebut harus dikonversi menjadi pengetahuan terstruktur melalui proses refleksi mendalam dan integrasi ke dalam struktur kurikulum. Bab ini akan membedah bagaimana fenomena klinis, pemanfaatan teknologi digital dalam refleksi, dan sinergi antarprofesi menjadi tiga pilar utama dalam merekonstruksi masa depan pendidikan kesehatan di Indonesia.

Pendidikan tenaga kesehatan merupakan proses multidimensional yang bertujuan menghasilkan profesional kesehatan yang kompeten secara klinis, etis, dan komunikatif. Dalam konteks pendidikan ini, pengalaman praktik klinis, lapangan, atau simulasi bukan hanya komponen kurikuler, tetapi juga konstitutif dalam pembentukan kompetensi profesional tenaga kesehatan. Pengalaman praktik menyediakan situated learning yang memungkinkan mahasiswa menerapkan pengetahuan teoritis dalam konteks nyata pelayanan kesehatan, memperkaya pembelajaran, empathetic reasoning, pengambilan keputusan klinis, serta profesionalisme layanan. (Pelatihan et al., 2023)

Pendidikan tenaga kesehatan merupakan proses multidimensional yang bertujuan menghasilkan profesional kesehatan yang kompeten secara klinis, etis, dan komunikatif. Dalam konteks pendidikan ini, pengalaman praktik klinis, lapangan, atau simulasi bukan hanya komponen kurikuler, tetapi juga konstitutif dalam pembentukan kompetensi profesional tenaga kesehatan. Pengalaman praktik menyediakan *situated learning* yang memungkinkan mahasiswa menerapkan pengetahuan teoritis dalam konteks nyata pelayanan kesehatan, memperkaya pembelajaran, *empathetic reasoning*, pengambilan keputusan klinis, serta profesionalisme layanan. (Houser et al., 2025)

Perkembangan sistem kesehatan global menuntut tersedianya tenaga kesehatan yang tidak hanya unggul secara keilmuan, tetapi juga adaptif, reflektif, kolaboratif, dan mampu memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan serta kebutuhan pasien. Kompleksitas permasalahan kesehatan masyarakat, perubahan pola penyakit, kemajuan teknologi medis, serta tuntutan mutu pelayanan yang semakin tinggi menjadikan pendidikan tenaga kesehatan sebagai elemen strategis dalam pembangunan kesehatan. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan tidak lagi dapat berfokus semata pada penguasaan pengetahuan teoretis, melainkan harus memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi praktik yang kuat, sikap profesional, dan kemampuan pengambilan keputusan klinis berbasis konteks nyata pelayanan kesehatan.

Dalam konteks tersebut, pengalaman praktik baik dalam bentuk praktik klinik, praktik lapangan, simulasi, maupun pembelajaran berbasis kasus nyata menjadi jantung dari proses pembelajaran tenaga kesehatan. Pengalaman praktik memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan pasien, keluarga, tim kesehatan, serta sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Melalui pengalaman ini, mahasiswa tidak hanya “belajar melakukan” (*learning to do*), tetapi juga “belajar menjadi” (*learning to be*) seorang profesional kesehatan yang beretika, empatik, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pengalaman praktik memiliki peran penting dalam pembentukan kompetensi klinis sekaligus identitas profesional tenaga kesehatan.

Secara teoretis, pembelajaran berbasis pengalaman memiliki landasan kuat dalam berbagai teori pendidikan, khususnya *experiential learning theory* yang menekankan bahwa pembelajaran yang bermakna terjadi ketika individu terlibat langsung dalam pengalaman nyata, melakukan refleksi kritis, mengintegrasikan pengalaman tersebut ke dalam kerangka konseptual, dan kemudian mengaplikasikannya kembali dalam situasi baru. Dalam pendidikan kesehatan, pendekatan ini sangat relevan karena praktik pelayanan kesehatan selalu berada dalam konteks yang dinamis, tidak pasti, dan sarat dengan aspek klinis, sosial,

budaya, serta etika. Oleh karena itu, pengalaman praktik tidak dapat diposisikan sebagai pelengkap kurikulum, melainkan sebagai wahana utama pengembangan kompetensi profesional.

Namun demikian, integrasi pengalaman praktik ke dalam pendidikan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan antara teori dan praktik, variasi kualitas pembimbing klinik, keterbatasan lahan praktik, beban kerja pelayanan, serta kurangnya mekanisme refleksi terstruktur seringkali menyebabkan pengalaman praktik belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pembelajaran. Selain itu, perubahan lanskap pelayanan kesehatan termasuk meningkatnya kebutuhan kolaborasi interprofesional dan penggunaan teknologi digital menuntut model pendidikan kesehatan yang lebih inovatif dan responsif terhadap realitas praktik.

B. Transformasi Kurikulum Berbasis Real-World Evidence dan Fenomena Klinis

1. Rekonstruksi Kurikulum di Era Disrupsi Kesehatan

Pendidikan tinggi kesehatan, saat ini berada pada titik nadir transformasi yang dipicu oleh cepatnya evolusi teknologi medik dan perubahan beban penyakit global. Integrasi Real-World Evidence (RWE) ke dalam kurikulum bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan untuk menjamin relevansi lulusan. Berbeda dengan bukti dari uji klinis yang terkontrol ketat, RWE memberikan gambaran autentik mengenai efektivitas intervensi kesehatan dalam populasi yang heterogen di lapangan (Frenk et al., 2010).

Dalam konteks Indonesia, transformasi ini sejalan dengan Pilar ke-5 Transformasi Kesehatan (SDM Kesehatan) yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Kebijakan ini menekankan pentingnya penyelarasan antara kurikulum pendidikan vokasi dan profesi dengan kebutuhan industri serta penguatan literasi digital kesehatan (Kemenkes, 2024). Pengalaman praktisi dalam mengelola data pasien secara digital melalui sistem SatuSehat menjadi bukti riil yang harus diintegrasikan dalam materi pembelajaran untuk membentuk kompetensi "bidan masa depan" yang cakap teknologi.

2. Gap Analysis: Menjembatani Teori dan Realita Praktik

Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan kesehatan adalah adanya kesenjangan kompetensi (competency gap) antara apa yang diajarkan di kelas dengan kompleksitas di lahan praktik. (Biggs, 2016) mengemukakan konsep Constructive Alignment, di mana aktivitas pembelajaran harus didesain untuk mencapai luaran kerja yang nyata. Fenomena klinis kontemporer, seperti peningkatan kasus kehamilan risiko tinggi yang terpapar polusi lingkungan atau

gangguan kesehatan mental perinatal, sering kali belum terkodifikasi secara mendalam dalam buku teks standar.

Melalui mekanisme feedback loop dari pengalaman praktisi, institusi pendidikan dapat melakukan analisis kesenjangan secara berkala. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang menegaskan bahwa pengembangan kompetensi nakes harus berorientasi pada standar pelayanan yang dinamis dan evaluasi kinerja berbasis data lapangan (KEMENKES, 2025). Dengan demikian, kurikulum menjadi entitas yang "hidup" dan responsif terhadap perubahan.

3. Evidence-Based Practice (EBP) dan Clinical Wisdom

Pengalaman praktik tidak hanya memberikan data mentah, tetapi juga membentuk apa yang disebut sebagai clinical wisdom atau hikmat klinis. Pendapat menyatakan bahwa integrasi EBP yang efektif memerlukan keseimbangan antara bukti penelitian terbaik, keahlian klinis praktisi, dan nilai-nilai pasien (Joy Higgs, Gail M. Jensen, Stephen Loftus, Franziska V. Trede, 2024). Dalam pendidikan kebidanan, pengalaman menangani kasus unik di daerah terpencil (seperti penanganan perdarahan postpartum dengan keterbatasan fasilitas) memberikan perspektif berharga yang harus diangkat menjadi materi Case-Based Learning (CBL).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa standar kurikulum baru bagi bidan harus mengikuti standar internasional guna memastikan lulusan siap menghadapi kondisi dunia nyata yang kompleks, termasuk kemampuan melakukan rujukan cepat dan tepat melalui klasifikasi risiko berbasis data (KEMENKES, 2025). Transformasi ini menuntut dosen untuk tidak hanya mengajarkan "cara menyuntik", tetapi juga "cara berpikir" dan "cara berinovasi" berdasarkan bukti riil.

4. Implementasi Outcome-Based Education (OBE) dan Strategi 2025

Implementasi transformasi ini bermuara pada pendekatan Outcome-Based Education (OBE). Berdasarkan Rencana Strategis Kemendiktisaintek 2025-2029, institusi pendidikan tinggi didorong untuk menciptakan lulusan yang mampu beradaptasi dengan revolusi kesehatan 4.0, termasuk penggunaan AI dalam diagnosa dini dan manajemen krisis kesehatan (Kemendiktisaintek, 2025). Strategi Project-Based Learning (PjBL) yang melibatkan praktisi dari lahan praktik sebagai dosen tamu (Program Praktisi Mengajar) memperkuat keterpaparan mahasiswa terhadap dinamika pelayanan yang sesungguhnya.

C. Refleksi Praktis Berbasis Teknologi Digital dalam Pendidikan Kesehatan

1. Evolusi Refleksi: Dari Tradisional ke Digital (Digital Reflective Practice)

Refleksi dalam praktik kesehatan adalah proses kognitif aktif untuk menganalisis pengalaman klinis guna meningkatkan kualitas tindakan di masa depan. Jika sebelumnya refleksi sering dianggap sebagai aktivitas subjektif yang sulit diukur, kehadiran teknologi digital telah mengubah paradigma ini menjadi lebih terstruktur dan berbasis data. Dalam dunia medis yang kompleks, refleksi harus melampaui sekadar "mengingat peristiwa," melainkan harus menjadi proses "refleksi-dalam-tindakan" (reflection-in-action) yang diperkuat oleh alat bantu keputusan klinis (Kinsella et al., 2015)

Di lingkungan Poltekkes Kemenkes, transformasi digital dalam refleksi tercermin dalam penggunaan e-Portofolio dan Digital Logbooks. Mahasiswa tidak hanya mencatat jumlah asuhan, tetapi mengunggah narasi reflektif yang terintegrasi dengan data asuhan riil. Hal ini selaras dengan Pilar ke-6 Transformasi Kesehatan (Transformasi Teknologi Kesehatan) yang diusung Kemenkes RI, di mana digitalisasi rekam medik melalui platform SatuSehat memungkinkan praktisi untuk meninjau kembali keputusan klinis mereka berdasarkan data historis yang akurat (Kemenkes RI, 2024).

2. Model Refleksi Terintegrasi Kecerdasan Buatan (AI)

Salah satu lonjakan terbesar dalam pendidikan kesehatan adalah penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk memandu proses refleksi. Model refleksi klasik seperti Gibbs' Reflective Cycle kini dapat diimplementasikan dalam bentuk AI-driven reflective prompting. Dalam model ini, sistem digital memberikan pertanyaan pemantik otomatis yang menantang mahasiswa untuk berpikir lebih dalam saat mereka memasukkan data kasus yang sulit ke dalam sistem.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam memberikan umpan balik reflektif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa kesehatan hingga 40%. Misalnya, ketika seorang mahasiswa kebidanan merefleksikan penanganan preeklampsia, sistem AI dapat menyajikan data literatur terbaru atau membandingkan tindakan mahasiswa dengan protokol klinis nasional secara real-time, sehingga proses refleksi menjadi lebih objektif dan saintifik. (Sakhiyya et al., 2025)

3. Simulasi Virtual dan Video-Based Reflection

Teknologi simulasi (Virtual Reality/VR) dan rekaman video telah menjadi instrumen revolusioner dalam refleksi praktis. Melalui Video-Based Reflection

(VBR), mahasiswa dapat melihat kembali performa mereka saat melakukan prosedur klinis atau komunikasi terapeutik. Penelitian menyatakan bahwa melihat diri sendiri dalam rekaman video memungkinkan praktisi mendeteksi kesalahan kecil yang tidak disadari saat tindakan berlangsung (blind spots). (Adesope et al., 2024)

Pemerintah melalui Kemenkes RI (2025) dalam arah kebijakan pengembangan laboratorium simulasi di Poltekkes, mendorong penggunaan high-fidelity simulation. Pengalaman praktik di laboratorium ini direkam secara digital, kemudian dibahas dalam sesi debriefing yang mendalam. Proses ini mengubah pengalaman "mentah" menjadi pengetahuan bermakna, mengurangi risiko kesalahan medis (medical error), dan meningkatkan keselamatan pasien sesuai dengan standar keselamatan pasien internasional.

4. Refleksi Kolaboratif dalam Ekosistem Digital

Teknologi juga memfasilitasi refleksi kolaboratif lintas disiplin (interprofessional reflection). Melalui platform pembelajaran daring (LMS) dan forum diskusi profesional, tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang dapat merefleksikan satu kasus secara bersamaan. Hal ini sangat penting dalam penanganan stunting atau kematian ibu yang memerlukan kolaborasi bidan, dokter, dan ahli gizi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2025, pengembangan kompetensi berkelanjutan kini diarahkan pada sistem pembelajaran berbasis komunitas (Sikeren Kemenkes). Platform ini memungkinkan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia untuk berbagi refleksi kasus-kasus sulit secara anonim, menciptakan bank pengetahuan kolektif yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa sebagai bahan ajar yang sangat aktual.

D. Sinergi Interprofessional Collaboration (IPC) dalam Praktik dan Pendidikan

1. Rekonstruksi Paradigma: Dari Silo ke Kolaboratif

Dalam dekade terakhir, pergeseran paradigma dari praktik profesional yang terisolasi (silo) menuju kerja sama tim interprofesional telah menjadi standar emas dalam pelayanan kesehatan global. Interprofessional Collaboration (IPC) bukan sekadar bekerja bersama di ruangan yang sama, melainkan sebuah kemitraan antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga untuk mencapai kualitas asuhan yang optimal. Reeves et al. menegaskan bahwa kegagalan komunikasi interprofesional merupakan penyebab utama dari 70% kejadian tidak diharapkan (adverse events) di rumah sakit (Scott Reeves, Simon Lewin, Sherry Espin, 2010).

Di Indonesia, penguatan IPC menjadi tulang punggung Transformasi Layanan Primer dan Rujukan (Pilar ke-1 dan ke-2 Transformasi Kesehatan).

Sebagai dosen Poltekkes Kemenkes, Ibu/Bapak tentu memahami bahwa pendidikan harus mendahului praktik. Oleh karena itu, Interprofessional Education (IPE) di kampus harus dirancang agar mahasiswa bidan, perawat, gizi, dan sanitasi dapat belajar "bersama, dari, dan tentang satu sama lain" untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan prevalensi stunting secara holistik (Kemenkes RI, 2024).

2. Implementasi IPC dalam Ekosistem Digital Kesehatan

Digitalisasi telah mempercepat adopsi IPC melalui sistem informasi yang terintegrasi. Platform SatuSehat yang dikembangkan oleh Kemenkes RI memungkinkan berbagai profesi kesehatan untuk mengakses data pasien yang sama secara real-time. Pengalaman praktik dalam menggunakan rekam medis elektronik (RME) yang terintegrasi ini menjadi bahan pembelajaran krusial dalam kurikulum. Menurut World Health Organization, penggunaan teknologi informasi dalam kolaborasi interprofesional dapat meningkatkan efisiensi kerja tim hingga 30% dan mengurangi duplikasi tindakan medis.

Integrasi ini menuntut mahasiswa untuk memiliki kompetensi digital interprofessionalism. Mereka tidak hanya harus mahir secara klinis, tetapi juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan etis melalui platform digital (seperti konsultasi interprofesional melalui telemedicine). Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 13 Tahun 2025 yang mewajibkan seluruh tenaga kesehatan untuk memiliki literasi digital yang mumpuni sebagai bagian dari standar kompetensi baru (KEMENKES, 2025).

3. Mentorship dan Preceptorship Interprofesional di Lahan Praktik

Pengembangan pendidikan kesehatan melalui pengalaman praktik sangat bergantung pada model mentorship dan preceptorship. Pengalaman unik tenaga kesehatan di lapangan menunjukkan bahwa bimbingan yang bersifat interprofesional (misalnya, mahasiswa bidan mendapat bimbingan dari dokter spesialis atau ahli gizi di puskesmas) memberikan wawasan yang lebih luas mengenai tata laksana pasien secara komprehensif.

Berdasarkan laporan National Academy of Medicine (2021), lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi terbukti meningkatkan kepuasan kerja tenaga kesehatan dan menurunkan angka burnout. Di Indonesia, Kemenkes RI melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan (2025) telah meluncurkan pedoman baru mengenai "Rumah Sakit Pendidikan dan Puskesmas Pembina" yang menekankan pada penguatan iklim kolaboratif sebagai syarat akreditasi lahan praktik bagi mahasiswa Poltekkes.

4. Dampak IPC terhadap Keselamatan Pasien dan Mutu Layanan

Implikasi akhir dari penguatan IPC dalam pendidikan adalah terciptanya budaya keselamatan pasien (*culture of safety*). Pengalaman praktisi dalam melakukan *clinical case conference* secara rutin merupakan bentuk pembelajaran yang sangat efektif untuk diadaptasi ke dalam metode *Case-Based Learning (CBL)* di kelas. Dengan memaparkan mahasiswa pada dinamika pengambilan keputusan tim di lapangan, pendidikan kesehatan tidak lagi hanya menghasilkan individu yang pintar secara akademik, tetapi anggota tim yang andal dalam menjaga keselamatan pasien sesuai dengan target *Sustainable Development Goals (SDGs)* 2030.

E. Simpulan

Pengembangan pendidikan kesehatan yang progresif tidak dapat dipisahkan dari dialektika yang terjadi di lahan praktik. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengalaman praktik memiliki implikasi transformatif dalam tiga dimensi utama:

1. **Transformasi Kurikulum:** Pengalaman lapangan berfungsi sebagai sensor utama dalam mendeteksi perubahan kebutuhan pelayanan kesehatan. Integrasi *Real-World Evidence* memastikan kurikulum tetap relevan dan selaras dengan kebijakan transformasi kesehatan pemerintah, khususnya dalam aspek digitalisasi dan penguatan layanan primer.
2. **Pedagogi Reflektif:** Teknologi digital telah merevolusi cara tenaga kesehatan mengambil makna dari pengalaman mereka. Penggunaan AI, simulasi virtual, dan e-portofolio mengubah refleksi dari sekadar aktivitas retrospektif menjadi instrumen peningkatan kualitas yang objektif dan terukur.
3. **Kekuatan Kolaboratif:** Sinergi interprofesional (IPC) yang ditemukan dalam praktik klinis harus menjadi ruh dalam setiap modul pendidikan. Kolaborasi yang efektif terbukti menjadi kunci utama dalam menjamin keselamatan pasien dan efisiensi sistem kesehatan.

Sebagai penutup, sinergi antara institusi pendidikan dan lahan praktik harus diperkuat melalui kebijakan yang mendukung *long-life learning*. Dengan menjadikan pengalaman praktik sebagai kompas pengembangan pendidikan, kita tidak hanya mencetak tenaga kesehatan yang cakap, tetapi juga agen perubahan yang mampu menjawab tantangan kesehatan masa depan demi mewujudkan *Indonesia Emas 2045*.

F. Referensi

- Adesope, O., & Proença, L. (2024). Video-based approaches in health education : a systematic review and meta-analysis. *Saintific Report*, 1–14.
- Biggs, J. (2016). Teaching for Quality Learning at University Assessing for learning quality : II . Practice. *Creative Education*, 7(14), 1–36. Retrieved from <https://www.scirp.org/journal/home?journalid=136>
- Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z. A., Cohen, J., Crisp, N., Evans, T., Fineberg, H., Garcia, P., Ke, Y., Kelley, P., & Gates, M. (2010). Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an. *Education Of Health Professionals For The 21 St Century*, 1923–1958. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61854-5
- Houser, S. H., Flite, C. A., Foster, S. L., Kinnerson, L., Hunt, T. J., Morey, A., Pope, R. D., Sorensen, L., & Ed, D. (2025). *Incorporating Experiential Learning into Health Information Education : Enhancing Curriculum with Real-World Applications Advances in Health Information Science and Practice*. 1(2). doi: 10.63116/YRUD1773
- Joy Higgs, Gail M. Jensen, Stephen Loftus, Franziska V. Trede, S. G. (2024). *Clinical Reasoning in the Health Professions, 5th Edition*. Retrieved from <https://www.uk.elsevierhealth.com/clinical-reasoning-in-the-health-professions-9780443110979.html>
- Kemendiktisaintek. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2025 Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029*.
- Kemenkes. (2024). *Merajut Asa Kesehatan Bangsa: Transformasi SDM Kesehatan Indonesia*. Jakarta: SDM Kesehatan Indonesia Transformasi SDM Kesehatan Indonesia.
- KEMENKES. (2025). *Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2025*.
- Kemenkes RI. (2024). *Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024* (1st ed.). Jakarta Indonesia.
- Kinsella, E. A., & Ed, M. A. (2015). Reflections on reflective practice. *SAGE Open Medicine*, June 2001.
- Pelatihan, E., Update, M., Peningkatan, T., Dan, S., Bidan, K., Pelayanan, P., Of, A., Associated, F., Of, W. S., & Patients, I. N. H. (2023). *Jurnal Keperawatan*. 15, 1719–1726.
- Sakhiyya, Z., & Trisanti, N. (2025). The Students ' Perceptions of Artificial Intelligence (AI) in Higher Education: A Systematic Literature Review. *The Proceedings of English Language Teaching, Literature, and Translation*, 14, 182–195.
- Scott Reeves, Simon Lewin, Sherry Espin, M. Z. (2010). *Interprofessional Teamwork*

for Health and Social Care.

PROFIL PENULIS



Dr. Halimatussakdiah, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat merupakan dosen pengajar di Poltekkes Kemenkes Aceh sejak tahun 1990. Penulis merupakan alumni Universitas Indonesia mulai S1, S2 dan Profesi. Penulis menyelesaikan S1 tahun 1999, S2 tahun 2005 dan Spesialis keperawatan Maternitas tahun 2006. Selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan Doktorat pada Jurusan Manajemen

Sumber Daya Manusia Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala (USK) tahun 2019.

Keahlian penulis adalah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Medikal Bedah dan Manajemen SDM Kesehatan. Penulis Sebagai dosen pengajar Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Aceh. Selain mengajar, penulis aktif sebagai Penulis aktif dalam pelatihan, workshop, penelitian dan pengabdian Masyarakat. Informasi publikasi dapat diakses pada Google Scholar [y2hhHCoAAAAJ](https://scholar.google.com/citations?user=y2hhHCoAAAAJ). Penulis telah menghasilkan beberapa buku yang telah mempunyai ISBN dari IKAPI dan Prodi DIII Keperawatan Banda Aceh. Adapun judul judul buku yang telah terbit: Profil Metabolik Remaja, Suami Siaga, Tips ibu hamil dan Pasca bersalin, Analisis Kepuasan pasien melalui Kinerja perawat di RS Pemerintah, Deteksi Dini Resiko Preeklampsia dan Inovasi Teknologi Kesehatan.

Selama ini penulis aktif organisasi diantaranya seperti Asosiasi Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia (Ketua Regional Aceh 2020-2024). Organisasi berikutnya yang ditekuni penulis adalah Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI; ketua IPEMI Aceh 2009-2024). Demikian juga penulis aktif dalam ikatan alumni Universitas Indonesia (Provinsi Aceh).

Email: halimatussakdiah@poltekkesaceh.ac.id

Motto “Berikanlah ilmu kepada orang lain walaupun hanya sepatah kata”



Lani Nurlita, M.Tr.Keb Lahir di Serang, 18 Juni 1995. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Vokasi pada Program Studi DIII-Kebidanan, pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Faletahan dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan Sarjana pada Program Studi DIV-Kebidanan pada Universitas Nasional dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Terapan Kebidanan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Husada dan lulus pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021-Sekarang, bekerja di Universitas Bina Bangsa sebagai Dosen atau Tenaga Pendidik. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Bangsa mengampu mata kuliah Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: laninurlita0695@gmail.com
Motto: "Kegelapan hari ini, tidak akan menghalangi cahaya esok hari"



Annisa Ridlayanti, S.Keb.,Bd.,M.Keb Lahir di Bandung, 24 Februari 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Brawijaya Malang dan lulus tahun pada tahun 2016. Saat ini sedang menempuh Studi S3 Ilmu Kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2006-2009 di Rumah Bersalin Afiatun Hasanah Kota Bandung. Tahun 2007-2009 bekerja sebagai tenaga bidan praktisi honorer di Puskesmas Garuda Kota Bandung. Tahun 2009-2012 bekerja sebagai laboran dan tenaga pengajar di Akademi Kebidanan Aisyiyah Bandung. 2012 hingga saat ini bekerja sebagai dosen kebidanan, peneliti, dan motivator. Saat ini penulis bekerja di Universitas Aisyiyah Bandung dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan Holistik Islami, Asuhan Kebidanan Muslimah, Asuhan Kebidanan Bayi, Balita, Anak dan Prasekolah, Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Metodologi Riset 1, Metodologi Penelitian, Statistika Penelitian. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, international conference, pengabdian masyarakat, serta aktif dalam berorganisasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: annisa_ridlayanti@yahoo.com
Motto: "always be grateful and be happy as possible and forever"



Anita Setyowati, M.Tr.Kep lahir di Sleman pada tanggal 22 Maret 1997. Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan (S1) di Program Studi Keperawatan, Poltekkes Kementerian Kesehatan Yogyakarta pada tahun 2019. Ketertarikan terhadap pengembangan ilmu keperawatan dan praktik profesional mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan Magister Terapan Keperawatan (S2) di Poltekkes Kementerian Kesehatan Semarang dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2023. Saat ini, Anita Setyowati, M.Tr.Kep berkarier sebagai dosen di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. Dalam kapasitasnya sebagai pendidik, penulis mengampu mata kuliah Asuhan Keperawatan Anestesi Pre, Intra, Post, Asuhan Keperawatan Anestesi Kasus Umum dan Asuhan Keperawatan Anestesi Kritis, dengan fokus pada penguatan kompetensi klinis, pengkajian keperawatan anestesi, serta praktik keperawatan pra anestesi berbasis evidensi. Penulis berkomitmen untuk mengintegrasikan pengalaman praktik klinis dengan pembelajaran akademik guna menghasilkan lulusan yang profesional, kompeten, dan beretika. Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan akademik, antara lain penyusunan buku ajar dan referensi keperawatan anestesi, publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional, serta partisipasi dalam seminar dan konferensi ilmiah baik sebagai peserta maupun pemakalah. Selain itu, penulis juga terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan edukasi kesehatan masyarakat. Melalui karya tulis dan aktivitas akademiknya, penulis berupaya memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu, khususnya pada bidang anestesi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anitasetyowati@unisayogya.ac.id



Dr.Yeni Fitrianingsih,SST,MKes Lahir di Kuningan, 12 Desember 1969. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma IV pada Program Studi DIV Kebidanan Poltekkes Tasikmalaya Tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan S3 Doktor Ilmu Kedokteran Kesehatan pada Universitas Dipenogoro lulus tahun 2022 . Riwayat pekerjaan diawali

pada tahun 1988 menjadi Perawat di RS Pelabuhan, kemudian Tahun 1990 menjadi Bidan Puskesmas Nyalindung Sukabumi, selanjutnya menjadi bidan di beberapa Puskesmas Kota Cirebon hingga tahun 2010. Saat ini penulis bekerja menjadi dosen di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Kampus Cirebon . Beberapa pengalaman diantaranya menjadi Reviewer nasional versi Simlitabkes, menjadi Ketua IBI Kota Cirebon Periode 2018-2023 dan menjadi Ketua Program Studi STR Kebidanan Cirebon, mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan, Asuhan Kebidanan Neonatal, Bayi, Balita dan Pra Sekolah, Soft Skill, Biokimia, nulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Menjadi Narasumber Seminar Nasional dan Internasional. . Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yfitrianingsih44@gmail.com

Motto: "Knowledge from Practice, Excellence for Humanity."

SINOPSIS

Bunga rampai ini menghadirkan kumpulan tulisan reflektif dan ilmiah yang menggambarkan dinamika pengalaman praktik tenaga kesehatan dalam berbagai setting pelayanan kesehatan. Buku ini menjadi ruang berbagi pengalaman nyata, pembelajaran kontekstual, serta refleksi kritis yang lahir dari interaksi langsung dengan pasien, keluarga, komunitas, dan sistem pelayanan kesehatan. Melalui pendekatan naratif dan analitis, setiap bab menyajikan potret praktik profesional yang sarat makna serta kontribusinya terhadap pengembangan kompetensi tenaga kesehatan.

Chapter 1: Pengalaman Praktik Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan mengulas berbagai pengalaman lapangan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Bab ini menyoroti tantangan, inovasi, kolaborasi interprofesional, serta dinamika komunikasi dengan pasien dan tim kesehatan dalam berbagai fasilitas layanan, baik di tingkat primer maupun rujukan.

Chapter 2: Pembelajaran dari Praktik Kebidanan di Layanan Kesehatan memaparkan pengalaman praktik kebidanan yang berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Bab ini menggambarkan pembelajaran klinis, pengambilan keputusan berbasis bukti, pendampingan persalinan, serta upaya peningkatan keselamatan ibu dan bayi. Refleksi yang disajikan memperlihatkan pentingnya empati, keterampilan klinis, dan kolaborasi dalam praktik kebidanan.

Chapter 3: Pengalaman Praktik Gizi dalam Pelayanan Kesehatan membahas peran tenaga gizi dalam menangani masalah gizi individu dan masyarakat. Berbagai pengalaman praktik di fasilitas kesehatan dan komunitas menunjukkan pentingnya asesmen gizi, intervensi berbasis kebutuhan, edukasi, serta strategi perubahan perilaku untuk meningkatkan status kesehatan pasien dan masyarakat.

Chapter 4: Refleksi Etika dan Profesionalisme dalam Praktik Kesehatan mengangkat dimensi etika, tanggung jawab profesional, serta nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan. Bab ini menelaah dilema etis yang sering muncul di lapangan, pentingnya integritas, komunikasi efektif, serta komitmen terhadap standar profesi dan keselamatan pasien.

Chapter 5: Implikasi Pengalaman Praktik terhadap Pengembangan Pendidikan Kesehatan membahas bagaimana pengalaman praktik menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, serta peningkatan kompetensi mahasiswa tenaga kesehatan. Bab ini menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) untuk

menghasilkan tenaga kesehatan yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini tidak hanya menjadi dokumentasi pengalaman praktik, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam penguatan mutu pelayanan dan pendidikan kesehatan. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Bunga rampai ini menghadirkan kumpulan tulisan reflektif dan ilmiah yang menggambarkan dinamika pengalaman praktik tenaga kesehatan dalam berbagai setting pelayanan kesehatan. Buku ini menjadi ruang berbagi pengalaman nyata, pembelajaran kontekstual, serta refleksi kritis yang lahir dari interaksi langsung dengan pasien, keluarga, komunitas, dan sistem pelayanan kesehatan. Melalui pendekatan naratif dan analitis, setiap bab menyajikan potret praktik profesional yang sarat makna serta kontribusinya terhadap pengembangan kompetensi tenaga kesehatan.

Chapter 1: Pengalaman Praktik Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan mengulas berbagai pengalaman lapangan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Bab ini menyoroti tantangan, inovasi, kolaborasi interprofesional, serta dinamika komunikasi dengan pasien dan tim kesehatan dalam berbagai fasilitas layanan, baik di tingkat primer maupun rujukan.

Chapter 2: Pembelajaran dari Praktik Kebidanan di Layanan Kesehatan memaparkan pengalaman praktik kebidanan yang berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak. Bab ini menggambarkan pembelajaran klinis, pengambilan keputusan berbasis bukti, pendampingan persalinan, serta upaya peningkatan keselamatan ibu dan bayi. Refleksi yang disajikan memperlihatkan pentingnya empati, keterampilan klinis, dan kolaborasi dalam praktik kebidanan.

Chapter 3: Pengalaman Praktik Gizi dalam Pelayanan Kesehatan membahas peran tenaga gizi dalam menangani masalah gizi individu dan masyarakat. Berbagai pengalaman praktik di fasilitas kesehatan dan komunitas menunjukkan pentingnya asesmen gizi, intervensi berbasis kebutuhan, edukasi, serta strategi perubahan perilaku untuk meningkatkan status kesehatan pasien dan masyarakat.

Chapter 4: Refleksi Etika dan Profesionalisme dalam Praktik Kesehatan mengangkat dimensi etika, tanggung jawab profesional, serta nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan kesehatan. Bab ini menelaah dilema etis yang sering muncul di lapangan, pentingnya integritas, komunikasi efektif, serta komitmen terhadap standar profesi dan keselamatan pasien.

Chapter 5: Implikasi Pengalaman Praktik terhadap Pengembangan Pendidikan Kesehatan membahas bagaimana pengalaman praktik menjadi landasan penting dalam pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, serta peningkatan kompetensi mahasiswa tenaga kesehatan. Bab ini menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang adaptif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, bunga rampai ini tidak hanya menjadi dokumentasi pengalaman praktik, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam penguatan mutu pelayanan dan pendidikan kesehatan. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

ISBN 978-634-7556-77-6



9

786347

556776

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

